

Manual Gestor de Demanda de Primer Nivel 061 Salut Respon

Formació i Qualitat
Serveo Servicios - Servei SEM

Històric de canvis

Versió	Data	Modificació	Pàgines
1	Setembre 2020		
2	Febrer 2020	5.3.4.2 Alerta passarel.la SEM-112 5.3.5 Alertant indirecte 5.3.6 Alertant Banc de Sang i Teixits (BST) 5.4 Localitzacions 5.6.3.2 Dolor 5.6.3.8 Mal definits / altres 5.6.3.9 Ginecologia / obstetrícia 5.6.6 Consultoria ICO 24 hores 5.6.6.1 Sol·licitud de transport sanitari a través del servei ICO 24 hores 5.7.2 Trucada transferida a personal sanitari 5.8.4 Trucades d'anul·lació incidents actius 5.8.8 Trucades amb demanda d'una ambulància efectuada per un alertant professional sanitari no hospitalari 5.8.10 Procediment Atenció Residents amb suport Consultoria geriàtrica 5.8.14.1 Accions específiques del gestor de demanda de primer nivell d'interhospitalari 5.8.15 Trucades amb demanda d'un trasllat extracomunitari 5.8.19.2.2.1 Desplegable campanya administrativa 5.8.19.2.2.2 Traduccions 5.8.19.3.1 Passar la trucada a consulta administrativa 5.8.19.3.2 Passar la trucada a Consultoria Sanitària 5.9.3 Extensions diferents sales 6 Glossari	20, 29, 30, 48, 52, 54, 59, 61, 62, 68, 75, 83, 90, 95, 110, 117, 118, 121, 136
3	Maig 2021	5.8.22 Servei preventiu TEDAX 5.6.3.8 Mal definits / altres	100, 52
4	Juny 2021	5.6.1 Accident/traumatisme	41
5	Juliol 2021	5.6.2 Malaltia lloc públic	45
6	Agost 2021	5.4.6 Teleassistència 5.3.7 Guió Alertant MMEE, PL, BB, GU, GUB 5.9.3 Extensions diferents sales	29, 127, 140
7	Octubre 2021	5.6.2 Accident/Traumatisme: Implementació botó Sospita Violència Sexual a la pantalla Accident/Traumatisme 5.8.17 Trucades d'idiomes 5.9.3 Zones i extensions diferents sales 5.12.9 Transferències específiques Sala Reus	39, 95, 124, 138
8	Novembre 2021	5.1 Entrada a SITREM 5.12.9 Transferències específiques Sala Reus	7, 137
9	Febrer 2022	5.7.1 Accident/Traumatisme (figura patinet) 5.9.10 Procediment Atenció Residents amb suport Consultoria Fragilitat 5.9.14 Trucades amb demanda d'un trasllat interhospitalari 5.9.24 Prestació d'Ajudar a Morir (PRAM) 5.13.2 Reclamacions	37, 79, 85, 95, 128
10	Abril 2022	5.9.24 Prestació D'Ajuda a Morir (PRAM) 5.13.1 Transferències específiques Sala Reus	95, 128
11	Maig 2022	5.7.3.1 Alteracions Neurològiques	48
12	Juny 2022	5.7.3 Malaltia Lloc Públic (ESMES) 5.7.4.7 Alteracions psiquiàtriques 5.9.28.1.3.6 Cribratge càncer	41, 49, 111
13	Agost 2022	5.9.14 Trucades amb demanda d'un trasllat interhospitalari	81
14	Setembre 2022	5.7.3 Punxades amb xeringues o similars en el context d'oci nocturn 5.9.28.1.2.10 Consell al Viatger Sanitària 5.9.28.1.3.4 Consell al Viatger 5.9.1 Trucades informatives: Sol·licitud d'informació i/o documentació clínica	38, 100, 106, 83
15	Novembre 2022	5.10.3 Zones i Extensions diferents sales	118

16	Gener 2023	5.1 Entrada a Sitrem 5.7.1 Accident/Traumatisme 5.7.2 Malaltia lloc públic	8, 36, 40
17	Gener 2023	5.9.10 Procediment Atenció Residents amb suport Consultoria Fragilitat	92
18	Febrer 2023	5.7.7. ICO Consultoria ICO 24 hores 5.9.14.1. Trucades amb demanda d'un trasllat interhospitalari	76, 103
19	Abril 2023	5.4.1.1. Demanda per part de la Divisió d'Escortes de la Policia de la Generalitat 5.7.2. Malaltia al lloc públic 5.7.3. Malaltia a domicili 5.9.14.1. Trucades amb demanda d'un trasllat interhospitalari 5.9.16. Consulta Especialista	12, 42, 46, 101, 107
20	Abril 2023	3. Definicions	7
21	Abril 2023	5.7.4.1. Consulta sanitària (requadre esquerre)	58
22	Abril 2023	5.7.4.1. Consulta sanitària (requadre esquerre) Rectificació SUVEC	66
23	Juliol 2023	5.2 Recepció Inicial: Obligatorietat de identificació professional 5.7.4.1. Consulta Sanitària (requadre esquerre) Rectificació SUVEC 5.7.4.2. Consulta Administrativa (requadre dret) Rectificació Consell al Viatger 5.9.6.2.4. Reclamació d'alertant qualificat 5.9.27.1.1. Passar la trucada a Consulta Administrativa 8 ANNEXOS: Guia bones pràctiques	9 66, 68, 88, 120
24	Agost 2023	5.9.14.1. Accions específiques del gestor de demanda de primer nivell	104
25	Setembre 2023	5.4.4 Alerta passarel·la SEM-112 5.7.3 Malaltia domicili 5.7.4.2 Consulta administrativa (requadre dret) 5.14 ACD (Atenció Continuada Domiciliària) i GCS (Guia de Centres Sanitaris)	18, 21 47, 48, 49, 70, 129,
26	Novembre 2023	5.7.3.9 Ginecologia / Obstetrícia 5.9.8 Trucades amb demanda d'una ambulància efectuada per un alertant professional sanitari no hospitalari (TSU) 5.9.8.1.1 Professional sanitari es troba amb el pacient 5.9.13.1 Trucades amb demanda d'un trasllat interhospitalari	55 90 91 102
27	Novembre 2023	5.9.4.1 Trucades d'anul·lació d'incidents actius amb recurs assignat TSNU 5.9.6.2.6 Reclamacions d'incident amb recurs assignat TSNU	84 90
28	Novembre 2023	5.9.8.3 Transport Sanitari Urgent Municipi Barcelona	98
29	Novembre 2023	5.9.8.3 Transport Sanitari Urgent Municipi Barcelona(S'elimina)	97
30	Gener 2024	5.9.8.1 Sol·licitud d'un recurs SVB: Sol·licitud Transport Sanitari en patologia respiratòria 8.2 Annexes: Guio Trucada Transport Sanitari	96 - 97 146
31	Març 2024	5.9.15.2 Consultoria ICO_ Nuevos hospitales ICO 5.14.4 Traduccions- anglès o francès entrada directe 061 5.9.13.1 Accions específiques del gestor de demanda de primer nivell - Transferència trucades relacionades amb Auxiliar de coordinació IH	110 138 106
32	Abril 2024	5.9.13 Trucades amb demanda d'un trasllat interhospitalari 7 Esquema Reclamacions Incidents	106 142
33	Juny 2024	5.5 Localitzacions. (excepció 0 ciutat Barcelona)	28
34	Juliol 2024	5.9.15 Consulta Especialista, 5.9.15.3 Suport Psicològic 5.9.13 Trucades amb demanda d'un trasllat interhospitalari	113 105
35	Juliol 2024	5.9.12 Activació Codi ICTUS/IAM detectat per un Centre Sanitari no Hospitalari o personal sanitari que es trobi amb el pacient al domicili apartat 5.9.12.1 Codi ICTUS Trasllats Judicials	103
36	Agosto 2024	Localització: Edificis emblemàtics: Punt de trobada Palau Sant Jordi 5.9.11 Trucades amb demanda d'una ambulància per trasllats judicials i trasllats involuntaris	30 102
37	Octubre 2024	5.7.2 Malaltia lloc públic Nova Etiqueta Testimoni Suïcidi Consumat 5.7.3 Malaltia domicili 5.7.3.7 Alteracions psiquiàtriques Nova Etiqueta Testimoni Suïcidi Consumat	46 54

38	Novembre 2024	5.9.14 Sol·licituds de transports sanitaris a centres d'Atenció Intermedà (ATINT)	101
39	Desembre 2024	5.4.1 Alertant VIP	11
		5.4.1.2 Alertant VIP telèfon de l'Esperança	13
40	Març 2025	5.9.2 Trucades nul·les (Procediment d'atenció de trucades malicioses)	83
		5.9.9 Trasl·lat Residències MUTUAM (Obsolet Se elimina del manual)	98
		5.7.1 Accident/traumatisme (aclariment afectats lleus, greus)	39
41	Juliol 2025	5.4.6 Atenció a les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista des del SEM indirecte	28
		Actualització en tots els camps de sala Diagonal, per Sala Gran via	Varies
		5.4.1.3 Alertant VIP HDOM hematologia H. Sant Pau	14
		5.9.4.1 Trucada d'una unitat gestor d'un adjudicatari de Transport Sanitari No Urgent (TSNU)	87
42	Octubre 2025	5.8.2 Trucada transferida a professional sanitari (afectació a les següents instruccions operatives en relació a la transferència a Cap de Guardia):	80
		5.4.1 Alertant VIP	12
		5.4.2 Columnes de rescat cardíac (CRC)	14
		5.4.4 Alerta passarel·la SEM - 112	20
		5.7.1 Accident/traumatisme	40
		5.7.5 Informació Breu	78
		5.7.6 Informació Ampla	79
		5.9.1 Trucades informatives	83
		5.9.6 Trucades de reclamació d'incidents (intervencions)	88
		5.9.15 Trucades amb demanda d'un trasllat Inter-hospitalari	105
		5.9.17 Consulta Especialista	111
		5.9.24 Centres de vacunació massiva	120
		5.13.3 Transports sanitaris	132
		5.14.1.3 ACD Alt Pirineu	135
43	Desembre 2025	5.10.1 Operativa Logat manual a la telefonia	126
		5.10.3 Zones i Extensions diferents sales	129
		5.13.1 Transferències específiques Sala Reus	132

1	Objectiu	8
2	Àmbit aplicació	8
3	Definicions	8
4	Responsabilitats	9
5	Descripció de les activitats.....	9
5.1	Entrada a SITREM.....	9
5.2	Recepció inicial.....	10
5.3	Identificació i classificació de l'alertant.....	11
5.4	Alertes específiques	12
5.4.1	Alertant VIP	12
5.4.2	Columnes de rescat cardíac (CRC)	14
5.4.3	APP	18
5.4.4	Alerta passarel·la SEM - 112	20
5.4.5	Alertant indirecte.....	28
5.5	Localització.....	29
5.5.1	Localització de l'incident a través d'unes coordenades X,Y	33
5.5.2	Punts de trobada previstos per a incidents al Port de Barcelona i Aeroport del Prat de Llobregat.....	34
5.5.3	Punts de Trobada Port de Barcelona.....	34
5.5.4	Punts de trobada Aeroport del Prat de Llobregat.....	34
5.5.5	Relacionar incidents actius	35
5.6	Dades de l'afectat.....	36
5.7	Classificació.....	39
5.7.1	Accident/traumatisme	40
5.7.2	Malaltia lloc públic	44
5.7.3	Malaltia domicili	48
5.7.4	Atenció No Presencial No Urgent	61
5.7.5	Informació Breu	78
5.7.6	Informació Ampla.....	79
5.8	Finalització trucada.....	80
5.8.1	Trucada finalitzada pel gestor de demanda de primer nivell	80
5.8.2	Trucada transferida a professional sanitari	81
5.9	Tipologia de trucades	83
5.9.1	Trucades informatives	83
5.9.2	Trucades nul·les	85

5.9.3	Noves trucades sobre incidents actius que no el modifiquen ni reclamen	86
5.9.4	Trucades d'anul·lació d'incidents actius.....	87
5.9.5	Trucades de modificació d'incidents actius	89
5.9.6	Trucades de reclamació d'incidents (intervencions).....	90
5.9.7	Trucades emeses pel gestor de demanda de Primer Nivell	96
5.9.8	Trucades amb demanda d'una ambulància efectuada per un alertant professional sanitari no hospitalari (TSU).....	97
5.9.9	Trasllat Residències MUTUAM: Obsolet eliminat.....	102
5.9.10	Procediment Atenció Residents amb suport Consultoria Fragilitat.....	102
5.9.11	Trucades amb demanda d'una ambulància per trasllats judicials i trasllats involuntaris	103
5.9.12	Activació Codi ICTUS/IAM detectat per un Centre Sanitari no Hospitalari o personal sanitari que es trobi amb el pacient al domicili.....	104
5.9.13	Gestió de demandes de transport des de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya.....	104
5.9.14	Sol·licituds de transports sanitaris a centres d'Atenció Intermèdia (ATINT)	105
5.9.15	Trucades amb demanda d'un trasllat Inter-hospitalari.....	106
5.9.16	Trucades amb demanda d'un trasllat extracomunitari.....	113
5.9.17	Consulta Especialista	113
5.9.18	Trucades d'idiomes.....	118
5.9.19	Servei d'interpretació de llengua de signes.....	119
5.9.20	Incidències concretes Atenció Primària	120
5.9.21	Alertant Banc de Sang i Teixits (BST).....	120
5.9.22	Centres de Reducció de Danys (CAS).....	121
5.9.23	Servei preventiu TEDAX.....	121
5.9.24	Centres de vacunació massiva	122
5.9.25	Prestació d'Ajudar a Morir (PRAM)	122
5.9.26	Teleassistència (TASS)	124
5.9.27	Guió alertant MMEE, PL, BB, GU, GUB:.....	125
5.9.26	Operativa de traspàs de trucades a segon nivell i consultoria	125
5.9.26.1	Passar la trucada a consulta administrativa	125
5.9.26.1.1	Passar la trucada a Consultoria Sanitària	126
5.9.26.1.2	Trucades on es selecciona Traduccions	127
5.10	Sales en situació de caiguda de SITREM.....	127
5.10.1	Operativa Logat manual a la telefonia	127

5.10.2	Recollida de dades	128
5.10.3	Zones i Extensions diferents sales.....	129
5.11	Situació de caiguda barra de telefonia	132
5.12	Situacions extraordinàries	132
5.13	Procediments específics Sala Operativa Sanitària de Reus	133
5.13.1	Transferències específiques Sala Reus.....	133
5.13.2	Reclamacions	134
5.13.3	Transports sanitaris	135
5.13.4	Modificació d'adreça per veu: adreça validada per 112	136
5.13.5	Obertura de porta	137
5.14	ACD (Atenció Continuada Domiciliaria) i GCS (Guia de Centres Sanitaris) 137	
5.14.2	Operativa Franja d'Aragó.....	141
5.14.3	112: Modificació Adreça per veu.....	142
5.14.4	Traduccions.....	142
6	Glossari	142
7	Esquema Reclamacions Incidents:	144
8	Abreviatures més freqüents	147
9	ANNEXOS	150
9.1	Annex– Guia de bones pràctiques per a gestor/a d'emergència	150
9.2	GUIÓ GENERAL DE TRUCADES:	151

1 Objectiu

Aquest manual té com a objectiu definir la metodologia a seguir al Centre Coordinador Sanitari (CECOS), per al tractament de les alertes dels **usuaris** que requereixin alguns dels serveis oferts per l'organització.

2 Àmbit aplicació

Sala Operativa Sanitària d'Hospitalet, Sala Operativa Sanitària de Gran Via Barcelona i Sala Operativa Sanitària de Reus.

3 Definicions

AFECTAT, AFECTADA: persona que té o és susceptible de patir una urgència, problema o dubte sanitari, receptora de l'atenció, consell o informació sanitària.

ALERTA: demanda assistencial/informativa que serà gestionada pel centre coordinador sanitari.

ALERTANT: persona particular o que pertany a un organisme que contacta amb el centre coordinador per comunicar una necessitat sanitària assistencial o informativa, real o percebuda, pròpia o d'una tercera persona.

CENTRE COORDINADOR SANITARI (CECOS): és l'element del sistema sanitari extra-hospitalari al qual el client pot accedir (multicanal) per realitzar una demanda de salut al sistema. Té com a funció la recepció d'alertes, la seva gestió i l'adjudicació d'una resposta a cada una d'aquestes. Engloba la demanda assistencial urgent, no urgent i informació sanitària.

CONFIDENCIABILITAT: l'empresa proveïdora i per extensió el seu personal es compromet al compliment de la legalitat vigent en relació amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades. L'accés al programari de treball del CECOS es realitza mitjançant login i password que són personals i intransferibles per cadascun dels gestors de demanda de primer i segon nivell.

GESTOR DE DEMANDA DE PRIMER NIVELL: és el professional no sanitari encarregat de rebre les trucades d'alerta, localitzar-les, identificar la seva tipologia i recollir la informació mínima per ser classificades en funció de la seva gravetat inicial mitjançant un programari informàtic.

GESTOR DE DEMANDA DE SEGON NIVELL: és el professional no sanitari encarregat de gestionar les consultes administratives de la pantalla "**Atenció No Presencial No Urgent**" que li son transferides pels gestors de demanda de primer nivell.

INCIDENT: registre de la situació provocada per una alerta rebuda envers una situació de demanda sanitària/informativa o de gestió administrativa. Un incident té com a mínim un afectat fins un màxim de "X" i pot tenir de 0 a "X" intervencions.

INTERVENCIÓ: resposta davant un incident que implica l'assignació de recursos propis o aliens. Cada recurs assignat suposa una intervenció.

REBUIG DE PROTOCOL: son aquells incidents en que el alertant no està conforme amb la resposta donada pel protocol de primer nivell i indicada pel gestor de demanda. En aquest cas, la trucada es passa sempre a valorar a personal sanitari.

4 Responsabilitats

Execució: Gestor de demanda de primer nivell i els seus coordinadors.

Supervisió: coordinador d' l'empresa proveïdora, Auxiliar Coordinació/Coordinador Operatiu.

5 Descripció de les activitats

5.1 Entrada a SITREM

LLENGUA VEHICULAR: el català s'ha d'utilitzar com a llengua vehicular al servei, tant de forma escrita com oral; exceptuant aquests casos on l'usuari o la alertant ens parlin en una altre llengua. En aquells moments és on farem el canvi d'idioma oral.

A l'inici de la jornada, l'aplicatiu per recollir trucades sempre serà SITREM. Per tenir accés a aquesta eina, introduïrem les nostres dades (LOGUIN – CONTRASENYA) per poder accedir i, a continuació, l'aplicatiu ens demanarà de quina forma volem fer ús de SITREM. En el cas de gestors de primer nivell sempre serà Gestor Demanda + SUVEC.

9.41.4.0 SITREM™

Benvinguts a l'aplicació

**Generalitat de Catalunya
Departament de Salut**

061 SALUT RESPON

Introdueixi el nom d'usuari

Introdueixi la seva clau personal

Avís: D'acord amb la normativa sanitària i de protecció de dades, únicament podeu accedir a aquella informació de Sitrem necessària per a les finalitats pròpies del vostre perfil. L'ús i accés a informació de pacients amb altres finalitats diferents de les que teniu atribuïdes no està permesa i pot comportar responsabilitats civils, penals i/o administratives.

Finalitzar **Continuar**

Habilitats Telefòniques

Seleccioni la Funció

Desar Sortir

Funció
Gestor Demanda
Gestor Demanda Anglès
Gestor Demanda Francès
Gestor Demanda Anglès i Francès
Gestor Demanda IH
Gestor Demanda ICO
Gestor Demanda IH i ICO
Gestor Demanda II
Treball Administratiu / Emissió Trucades

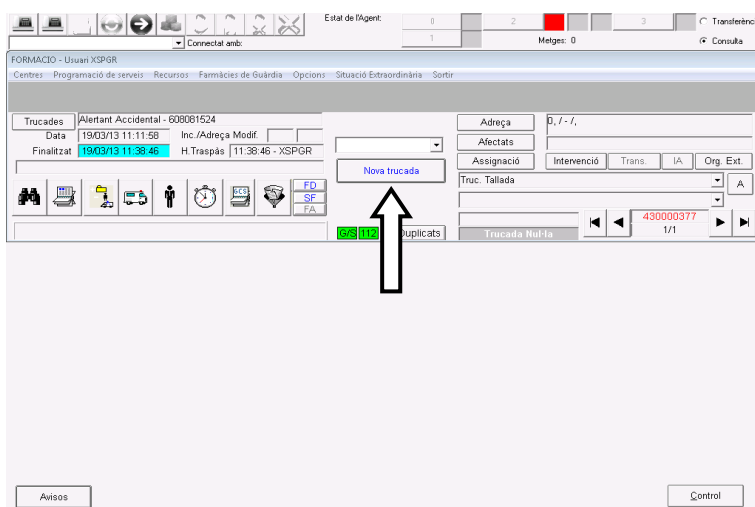
5.2 Recepció inicial

L'entrada de l'alerta es realitza de manera automàtica. Simultàniament el gestor de demanda de primer nivell escolta a el alertant i apareix al monitor la carta de 'Nova Trucada'.

De forma manual també es pot accedir a la carta de 'Nova Trucada' prement a la pantalla inicial el botó de **"Nova Trucada"**.

La fórmula de presentació segons via d'entrada de la demanda és:

- Origen alerta 112 fórmula: *"061 digui'm"*
- Origen alerta 061 fórmula:
 - o De 06-12 h: *"Bon dia, l'atén ... (nom del gestor), en què el puc ajudar?"*
 - o De 12-20 h: *"Bona tarda, l'atén ... (nom del gestor), en què el puc ajudar?"*
 - o De 20-06 h: *"Bona nit, l'atén ... (nom del gestor), en què el puc ajudar?"*
- Origen alerta ICO 24h: *"ICO 061 l'atén... (nom del gestor), en què el puc ajudar?"*
- Origen alerta APP: *"Bon dia - Bona tarda - Bona nit, l'atén ... (nom del gestor), en què el puc ajudar?"*
- Origen interhospitalaris 902335033: *"Interhospitalaris SEM, Bon dia - Bona tarda - Bona nit."*
- Origen alerta CRC: *"061 digui'm"*



De acord amb el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública obliga a que quan un ciutadà al que s'atengui telefònicament sol·liciti expressament la identificació del professional, és obligatori identificar-se amb el nom, cognoms i categoria professional o càrrec, i facilitar-li -si li demanen- les dades professionals.

Identificació personal SERVEO a requeriment afectat/alertant: El professional que atén al ciutadà pot facilitar dos tipus d'informació:

- Dades individuals: Dades que permeten identificar al professional.
- Dades empresarials: Dades que permeten al ciutadà comunicar-se amb l'Entitat que li ha donat servei.

Identificació Individual		Dades empresarials
Nom Cognom1 Cognom2	- Gestor de Demanda - Gestor de Recursos - Gestor Administratiu - Coordinador - Supervisor	Carrer Pablo Iglesias, 101-115 08908 L'Hospitalet de Llobregat 93 264 44 00 uac.sem@gencat.cat

Aquesta informació caldrà donar-la quan el ciutadà ho sol·liciti **expressament**, si no és així s'ha de seguir el que s'indica:

Exemple:

Alertant: Com es diu vostè? / Com et dius? / Quin és el teu nom complet?

Professional: Soc Josep Garcia Suárez, gestor de demanda / gestor administratiu / gestor de recursos / coordinador / supervisor.

Alertant: On treballes? / Quines són les teves dades de contacte?

Professional: Carrer Pablo Iglesias, 101-115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat. 93 264 44 00. uac.sem@gencat.cat

5.3 Identificació i classificació de l'alertant

Per accedir a les dades de l'alertant, s'ha de seleccionar primer un tipus de alertant, utilitzant el desplegable. Si es coneix el codi de l'opció que interessa es pot teclejar a la caixa de text que hi ha a l'esquerra, per exemple escrivint **"32"** i, automàticament, apareix en el desplegable l'opció alertant **"Entorn afectat"**.

La selecció d'un tipus d'alertant és **obligatòria** i s'ha de realitzar en primer lloc, ja que la resta d'objectes de la pantalla estan inhabilitats mentre no es registri aquest.

Si l'alertant és un centre sanitari cal anotar el nom del metge que truca; es pot fer prement el botó amb la **"M"**. Aquesta dada es guarda a la pantalla de transport sanitari (TSU o secundari) que s'explica més endavant.

Al seleccionar el botó **"Alertant"**, s'obre la pantalla corresponent amb la possibilitat d'omplir les dades de l'alertant.

Sota el botó **"Alertant"** hi ha una casella de verificació titulada **"Adreça a Afectat"** que per defecte vincula l'adreça registrada a l'incident com adreça particular de l'afectat i, al prémer al damunt, la desvincula. S'ha de ser curós en mantenir aquets vincle sols quan existeix (adreça incident correspon a l'adreça particular de l'afectat).

El número de telèfon de l'alertant queda registrat automàticament al camp esmentat. Tot i així, s'ha de confirmar sempre.

En el cas en que no quedi registrat el telèfon de forma automàtica o siguin registres no compatibles amb un número de telèfon convencional, el gestor de demanda de primer nivell ha de sol·licitar el número real a l'alertant mitjançant la pregunta:

"Si us plau, em pot facilitar el seu telèfon de contacte?"

En aquest cas quan el telèfon sigui de l'afectat cal enregistrar-lo al camp: "Tel. Afectat".

Si es tracta d'alertants que no estan amb l'afectat i, en el cas que el telèfon confirmat de l'alertant no correspongui al d'entrada de l'aplicació, cal fer constar el número facilitat al

camp “A” (No s’ha d’anotar al complement d’adreça. En casos de telèfons de Tele-Assistència, Policia Local, Mossos d’Esquadra i altres centraletes d’alarmes, sempre s’escriuran al camp ‘A’).

En el cas que l’alertant no estigui amb l’afectat, cal sol·licitar el número de telèfon d’aquest últim mitjançant la pregunta:

“Si us plau, em pot facilitar el telèfon d’on es troba l’afectat?”

El número facilitat cal enregistrar-lo al camp: **“Tel. Afectat”**.

El botó **“Telèfon”** permet comprovar si ja ha estat registrat el número a la base de dades del programa. Si és així, s’obrirà una pantalla que recull les dades de totes les persones i/o adreces que corresponen a aquest número de telèfon. Si es vol obtenir les dades d’un d’ells s’haurà de seleccionar prèviament situant el cursor sobre alguns dels seus camps i fer clic. Després s’ha de seleccionar entre les següents opcions: **“Acceptar nom i adreça”**, **“Acceptar adreça”** o **“Cancel·lar”** que equival a no acceptar res.

Per a que un telèfon es guardi en la base de dades d’usuaris és necessari que s’anoti el nom i els cognoms de l’afectat i que el telèfon correspongui a **“Alertant-incident”**.

Aquesta eina es pot utilitzar, però hem de comprovar que són les mateixes dades que l’alertant ens facilita (no ha d’afectar al guió de la trucada).

En el cas que truquin des de un centre sanitari (Hospital, CAP, SOSA, ...) o truqui MMEE caldrà sol·licitar extensió telefònica directa (si en té) i anotar-la en el camp de Complement.

A la part superior dreta es pot escollir tres casos excloents entre ells: **“Alertant”**, **“Alertant-incident”** o **“Incident”**. Aquest tres casos fan referència al número de telèfon que facilita l’usuari:

- **“Alertant”**: el telèfon correspon només a la persona o institució que truca (Ex. Guàrdia Urbana, algú que truca des del seu mòbil per un accident, etc.).
- **“Alertant-incident”**: el telèfon correspon al del domicili de l’alertant que és, també, l’adreça de l’incident (Ex. si algú truca des del seu domicili perquè està malalt o alguns dels seus familiars ho està).
- **“Incident”**: el telèfon correspon al lloc de l’incident (Ex. una malaltia en una discoteca, en la qual l’alertant avisa des del seu mòbil, però facilita el número de la discoteca).

5.4 Alertes específiques

5.4.1 Alertant VIP

El programa permet identificar un usuari mitjançant el telèfon de la trucada entrant assignant automàticament el tipus d’ alertant.

La versió actual inclou el tipus d’ alertant “Alertant VIP” i s’activa automàticament quan entra una trucada procedent d’uns telèfons prèviament fixats.

En el moment que entra aquesta trucada, el Gestor de demanda veurà que s'omplen totes les dades: telèfon, localització i nom. Sempre, però, s'ha de confirmar que l'adreça sigui correcta.

Al complement d'adreça o al camp 'A' surten missatges o indicacions a fer en cada cas, a banda de les indicacions donades per la classificació de l'incident.

També, les instruccions es poden consultar seleccionant el botó:



Hem de seguir, rigorosament, les instruccions i caldrà informar o bé, transferir la trucada a qui correspongui segons les instruccions donades.

D'altra banda, aquest alertant ("Alertant VIP") figura inclòs en el comboi d'alertants

5.4.1.1 Demanda per part de la Divisió d'Escortes de la Policia de la Generalitat

L'operativa és davant d'una petició per part de la Divisió d'Escortes de la Policia de la Generalitat (PG-ME) en cas d'emergència mèdica greu d'una personalitat VIP del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, així com de l'àmbit institucional; l'operativa serà la següent:

Petició del servei

La demanda entrarà pel telèfon de 061 des del mòbil de treball operatiu assignat a l'escorta de la personalitat VIP. L'escorta s'identificarà con a alertant VIP + indicatiu (Per exemple: GOV, EXGOV, INST, USO...) donant la localització actual.

Accions a realitzar pel Gestor/a de Primer Nivel:

- Localització de l'incident (demanar l'adreça exacta, ja que per defecte surt "Palau de la Generalitat Plaça Sant Jaume nº 0").
- Validació de les dades personals.
- Tipus de demanda (classificació OMEGA).
- Derivació de la trucada a Cap de Torn del territori on s'ha produït l'incident. En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn** (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a

20h). De 20h a 8h la transferència es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

5.4.1.2 Alertant VIP telèfon de l'Esperança

Quan es rebí una alerta del telèfon de l'Esperança s'activarà automàticament "Alertant VIP".

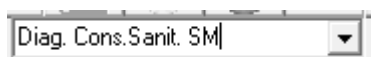
Aquestes trucades les realitzarà un voluntari del telèfon de l'esperança i li haurem de demanar les següent dades de l'afectat:

Nom

Adreça: Cal substituir inicial carregada a Sitrem c/Pablo Iglesias 101 per l'adreça de l'afectat.

Telèfon del afectat: s'anotarà en el Camp A

Classificarem segons simptomatologia i s'haurà de transferir la trucada directament a la Taula de Salut Mental mitjançant combo.



Es important **no deixar en cua** i haure d'esperar a transferir a personal sanitari. Si després d'un temps prudencial no podem transferir la trucada consultarem a l'equip de coordinació SERVEO.

5.4.1.3 Alertant VIP HDOM hematologia H. Sant Pau

Ens pot entrar una alerta VIP des del servei de HDOM hematologia H. Sant Pau sempre ei quant es detecti una patologia urgent.

S'identificarà com a HDOM hematologia H. Sant Pau informant del nom i perfil professional. Indicaràn filiació, telèfon i localització del afectat.

ACCIONS: Gestora/Gestor de Demanda:

- Si HDOM hematologia H. Sant Pau truca des dels telèfons facilitats el Sitrem detectarà automàticament **el tipus d'alerta i l'inclou a Alertant VIP**.
- **VIP:** text "Hospitalització domiciliaria hematologia H. Sant Pau, passar la trucada a valoració personal sanitari, CT Barcelona".

Es traspasarà la trucada a CT BCN per tal de consensuar amb el metge HDOM tipus de recurs.

5.4.2 Columnes de rescat cardíac (CRC)

Sota el botó del telèfon es troba el botó "**CRC**". Una columna de rescat cardíac és una torre vertical que acull en el seu interior un desfibril·lador semiautomàtic o automàtic (DEA - DESA). Aquestes columnes estan ubicades en llocs públics amb l'objectiu de poder atendre al més aviat possible a les persones que pateixen una aturada cardíaca.

Cada una d'aquestes columnes té el seu propi número de telèfon, de manera que, es pot emetre una trucada automàtica des d'aquestes columnes per avisar d'una emergència mèdica d'aquestes característiques (aturada cardíaca).

Quan un desfibril·lador es treu de la columna, aquesta llança una trucada que entra al CECOS del SEM (aquesta situació sols es dona en les CRC vinculades al programari de SEM).

Al gestor de demanda de primer nivell li entra una trucada i al despenjar surt automàticament la pantalla de carta de trucada amb les dades de la columna **sense necessitat de prémer cap botó**.

Nova trucada

Alertant: 95 Alertant CRC M Telèfon: 933211804

Adreça a Afectat: ☒ Adreça a Afectat

Municipi: Barcelona Comarca: Barcelonès Província: BARCELONA

Barri: Les Corts Barri: Les Corts

Adreça: CRC/CRC WINTERTHUR IBERICA, S.A. A H C E X Nº: 575

Complement: Ed. Illa Diagonal, Av Diagonal, 575. Planta segona. Zona Atenció Client

ABS: BCN L-2 4b CAP Montnegre Zonas:

Nom i Cognoms: CRC WINTERTHUR EDIFICIO ILLA DIAGONAL

Edat: D Sexe: D.N.I. C.I.P. Tel.Afectat: 933211804

Codi: 7438 CRC

S'activa el botó CRC automàticament

Incidents que poden estar relacionats:

Municipi	Adreça	Comp.Adreça	C.Incident	Afectat	Tipus Demanda	SubM1
Alella	CRC CRC AJUNTAMENT D'ALELLA	Polícia Municipal,	30000505	CRC AJUNT.ALELLA POL	MALALTIA LLOC f Alella	
Alella	CRC CRC AJUNTAMENT D'ALELLA	Polícia Municipal,	30000494	CRC AJUNT.ALELLA POL	MALALTIA LLOC f Alella	
Barcelona	CRC CRC COM.CENTRO COMERCIAL GLC	C. C. GLORIES, Av,	30000481	CRC COM.PROP. GLORIE	MALALTIA LLOC f Poblenou	
Barcelona	CRC CRC WINTERTHUR IBERICA, S.A.	Ed. Illa Diagonal, /	30000475	CRC WINTERTHUR EDIFI	MALALTIA LLOC f Les Corts	

Incident preparat per passar a pantalla de Protocols

Crear nou incident No crear nou incident Reclamació Anul·lar incident Modificar incident Trucada nul·la

En el monitor de l'esquerra apareix una pantalla de color taronja amb el següent missatge:

“ATURADA CARDIO RESPIRATÒRIA. DESFIBRIL·LADOR ACTIVAT. CRC”

“AVISI AL COORDINADOR”

Aquesta pantalla s'alterna amb la del cartogràfic del SITREM.

El Gestor de demanda s'ha de presentar: **“061 diguin?”** (No cal confirmar el telèfon, ja que és una trucada automàtica i l'alertant el desconeix).

Si cal confirmar SEMPRE:

- L'activació d'un desfibril·lador PER UNA SOSPITA D'ATURADA CARDÍACA.
- El municipi
- Si l'afectat està a la mateixa adreça de la columna.

Opció 1: el programa SITREM és capaç de reconèixer automàticament la columna que està trucant i la seva ubicació a partir del número de telèfon de l'alertant – CRC (sempre i quan l'alerta procedeixi de la CRC), ja que el programa SITREM té emmagatzemada la següent informació per a cada columna:

- Número de telèfon de la CRC (alertant), origen de la trucada.
- Número identificació de la CRC.
- Adreça (província, municipi, carrer, número de carrer, ABS, etc.).
- Posició GPS per situar-la a la cartografia.
- Descripció d'ubicació genèrica de la CRC; per exemple, Ajuntament de Begur...
- Telèfon de contacte d'un responsable d'aquesta CRC, generalment, el telèfon de mossos del municipi.

L'incident queda localitzat **sense necessitat de prémer el botó “Z”** per localitzar, així l'ABS, l'hospital de referència, etc. queden directament identificats a l'incident.

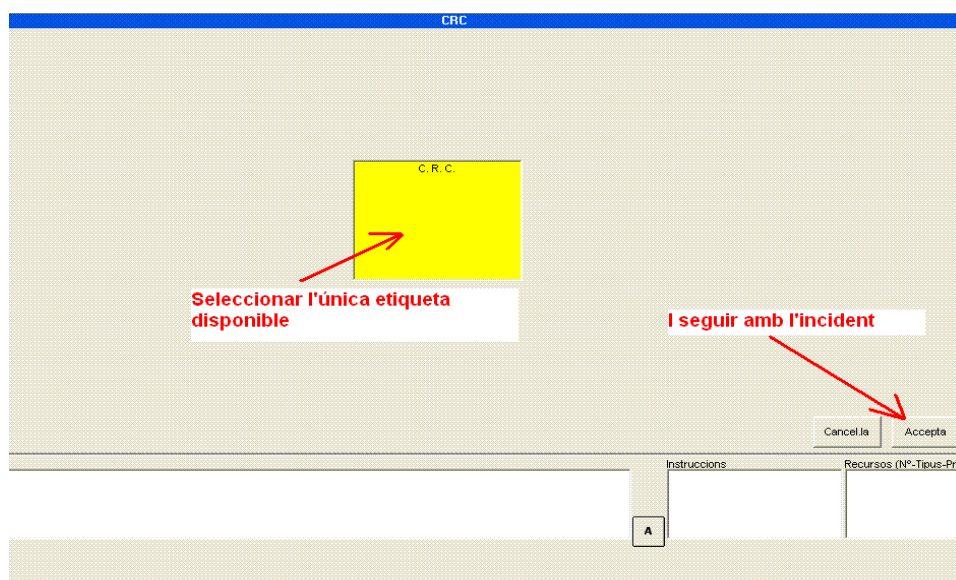
Si l'usuari vol visualitzar la ubicació de l'incident a la pantalla de cartografia, pot utilitzar el botó habitual **“la bola del món”**.

Opció 2: si l'afectat està en **una altra adreça diferent** a la de la columna (CRC), s'ha d'agafar el carrer, número, pis i el telèfon de l'alertant i s'ha d'apuntar al complement d'adreça. El gestor de demanda de primer nivell ha d'avisar al seu coordinador, per tal que aquest avisi al Coordinador Tècnic/Infermer Consultor o a l'Auxiliar de Coordinació/Coordinador Operatiu en la seva absència.

L'incident queda preparat perquè l'usuari segueixi amb el protocol corresponent.

S'ha creat un nou tipus de demanda específic per al tractament de les CRC. Aquest tipus de demanada és el **“CRC”**.

En ambdós casos, el gestor de demanda de primer nivell ha de prémer el botó de **“Crear nou incident”** com a qualsevol altre incident. El programa SITREM li mostra la pantalla de l'Omega corresponent:



Un cop acceptat el protocol, cal que el gestor de demanda avisi/truqui al Coordinador Tècnic/Infermer Consultor o a l'Auxiliar de Coordinació/Coordinació o al Cap de Torn de la zona que correspongui que ha entrat una alerta de CRC i li digui el número d'incident. En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn** (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 08h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

Cal tenir en compte que la columna CRC i el DESA donen el missatge de trucar al 112.

Quan l'alertant truqui al 112 podem trobar 2 situacions:

Si l'afectat està a la mateixa adreça de la CRC:

El 112 ens passarà l'avís amb el codi de CRC actiu, però sense la veu, el Gestor de demanda de primer nivell ha de buscar l'incident, posant el codi de CRC, ex. **“CRC0132”**.

En el camp corresponent per trobar l'incident ja creat i no en crearà un altre, només relacionarà la trucada del 112 amb l'incident automàtic fent constar al camp "A" la trucada del 112 i ha d'avisar al Coordinador Tècnic/Infermer consultor Auxiliar de Coordinació/coordinador operatiu.

Posar codi CRC seguit del número.

Municipi	Adreça	Comp. Adreça	C. Incident	Afectat	Tipus Demanda	SubM1
Barcelona	c. Muntaner, de 0		310001144		ACCIDENTS / TRA	Sarrià-Sant Gervasi
Besalú	CRC CRC0131 Ajuntament de Besalú	Plaça Llibertat, 1 -	310001143	CRC0131 Aj. de Besalú	ACCIDENTS / TRA	Besalú
Besalú	CRC CRC0132 Ajuntament de Besalú	Francisc Cambó,	310001141	CRC0132 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC CRC0131 Ajuntament de Besalú	Plaça Llibertat, 1 -	310001140	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC CRC0131 Ajuntament de Besalú	Plaça Llibertat, 1 -	310001138	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC CRC0131 Ajuntament de Besalú	Plaça Llibertat, 1 -	310001135	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú

Municipi	Adreça	Comp. Adreça	C. Incident	Afectat	Tipus Demanda	SubM1
Barcelona	c. Muntaner, de 0		310001144		ACCIDENTS / TRA	Sarrià-Sant Gervasi
Besalú	CRC CRC0131 Ajuntament de Besalú	Plaça Llibertat, 1 -	310001143	CRC0131 Aj. de Besalú	ACCIDENTS / TRA	Besalú
Besalú	CRC CRC0132 Ajuntament de Besalú	Francisc Cambó,	310001141	CRC0132 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC CRC0131 Ajuntament de Besalú	Plaça Llibertat, 1 -	310001140	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC CRC0131 Ajuntament de Besalú	Plaça Llibertat, 1 -	310001138	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC CRC0131 Ajuntament de Besalú	Plaça Llibertat, 1 -	310001135	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú

Crear nou incident **No crear nou incident** Reclamació Anul·lació Modificar incident Trucada nul·la

Aquests incidents corresponen a la mateixa zona. Determini si és un nou incident

Municipi	Adreça	Comp. Adreça	C. Incident	Afectat	Tipus Demanda	SubM1
Barcelona	c. Muntaner, de 0		310001144		ACCIDENTS / TRA	Sarrià-Sant Gervasi
Besalú	CRC		310001143	CRC0131 Aj. de Besalú	ACCIDENTS / TRA	Besalú
Besalú	CRC		310001141	CRC0132 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC		310001140	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC		310001138	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú
Besalú	CRC		310001135	CRC0131 Aj. de Besalú	CRC	Besalú

Crear nou incident **No crea incident** Reclamació Anul·lació Modificar incident Trucada nul·la

Si l'afectat no està en el mateix lloc de la CRC:

El 112 ens passarà l'avís de CRC amb el codi de columna, però amb la nova adreça, XXXXXXXXX.

Primer es localitza l'incident automàtic de la CRC. Si en el camp adreça complementària hi ha la nova localització de l'afectat no s'ha de canviar res. Si aquesta nova adreça que passa el 112 no consta, s'ha de fer una modificació i l'apuntarem a l'adreça complementària del SITREM.

CECOS amb situació de contingència i alerta de CRC:

Si el CECOS, ja sigui per una avaria o per una parada programada de SITREM, no disposa del programa informàtic, no entraran les alertes automàtiques a la pantalla.

Només es tindrà una alerta d'interfon i caldrà que la persona que ha activat el DESA faciliti el codi de columna. El Gestor de demanda demanarà el Codi de CRC.

Si entra una alerta per 112, el Gestor de demanda ha d'obrir un incident a Papyrus o paper, segons la contingència, amb el número de CRC facilitada pel 112 i ha de posar com a telèfon de l'alertant el que faciliti 112 i l'ha de classificar amb el tipus de demanda CRC.

Per localitzar l'adreça de la CRC l'empresa proveïdora de gestors de demanda disposa d'un un llistat que relaciona el codi amb l'adreça que es la que es farà constar al full de treball sense SITREM.

La resta es gestiona igual que els altres incidents.

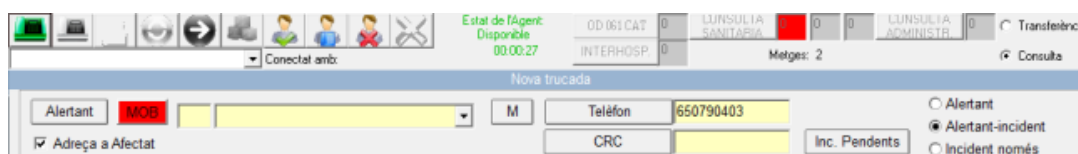
Sempre que l'alerta entri per la CRC no ens facilitaran número de telèfon, ja que no és visible ni conegut (no s'ha de demanar).

5.4.3 APP

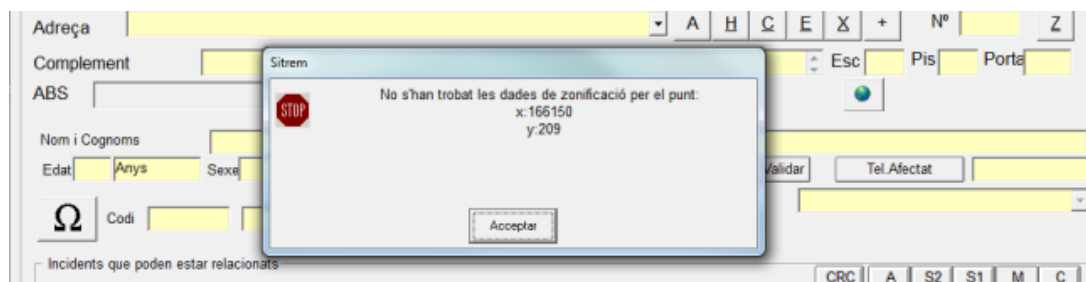
L'APP 061CatSalut Respon és una APP que, entre altres funcionalitats, permet llançar una trucada a 061 CatSalut Respon amb la seva GEO posició (si està activat el servei GPS del mòbil) i les dades de l'alertant (si aquest ha autoritzat l'enviament). En els dos casos, si no està activat el trànsit de dades del *smartphone*, sols s'emet la trucada, sense GEO posició ni dades de filiació associades.

1. Trucada emesa des de l'APP amb trànsit de dades del smartphone desactivat o sense cobertura de transmissió de dades:

Quan es realitza una alerta des de l'APP 061CatSalut Respon s'obre a SITREM la pantalla de “**nova trucada**” i s'identifica que aquesta s'està realitzant des d'un dispositiu mòbil que utilitza l'APP perquè apareix al costat del tipus alertant un rectangle amb fons vermell i les lletres “APP” ().



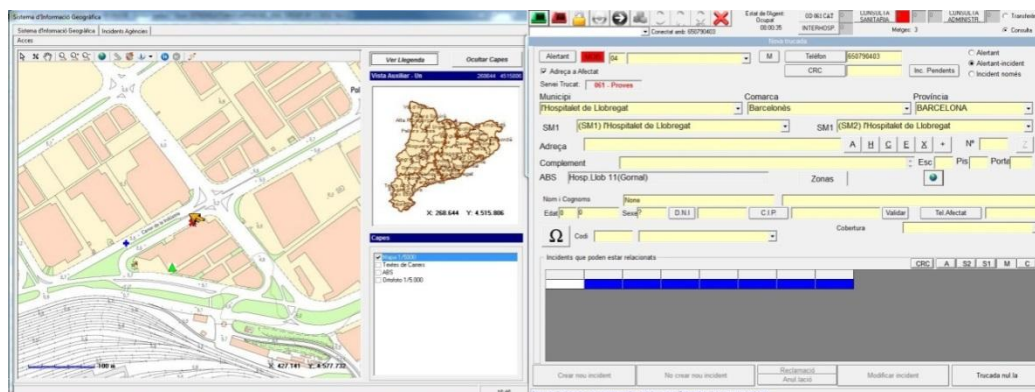
No es carrega cap dada automàticament i apareix un diàleg estàndard que indica que no s'han trobat les coordenades per GEO posicionar l'alerta.



S'ha d'acceptar el diàleg i iniciar la recollida de dades de la pantalla de nova trucada de manera habitual i continuar amb la classificació de la demanda segons la informació facilitada per l'alertant i actuar segons indicacions de SITREM.

2. Trucada emesa des de l'APP amb trànsit de dades del *smartphone* activat:

S'obre a SITREM la pantalla de “nova trucada” i s'identifica que aquesta s'està realitzant des d'un dispositiu mòbil que utilitza l'APP perquè apareix al costat del tipus alertant un rectangle amb fons vermell i les lletres “APP” (**APP**).



Missatge de benvinguda: **“Bon dia, Bona tarda, Bona nit, l’atén ..., en què el puc ajudar?”**

Confirmació del tipus d'alertant i telèfon. És important concretar si la demanda assistencial és per l'alertant o no (propri afectat o altres alertants).

De manera automàtica s'omplen les dades de província, comarca, municipi, submunicipi 1 i submunicipi 2. No es carrega el camp adreça, número, escala, porta ni pis.

S'ha de prémer el botó vermell **APP**, clicar la icona de la bola del món i el GIS posiciona a l'alertant amb una fletxa taronja.



No s'ha d'escollir cap adreça del carrer, hospitals, carreteres, edifici singular, cruïlles o signe + (**no clicar el botó A, H, C, E, X**), ni **tampoc zonificar**, ja que esborraria les coordenades de GEO posició de l'alerta de l'APP.

Un cop cliquem la bola del món, confirmarem amb l'alertant la GEO posició visualitzada al GIS. Confirmarem el municipi on es troba. Per exemple:

- en el cas d'un carrer: el carrer on es troba amb les cruïlles respectives o referències més properes.

- si es tracta d'una carretera: el nom i punt quilomètric aproximat o referència el més aproximada possible.
- si es tracta d'un hospital o d'un edifici singular: el carrer on es troba o referència més aproximada possible.
- si es tracta d'una zona no urbana: les referències més properes possibles.

Sortim de la pantalla de l'APP clicant el botó "Sortir".

Registrarem aquesta informació com text lliure al camp adreça, **sense seleccionar res del combo**. Per a que quedi registrat l'ABS al que pertany, cal prémer el botó "+", clicar a sobre on surt la fletxa al mapa i prémer el botó "Z" per zonificar.

Si cal afegir alguna informació complementària ho inclourem al camp 'Complement Adreça'. Aquest camp ha de contenir obligatòriament un text per tal que SITREM permeti continuar.

En el cas de domicilis, recollirem dades com: escala, pis i/o porta als camps corresponents i si es tracta d'un edifici públic la planta o ubicació específica.

Quan l'alertant VIP utilitza l'APP per contactar amb 061 CatSalut Respon, l'incident no es GEO posiciona i les dades que es carreguen a la pantalla de 'Nova Trucada' són les vinculades a l'alertant VIP. Aquesta trucada s'ha de tractar segons indica el manual d'operadors de demanda per alertants VIP i no com una entrada APP.

Si la persona ho ha configurat a la seva APP, també es carreguen dades personals de l'alertant (en aquest cas haurem de donar-li al botó de validar).

Si les dades de filiació no apareixen s'ha de demanar DNI o CIP i validar. En el cas que no facilitin DNI, CIP o no validin; hem d'anotar nom, cognoms, edat i sexe.

Si l'alertant no és el propi afectat haurem de substituir les dades de filiació carregades per les de l'afectat.

Classificarem la demanda segons la informació facilitada per l'alertant i actuarem segons indicacions de SITREM.

S'ha de confirmar que l'adreça s'ha enregistrat correctament, si no apareix i està en blanc, posarem l'adreça al camp "A" i la introduïrem manualment a l'Adreça.

Si per alguna incidència o raó s'ha perdut la GEO posició i es vol recuperar, s'ha de clicar el rectangle **APP**, clicar la icona de la bola del món dins de la pantalla Dades de l'APP Mòbil, introduir el camp Municipi, clicar el botó "+", marcar al GIS el lloc de l'incident i zonificar.

5.4.4 Alerta passarel·la SEM - 112

5.4.4.1 Incidents multisectorials

Són aquells incidents en els que hi participen més d'una agència. Aquests incidents no seran tractats pel gestor de demanda de SERVEO, si no que es donaran d'alta a SITREM automàticament amb les intervencions corresponents. La resta de trucades en què l'operador de 112 traspasarà la veu de l'alertant al gestor de demanda de SEM, haurà de tractar-la segons els procediments habituals.

En la pantalla 'Nova Trucada' hi consta l'organització que ens ha donat d'alta l'incident i el número **d'expedient únic** Expedient únic 13255955966 que és el que tindran de referència tots els cossos que intervenen en l'incident.

Aquest número ens permet identificar amb precisió l'incident amb les altres agències.

En el casos en què rebem un avís de 112 on es donin les següents situacions:

- Hi hagi assignat per PSRL els recursos **MOSSOS D'ESQUADRA** o **POLICIA LOCAL**.
- La **comunicació** amb l'**alertant** resulta **difícil** (barrera idiomàtica, agitació i/o poca col·laboració).
- **No** hi ha recurs assignat.

Caldrà passar-ho a valorar pel botó "CONSULTA" i, en cap cas, no es deixarà en cua de valoració.

5.4.4.2 Incidents sanitaris

Són aquells incidents en que només s'alerta a SEM.

El gestor de demanda de SERVEO rebrà una trucada de 112 i se li obrirà la carta de nova trucada amb les dades de localització complimentades.

El gestor de 112 li facilitarà les tres últimes xifres del número d'expedient únic i el municipi per confirmar que les dades traspassades són les correctes.

A continuació, li traspassarà la veu de l'alertant. El gestor de demanda de SEM, a la carta de nova trucada, haurà de prémer el botó "Org. Ext." (Organitzacions externes) i consultar de forma ràpida la informació transferida de detall recollida per 112. Això no ha d'interferir al nostre guió de la trucada, però si ens aporta informació per gestionar l'incident amb més agilitat.

El gestor haurà de complimentar les dades de l'afectat i classificar l'incident de forma habitual.

No copiarem cap informació de la ORG EXT al camp 'A', però confirmarem amb l'alertant el motiu de la trucada i classifiquem amb la confirmació donada per l'alertant.

A la informació transferida de detall recollida per 112 també podem accedir des de:

- Omega: prement el botó “O” (excepte Omega de Transport Sanitari).
- Incident creat: prement el botó “Org. Ext.” de la pantalla inicial.

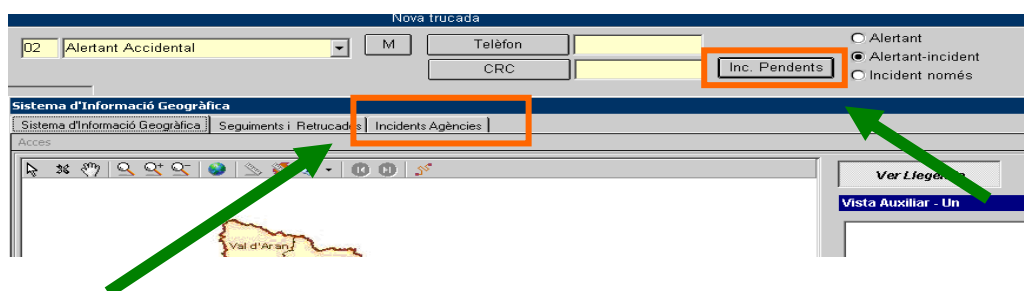
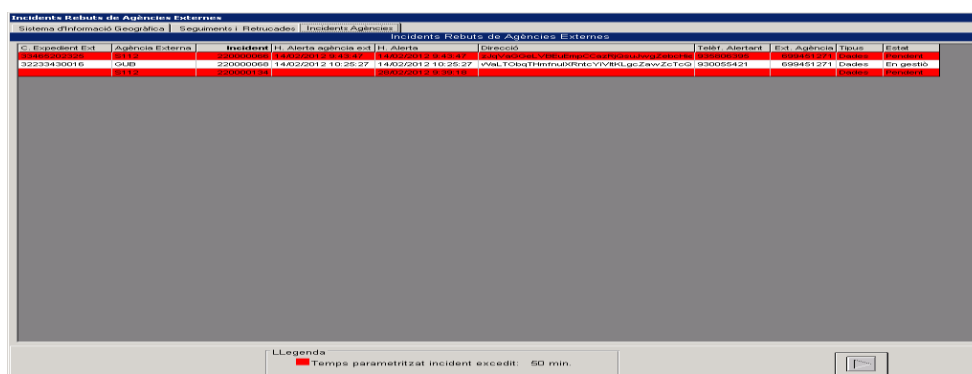
Els diferents botons de “Org. Ext” i “O”, si es troben de color vermell significa que hi ha missatges pendents de llegir.

En el cas de que no estiguin les dades (no s’omple automàticament la pantalla de nova trucada amb les dades de localització de l’incident), el gestor de demanda premerà el botó “Inc. Pendants” i aleshores s’ompliran automàticament les dades associades a la trucada de l’operador de 112.

En el supòsit que hi hagi més d'un incident associat al mateix operador del 112 pendent de ser complimentat, s'obrirà una finestra que informará d'aquests incidents i caldrà confirmar mitjançant el número d'expedient únic quin és el correcte.

Sempre haurà un gestor SERVEO a totes les sales visualitzant la pestanya d'incidentes d'agències per tal de tenir controlats aquests incidents penjats

Si malgrat això, per un mal funcionament del nexa entre dades i veu aïlladament en algun incident no es presenten les dades a la pantalla de nova trucada, el gestor de demanda anirà a la pestanya “**d'Incidents Agències**”, situada al monitor de l'esquerra, i mitjançant el número d'expedient únic cercarà l'incident. Per carregar les dades a la pantalla de nova trucada només caldrà fer doble clic sobre l'incident.



Una altra situació possible és que 112 traspassi les dades, però per incidències tecnològiques, no la veu. Aleshores apareixerà una alarma amb el següent missatge: **“ALERTA: INCIDENT PENDENT A PESTANYA INCIDENTS AGÈNCIES”** als perfils professionals següents: “Auxiliar de Coordinació/Infermer Consultor”.

Aquesta advertència apareixerà transcorreguts 15 segons després que les dades s'implementin a la pestanya **Incidents Agències**.

A continuació, l'Auxiliar de Coordinació alertarà al coordinador dels gestors de demanda i/o el mateix coordinador de gestors de demanda de l'empresa proveïdora avisarà a un gestor que estigui lliure perquè recuperi l'incident pendent de classificar. Aquest haurà de:

- Passar a “Treball Auxiliar”.
- Anar a la pantalla de “Incidents Agències”.
- Posicionar el punter a sobre l'incident a recuperar i fer doble clic.
- Trucar al telèfon que hi figura per tal de parlar amb l'alertant.
- Classificar amb l'Omega l'incident segons el procediment habitual.
- Finalitzar la trucada segons procediment habitual.

Si l'operador de 112 ens passa un incident i no es carreguen les dades a la pantalla de nova trucada ni figura l'incident a la pantalla d'agències externes, el gestor de demanda ha de complimentar les dades del telèfon, localització i afectat, classificar la demanda, segons protocols de primer nivell i facilitar la resposta a l'alertant, com es realitza en el procediment ordinari sense passarel·la. Abans s'haurà de comprovar que no sigui una trucada repetida, reclamació, modificació... per tal de no generar un duplicat.

Els gestors de demanda de primer nivell sols han de confirmar l'adreça amb l'alertant en aquells incidents que entrin per passarel·la i en el quals al camp adreça consti **"ADREÇA NO VALIDADA"**.

En aquests casos el gestor de demanda haurà d'**enregistrar-ho a SITREM UN COP GENERAT EL SERVEI** mitjançant la icona "ADREÇA".

Poden passar dues coses:

1. L'adreça es valida amb el cartogràfic de SITREM, llavors s'anota a la "A" ADREÇA VALIDADA. Eliminem l'anotació del 112 "ADREÇA NO VALIDADA" i sortim pel botó porta  perquè quedi registrat.
2. Si l'adreça no es pot validar amb el cartogràfic de SITREM, es deixa l'adreça facilitada per 112 i s'anota al camp "A": "SITREM NO LOCALITZA". Per poder deixar l'adreça igual del 112 NO hem de sortir per la icona de la porta. Podem sortir clicant per exemple la icona "Afectats".

Els incidents passats per 112 on l'adreça sigui un Centre Sanitari, s'haurà de modificar l'adreça a la pantalla de NOVA TRUCADA codificant el centre pel directori "H" de Sitrem i interrogar si el telèfon facilitat al 112 és un número directe o tenen una extensió (si faciliten extensió cal anotar-la al complement d'adreça).

Exemple: Nom del 112: Clínica Sagrada Família
Nom SITREM: Sagrada Família, Clínica (S)

Quan es tracti d'una Residència geriàtrica, també, modificarem l'adreça a la pantalla de NOVA TRUCADA, codificant-la pel directori "E" i s'haurà de modificar l'alertant per "Residència Geriàtrica".

TOT I AIXÒ SEMPRE ES LLEGIRÀ L'ADREÇA PER VERIFICAR NO HI HAGI INCOHERÈNCIES O MANQUI INFORMACIÓ RELLEVANT (on està dins un centre comercial, pis/porta si és domicili, manca del nom del carrer...).

Les alertes rebudes a través de 112 amb número d'expedient únic MAI es farà una Informativa Breu, trucada tallada, maliciosa o nul·la.

En casos d'Edificis singulars, s'ha de concretar accessos i cal confirmar un punt de trobada amb el personal de seguretat per tal de facilitar l'accessibilitat al lloc de l'incident. Aquesta informació es recollirà al camp 'Complement d'Adreça'.

5.4.4.3 Mecanismes de control

S'han establert mecanismes de control per tal d'assegurar la correcta recepció dels incidents per part del SEM provinents de 112; són missatges automàtics que s'envien d'una aplicació a l'altra.

- **Acceptat.** Aquest missatge s'envia per passarel·la de SEM a 112 quan les dades de l'incident enviades per 112 s'insereixen a la base de dades de l'aplicació (Sitrem).
- **Atès.** Aquest missatge s'envia per passarel·la de SEM a 112 quan:
 - **En els incidents amb veu i dades** el gestor de demanda accepta/rebutja el protocol.
 - **En els incidents sense veu (multi agències)** el gestor de recursos activa el primer recurs SEM a una intervenció del incident.

El 112, en cas de no rebre algun d'aquests missatges en els temps indicats en els seus procediments, realitzarà una trucada facilitant el número d'expedient únic de l'incident per tal de aclarir què és el que ha passat i si no s'han rebut, facilitar les dades de l'incident per tal de que es pugui gestionar per part de SEM. En aquesta situació, el gestor de demanda ha d'informar de la incidència al coordinador de demanda i aquest al Cap de Torn del territori on s'ha produït l'incident, en el cas de la **Sala Motors**, la transferència es a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn** en horari diürn (08h a 20h).

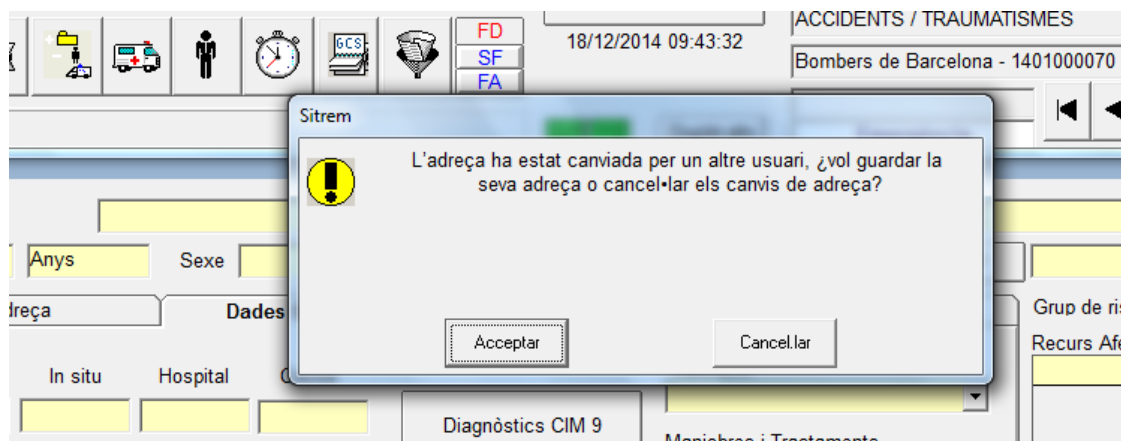
5.4.4.4 Modificació d'adreça

- **De 112 cap a SEM:** L'operador del 112 trucarà al gestor de demanda de SEM per informar que s'ha fet una modificació d'adreça, facilitant el número d'expedient únic per localitzar l'incident.

Pot succeir que l'112 faci una modificació d'adreça mentre el gestor de demanda del SEM encara està treballant a la carta de nova trucada i no ha premut el botó de "Crear nou incident". En aquest cas, es mostrarà una finestra amb el següent missatge:

"L'adreça ha estat canviada per un altre usuari, vol guardar la seva adreça o cancel·lar els canvis d'adreça?"

I dos possibles respostes: “Acceptar” o “Cancel·lar”



Si el gestor de demanda no ha realitzat cap comprovació d'adreça i, en conseqüència, no ha fet cap modificació de les dades facilitades des de l'112, cal que premi el botó “Cancel·lar” que implicarà que s'accepten les noves dades d'adreça que facilita l'112.

Si el gestor de demanda ha fet una comprovació d'adreça i ha fet alguna modificació de la mateixa, cal que premi el botó “Acceptar” que implicarà que no s'accepten les noves dades que facilita l'112.

5.4.4.5 Reclamació

- **De 112 cap a SEM.** Les reclamacions rebudes al 112 d'un incident que s'està gestionant, les farà en forma d'anotació a la missatgeria; al mateix temps, l'operador del 112 trucarà al gestor de demanda de SERVEO i li facilitarà el número d'expedient únic, traspasarà la veu de l'alertant i aquest cursarà una reclamació seguint el procediment SEM de les reclamacions, interrogant si l'afectat ha empitjorat o no.
- El gestor de recursos visualitza un missatge nou a la finestra “Reclamació incident” de la crono: “Nº incident xxxxxxxxxx. 112 ha fet una nova anotació”. Simultàniament apareix a la intervenció de la crono la lletra “R” informant de la reclamació.

5.4.4.6 Petició d'anul·lació

- **De 112 cap a SEM.** Les anul·lacions rebudes al 112 d'un incident que s'està gestionant, les farà en forma d'anotació i, al mateix temps, l'operador del 112 ha de trucar al gestor de demanda de SEM, li ha de facilitar el número d'expedient únic i, aquest ha de cursar una anul·lació preguntant el motiu i anotant al camp “A”: “112 anul·la incident i el motiu de l'anul·lació”. El gestor de recursos visualitzarà un missatge nou a la finestra “Anul·lació incident” de la crono: “Número incident xxxxxxxxxx. 112 ha fet una nova anotació”. Simultàniament apareixerà a la intervenció de la crono la lletra “A” informant de l'anul·lació. L'àrea de recursos de SEM comprovarà el motiu de l'anul·lació i decidirà si anul·la els recursos SEM activats per aquest incident.

5.4.4.7 Re-tipificació

- **De 112 cap a SEM:** La retipificació no és més que un canvi en la classificació del incident quan 112 rep més informació i canvia la seva classificació. L'operador de 112 ha de trucar al gestor de demanda del SEM li ha d'informar del número d'expedient únic i de que s'ha fet una retipificació de l'incident. El gestor de demanda avisarà a l'Auxiliar de Coordinació i aquest veurà la nova classificació al camp "A", actuant segons els actuals procediments.

Cercador prismàtics

A la pantalla de cercar incidents per prismàtics s'ha afegit una nova funcionalitat per tal de cercar aquells incidents procedents del 112:



Al combo superior "Alertant" triarem l'opció 112 i al camp inferior posarem el número d'expedient únic. Com es tracta d'un número amb moltes xifres, s'ha habilitat un comodí per tal de facilitar la cerca: "%". El podem situar abans, en mig o al final del número que coneixem i, al fer la cerca, ens presenta tots aquells incidents que coincideixen amb el criteri proposat.

5.4.4.8 Estat de la passarel·la



S'han habilitat dos controls a la pantalla, que presenten l'estat de les dues passarel·les de dades existents, la de 112 i la de Guàrdia Urbana/Bombers de Barcelona (GUB/SPEIS).

Aquests controls tenen dos valors: "En línia" i "Caiguda" representats per els colors "Verd" i "Vermell" respectivament.

Si l'indicador de la passarel·la de 112 està en color vermell vol dir que no està operativa i la gestió dels incidents es farà telefònicament com actualment.

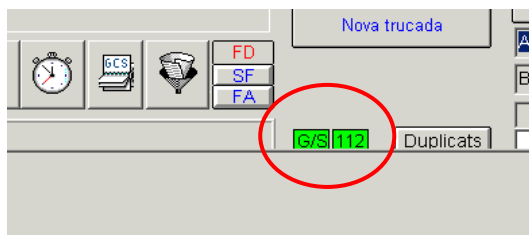
Els incidents que comencem a gestionar per telèfon per que la passarel·la de dades no està operativa es continuaran gestionant per telèfon fins el tancament del incident. Els podrem distingir perquè no tindran informat el número d'expedient únic.

5.4.4.9 Alerta passarel·la Guàrdia Urbana Barcelona/SPEIS (G/S)

La integració de dades entre els sistemes de despatx del SEM i a Guàrdia Urbana de Barcelona, el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis, Salvaments de Bombers de

Barcelona (SPEIS) amplia les seves funcionalitats facilitant la gestió dels operadors i gestors de les dues agències.

El control G/S en verd indicarà que la Passarel·la SEM-Guàrdia, Urbana Barcelona/SPEIS està en línia (hi ha connexió).



El gestor de demanda podrà rebre incidents de GUB/SPEIS, però sense veu associada. És a dir, se li obrirà la pantalla de nova trucada amb un incident que tindrà les dades completes, però sense veu.

Al quadre Agència constarà "Guàrdia Urbana" o "Bombers de Barcelona".

Quadre Agència: constarà Guàrdia Urbana o Bombers de Barcelona

El gestor de demanda haurà de trucar al telèfon que consti a la pantalla de nova trucada:

- Si contesten, confirmarà les dades carregades, classificarà i crearà incident.
- Si no contesta ningú ho haurà de comunicar immediatament a l'Auxiliar de Coordinació o Coordinador Tècnic de la sala de Barcelona.

5.4.5 Alertant indirecte

Ens referim a aquelles trucades en les quals l'alertant no es troba al lloc de l'incident (excepte als procediments específics de Transport Sanitari).

A aquests casos hem de gestionar la trucada amb les dades que ens facilita l'alertant, creant l'incident i informant de la resposta que indica Sitrem.

Si ens han facilitat un telèfon del lloc, haurem d'informar que ens posem en contacte amb la persona que es trobi al lloc de l'incident.

Després, seguidament, hem de trucar a l'afectat o alertant al lloc. Seguirem el procediment descrit a l'apartat 5.8.7. Trucades emeses pel gestor de demanda de primer nivell.

En el cas que l'alertant sigui TeleAssistència i la resposta que ens indica Sitrem és derivació, rebutjarem sempre el protocol.

TeleAssistència o qualsevol alertant indirecte fa retrucades per fer seguiment dels usuaris i demanar informació del servei. A aquests casos no es pot facilitar cap tipus d'informació referent al destí hospitalari del pacient i informarem al gestor de

TeleAssistència o a l' alertant que no els hi podem facilitar informació per la Llei de Protecció de Dades.

Sí podem facilitar informació, en cas que ho demanin personal qualificat (MMEE o jutjats), en cas d'estar actiu el servei.

5.4.5.1 Atenció a les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista des del SEM indirecte

Quan es rep una alerta al SEM, el professional de gestió de la demanda ha de classificar la consulta segons els procediments operatius habituals, aplicant els criteris clínics establerts. Si durant la trucada **s'identifica —ja sigui per part de l'afectat o del seu entorn—** que la persona té un diagnòstic de **Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)**, el gestor de demanda ha de seguir els passos següents:

1. Registrar la informació: **Anotar que la persona atesa té TEA al Camp A.**
2. Classificar segons símptomes: Continuar amb la classificació de la prioritat segons la simptomatologia que presenti l'afectat, d'acord amb el procediment establert.
3. Transferir la trucada amb informació rellevant: **Quan es derivi la consulta al consultor, comunicar explícitament que l'afectat és una persona amb TEA.**

Aquesta informació és clau per adaptar la comunicació durant l'atenció posterior.

S'aplicarà les rodes de transferència segons classificació i tipologia de consulta feta.

5.5 Localització

La localització d'un incident ha d'incloure els camps **municipi, comarca, província, adreça i número**, obligatòriament i els camps **Sub M1, Sub M2 i complement**, si s'escau amb les excepcions ja previstes per incidents classificats com **Atenció No Urgent > Consulta Administrativa**.

El gestor de demanda de primer nivell ha de sol·licitar la localització mitjançant dues preguntes:

“A quin municipi es troba l'afectat?”

En el cas de tractar-se de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, cal confirmar quina és la ciutat, per exemple:

“És Barcelona ciutat?”

Per localitzar el municipi pot escriure el nom del mateix al camp i, a continuació, obrir el desplegable per confirmar si és correcte. Altra opció és escriure part del nom i obrir el desplegable on apareixeran tots aquells municipis que continguin les lletres marcades i, a continuació, prémer a sobre del que correspongui.

Si al desplegable surt més d'un Municipi amb el mateix nom, s'ha de confirmar quin de tots es el correcte.

Exemple: L'Hospitalet? El gestor ha de confirmar Hospitalet de Llobregat o Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant?

Una vegada queda complimentat el municipi, de forma automàtica es registren la comarca i la província. Tanmateix, si la informació de la que disposa el Gestor de demanda és la província o la comarca pot complimentar un o altres camps i, automàticament, filtrarà els noms de les comarques o els municipis respectivament.

Si al municipi localitzat és festiu apareixerà un camp de color verd, just a sobre del camp "Municipi" que indicarà aquesta informació.

El camp Sub M1 correspon a districtes de Barcelona, Barris i/o llogarets i/o urbanitzacions, és a dir, àmbits territorials inframunicipals.

El camp Sub M2 realitza la mateixa funció de barris a la ciutat de Barcelona i mateixes subdivisió de Territori per la resta de municipis.

Aquets camps es carreguen automàticament al seleccionar el camp adreça. En tots els casos, **i sobre tot en les capitals de província**, cal confrontar la congruència entre el carrer i el barri que indica l'alertant i el barri que carrega SITREM interrogant al respecte:

"Quin barri és?"

A Barcelona ciutat, **cal anotar el barri al complement d'adreça, mai codificarem numero de portal 0, ni es pot servir el comodí "desconegut"** excepte per consultes de caire administratiu.

Cal confirmar que el barri indicat és el mateix que apareix a la carta de nova trucada. En cas negatiu, cal tornar a interrogar pel carrer i la població correcta fins obtenir la localització adequada.

Per localitzar l'adreça pot escriure's el nom de la mateixa al camp, prémer el botó **A** i, a continuació, obrir el desplegable per confirmar si és correcte. Altra opció és escriure part del nom, prémer el botó **A** i obrir el desplegable on apareixeran totes aquelles adreces que continguin les lletres marcades i, a continuació, prémer a sobre de la que correspongui. En el cas de tractar-se de via pública, cal demanar el número del carrer i/o la cruïlla més propera al lloc de l'incident. Si es tracta d'un domicili, cal sol·licitar el nom del carrer, el número, escala, el pis i porta i, en cap cas, cal codificar l'adreça com a cruïlla.

Si l'adreça correspon a un centre sanitari pot escriure's el nom del mateix al camp, prémer el botó **H** i, a continuació, obrir el desplegable per confirmar si és correcte. Altra opció és escriure part del nom, prémer el botó **H** i obrir el desplegable on apareixeran tots aquells centres que continguin les lletres marcades i, a continuació, prémer a sobre del que correspongui.

Si l'adreça correspon a una carretera, autopista, autovia... pot escriure's el nom de la mateixa al camp, prémer el botó **C** i, a continuació, obrir el desplegable per confirmar si és correcte. Altra opció és escriure part del nom, prémer el botó **C** i obrir el desplegable on apareixeran totes aquelles carreteres que continguin les lletres marcades i, a continuació, prémer a sobre de la que correspongui. Si l'alertant no coneix la

nomenclatura, interrogarem la direcció de la carretera prenent com a referència el municipi que ens indiquin més proper. Ex: Carretera de Navarcles a Mura, la pregunta és:

“De quin dels municipis es troba més proper?”

Cal sol·licitar sempre el punt quilomètric i el sentit de la carretera (si hi ha més d'un sentit).

The screenshot shows the 'Nova trucada' (New call) form. A warning dialog box is displayed in the center, stating: 'Punt Kilometric no trobat. En aquest municipi els punts kilomètrics van del 1156,2 fins el 1165,6. El número insertat pertany al municipi de VILA-SECA. Premi acceptar per canviar el municipi o cancel·lar per insertar un nou punt kilomètric.' (Kilometer point not found. In this municipality the kilometer points range from 1156.2 to 1165.6. The number entered belongs to the municipality of VILA-SECA. Press accept to change the municipality or cancel to insert a new kilometer point.)

The form fields include: Alertant (02), Alertant Accidental, M, Telèfon (608081524), Inc. Pendants, Adreça a Afectat, Servei Trucada, Municipi (Tarragona), Comarca (Tarragonès), Província (TARRAGONA), Sub.M1, Sub.M2, Adreça (A-7 / Ctra), Complement, ABS, Nom i Cognoms, Edat, Anys, Sexe, Codi, and a table of related incidents.

Municipi	Adreça	Comp. Adreça	C. Incident	Afectat	Tipus Demanda	SubM1
Tarragona	c. A-A0		130000367		MALALTIA LLOC F	Sant Pere i Sant Pau
Tarragona	Cr. Desconegut ((SM2) Bonavista) 0		130000366		MALALTIA DOMIC	Bonavista
Tarragona	c. Abat Escar, de l'0		130000362		MALALTIA DOMIC	Sant Salvador
Tarragona	c. A (Riu Clar) 0		130000296		MALALTIA DOMIC	Riu Clar
Tarragona	c. Adria, d'4		130000146		MALALTIA DOMIC	Tarragona

Si apareix en pantalla el missatge que es mostra a la imatge següent indicant que hi ha una discordança entre el punt quilomètric i el municipi, cal sol·licitar a l'alertant la confirmació de les dades. En aquest cas, preval la Ctra. i PK. anotant al camp complement d'adreça **“diuen és ...”**.

Si no faciliten PK, anotar Municipi, adreça “desconegut” i al complement d'adreça anotar nomenclatura de la Ctra. i totes les dades de localització.

Si l'adreça correspon a una edificació singular pot escriure's el nom de la mateixa al camp, prémer el botó **E** i, a continuació, obrir el desplegable per confirmar si és correcte. Altra opció és escriure part del nom, prémer el botó **E** i obrir el desplegable on apareixeran totes aquelles que continguin les lletres marcades i, a continuació, prémer a sobre de la que correspongui. En aquest apartat es pot trobar, també, masies de les quals 112 ha facilitat la seva GEO posició. I, també, es poden trobar unes 3000 masies de la comarca d'Osona i voltants que disposen d'un número de matrícula que l'alertant facilitarà.

En el cas que Gestió de Demanda identifiqi l'alerta dins del recinte Palau Sant Jordi o del Estadi Olímpic caldrà que codifiqui a la E 'PT Palau Sant Jordi/ Estadi Olímpic (els do recintes tenen el mateix punt).

Per fer una millor recerca podem utilitzar una sèrie de codis:

EM: estacions de metro	Esco: Escoles / bressol
FCG: Estacions de Ferrocarrils de la generalitat	Merc: Mercats
RNF: Estacions de Renfe	PLJA: Platges
Emp: Empreses	Pisc: Piscines
ALBE: Albergues	MOLL: Ports
BIBL: Biblioteques	Port: Punts facilitats per policia portuària
Ceme: Cementiris	PRES: Presons
Tana: Tanatoris	TEAT: Teatres
CENT: Centres comercials	Tram: Trams
CINE: Cinemes	UNI: Universitats
RESI: Residències	Mas: Masies
RG: Residències	Aero: Aeroports
COMI: Comissàries	Edif: Edificis oficials
CRC: Columnes de rescat cardíac	

Escriurem aquests codis davant del nom que ens indiquin.

Exemple: EM Carrilet, per fer recerca de la parada de metro de AV. Carrilet L1.

Si l'adreça correspon a una cruïlla de carrers, cal introduir el nom d'un dels dos carrers seguint el procediment anteriorment descrit i, a continuació, cal prémer el botó **X** que obre una nova finestra "**Cruce de calles**". Cal obrir el desplegable que ens mostra tots els possibles carrers que fan cruïlla amb l'introduït i escollir el que correspongui prement a sobre del mateix.

Un cop inserida l'adreça, només queda fer la zonificació de la mateixa amb el botó **Z** que permetrà crear l'incident. Les zones de classificació són les següents:

- **ABS:** àrea bàsica de salut
- **ZR:** regió sanitària
- **ZH:** zona hospitalària
- **ZS:** zona psiquiàtrica infantil
- **ZRS:** zona psiquiàtrica adults (exclusiu de Barcelona ciutat)
- **ZPS:** lot d'ambulàncies

El camp "**Complement**" permet escriure dades que puguin ser rellevants per a la localització de l'incident. Per exemple: dades referides a l'adreça que sembli important ressenyar.

En el cas que l'adreça de l'incident sigui un centre sanitari (H) o edifici o lloc singular (E), al seleccionar-ho es posaran en el complement d'adreça les dades de carrer i número d'aquest centre o edifici, pis, porta, escala (cal confirmar l'adreça que carrega Sitrem amb l'alertant i anotar la ubicació de l'afectat). En el cas que l'adreça que facilita l'alertant no correspongui a cap carrer (o carretera) de les incloses en el desplegable, s'haurà de seleccionar del desplegable "**Adreça**" el carrer comodí, el Desconegut i registrar l'adreça completa en el "**Complement d'adreça**". Quan es selecciona "**DESCONEGUT**" a l'adreça d'un municipi i, SITREM dona l'opció entre MUNICIPI o DISEMINAT, s'ha de triar sempre MUNICIPI perquè s'activi la unitat correcta.

Si l'adreça correspon a un centre de treball, comercial, turístic o de lleure i l'alertant és personal de seguretat del mateix, amb independència de la via d'entrada de l'alerta sigui 061 o 112, **cal confirmar un punt de trobada amb el personal de seguretat per tal de facilitar l'accessibilitat al lloc de l'incident**. Aquesta informació es recollirà al camp Complement d'adreça.

Si és un lloc obert, centre comercial, estadi-centres esportius, recinte firal, mercat, etc. Haurien de confirmar el punt d'accés o el lloc exacte de localització dins del recinte.

Després de cada dada de localització es reformula l'adreça, municipi, carrer, pis... per assegurar-se que no hi ha cap errada.

5.5.1 Localització de l'incident a través d'unes coordenades X,Y

Botó “+” (zonificació per coordenades XY)

Per poder pulsar aquest botó, s'haurà d'haver informat obligatòriament el camp “Municipi”. I hauran d'escriure com a text lliure al camp “Adreça” la dada de localització.

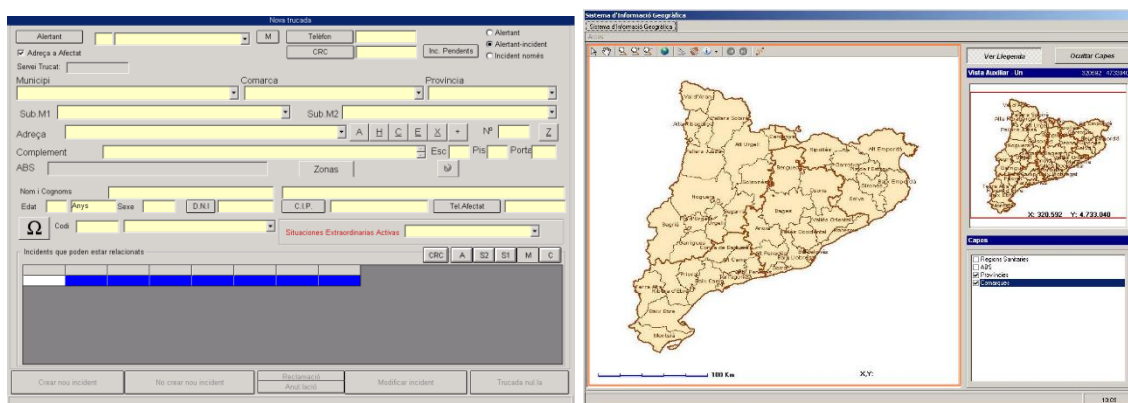
Al prémer el operador el botó  , la pantalla del cartogràfic entra en un nou mode (edició) que permet a l'operador, al fer “clic” amb el ratolí a sobre de ell, obtenir les Coordenades XY on s'ha produït l'incident, així com el municipi al que pertanyen aquestes coordenades.

Visualment es marca aquest nou mode posant-li al mapa del cartogràfic un marc de color taronja al voltant del mateix (figura inferior) i, també, el punter de ratolí per un diferent a l'actual per tal que es vegi clarament el mode en que ens trobem.

L'operador que es troba “editant” en el cartogràfic haurà de prémer primer el botó “Fletxa” i llavors al prémer el ratolí a sobre del mapa, les coordenades on premi seran considerades com les coordenades del incident.

Un cop l'operador esculli les coordenades, se li demanarà confirmació de la localització escollida, per tal de minimitzar errades.

Aquesta opció, el gestor de demanda, només l'utilitzarà quan la localització de l'incident sigui impossible per els mitjans habituals: carrer, edifici singular, carretera etc. i sempre que el punt indicat on es troba l'afectat apareix-hi reflectit al mapa del cartogràfic.



Un cop es retorni del sistema cartogràfic, aquest haurà proporcionat el codi ABS i el municipi d'aquestes coordenades XY. El municipi retornat es validarà que sigui el mateix que figura al camp “Municipi” que prèviament s'havia introduït, informant a l'operador d'error cas que no coincideixin, minimitzant així la possibilitat d'errada al fer la tria al sistema cartogràfic.

En cas de ser el mateix municipi, es complimentarà en pantalla el camp “ABS” amb el valor localitzat per aquelles coordenades i, a la vegada, es complimentaran les zones de seguretat de tal manera que la pulsació del botó “Zones” les presentarà.

El camp **“Direcció”**, en cas de tenir unes coordenades XY definides, serà un camp d'introducció lliure i, per tant, no es validarà que aquesta existeixi al carrer propi de SITREM™. Això serà així per tenir la mateixa operativa tant per aquests incidents creats per l'usuari com per als incidents creats per altres agències i que puguin venir a través de passarel·la; els quals poden tenir una direcció que no té per què existir al carrer de SITREM.

Aquest fet es pot variar i fer que el camp **“Direcció”** operi com sempre (tenint un desplegable que validi aquesta contra el carrer) si es prem qualsevol altre botó de pantalla (A,H,C,E,X). En aquest cas, s'esborrarà el camp “Direcció” i s'haurà d'introduir novament, validant-ne llavors contra el carrer de SITREM™ encara que hi hagi coordenades XY establertes. Les coordenades XY s'informaran, també, per les localitzacions validades contra les taules de SITREM.

El que sí es valida en tots els casos, és que el camp **“Direcció”** estigui informat. No pot quedar en blanc al sortir de la pantalla, és un camp obligatori. En aquest camp, el gestor de demanda escriurà l'adreça que li han donat; per exemple: si és una masia el nom de la masia o indret.

5.5.2 Punts de trobada previstos per a incidents al Port de Barcelona i Aeroport del Prat de Llobregat

Tant al recinte portuari de Barcelona com l'Aeroport del Prat de Llobregat, degut a la seva dispersió, s'han definit uns punts de trobada entre les unitats assistencials de SEM i els cossos de seguretat/alertants vinculats a aquest espai que hauran de ser recollits en el moment de la creació de l'incident.

5.5.3 Punts de Trobada Port de Barcelona

El recinte portuari inclou una zona del municipi del Prat de Llobregat (ZAL-Prat.). S'han definit uns punts (7 punts) d'accés i trobada al Port de BCN-Prat:

L'operador de demanda ha de complimentar les dades de l'alerta segons els procediments operatius del centre coordinador de SEM. Quan identifiqui que l'adreça de l'incident es troba dins de l'interior del recinte del port de Barcelona, en funció de l'alertant, actuarà de la següent manera:

- Alertant Policia Portuària: es codificarà la informació a l'aplicació OMEGA i caldrà fer la pregunta: **“Quin és el punt de trobada de vostès amb la unitat?”**. A continuació, codificarà el punt indicat (de l'1 al 7) prement el botó **“E”** i cercant **“Port de BCN Punt...”** els punts suspensius correspondran al número informat.
- Qualsevol altre tipus de alertant: es codificarà la informació a l'aplicació OMEGA i s'informarà a l'alertant en funció de la resposta facilitada per l'aplicació.

5.5.4 Punts de trobada Aeroport del Prat de Llobregat

Es poden produir diferents tipus de demanda d'intervenció a l'Aeroport:

- Emergència en les terminals i pàrquings
- Emergència per sol·licitud del servei mèdic de l'aeroport (SMA)

a) Emergència a les terminals i pàrquings:

L'aeroport de Barcelona-Prat té dues terminals (T1: nova i T2: antiga). La demanda de servei pot venir tant del mateix control de l'aeroport, com de passatgers que estan en les terminals (via 061 o 112).

Es crearà l'incident segons els procediments habituals. Donades les característiques de l'aeroport, serà especialment important tota la informació que es pugui aportar addicional a la localització: Número de terminal, zona d'arribades o sortides, punts de referència propers identificables (número de mostrador de facturació proper i companyia que l'opera, nom d'una cafeteria – tot i que n'hi ha amb noms repetits –, número de planta del pàrquing, plaça més propera, etc.). S'ha de tenir en compte que la T1 és la nova i la T2 encara hi ha qui la coneix pels noms antics (Terminal A, B o C).

b) Emergència per sol·licitud del servei mèdic de l'aeroport (SMA):

Quan l'alertant s'identifiqui com a membre del SMA, es considerarà com un transport sanitari i necessitarem que ens facilitin les següents dades del pacient a traslladar:

- Filiació
- Patologia que presenta a l'actualitat
- Mobilitat (precisa llitera, cadira rodes, deambula)
- Acompanyants

En aquest cas, s'haurà d'especificar a quina terminal es troben i si el pacient necessita llitera o un recurs SVA.

Si es troben a la T1

- No necessita llitera: El Servei Mèdic traslladarà al pacient al punt de reunió PR4 (vial inferior arribades) on SVB es farà càrrec.
- Sí necessita llitera o SVA: Accés per PR5 on Guàrdia Civil i un guia els esperaran.

Si es troben a la T2

- L'accés a les instal·lacions del servei mèdic es farà pel PR2 (aparcament Bloc Tècnic).

5.5.5 Relacionar incidents actius

A la part inferior de la pantalla apareix l'apartat **“incidents que poden estar relacionats”**, permet veure els incidents actius (que no han finalitzat) i que poden estar relacionats amb l'incident que s'està introduint. Els incidents relacionats es poden visualitzar per un criteri geogràfic, prement els botons a la dreta en la vora superior del quadre amb les lletres; **A, S2, S1, M, C, CRC**, és a dir, per adreça, per submunicipi 2, submunicipi 1, municipi, comarca o Columna de Recat Cardíac. Si no es selecciona cap, per defecte apareixeran els relacionats per adreça.

El gestor de demanda pot prémer els botons CRC, A, S1, S2, etc... per veure els incidents relacionats amb el incident actual i a més pot prémer el botó cercar per introduir un text a buscar a la graella, el botó filtre per introduir text en les columnes i filtrar les

dades, o prémer sobre el text “Radi XY” per efectuar la cerca per radi (en metres) des de la posició del incident actual.

S'ha de tenir en compte que prement el botó “A” només es visualitzen els incidents amb localitzacions de Sitrem i NO es veuen els incidents creats per les altres agències (112, GU, SPEIS).

INCIDENCIA DUPLICATS SITREM

Quan els incidents creats es cancel·len per duplicat (ho fa AC o CT), desapareixen de la part inferior de la pantalla a l'apartat “**incidents que poden estar relacionats**” (graella). I si entra una trucada de reclamació, anul·lació, modificació o retrucada no ho podem gestionar correctament. No quedarà reflectit el marcador a Sitrem,

Si detectem que pot haver passat això... habitualment fem una breu y fem recerca per prismàtics, anotem la informació al incident correcte i informem a AC/CT o a qui correspongui depenent de la trucada. Amb les alertes de 112 amb número d'expedient no podem fer breu i hem de generar incident i avisar a coordinació.

Hem de tenir en compte que si s'ha de passar a valorar de nou, si la deixem en cua, al metge/infermeria no li saltarà la pantalla correcte, per tant aquests incidents no es deixaren en cua.

5.6 Dades de l'afectat

El següent grup de dades, correspon a l'afectat.

Quan el motiu de la demanda sigui No contesta/No respira (emergència vital), Malaltia Lloc Públic o Accidents/Traumatismes (excepte en el cas de Caiguda en domicili lleu), **NO** cal sol·licitar filiació de l'afectat i només cal intentar conèixer l'edat aproximada i anotar el sexe. En aquest cas no es retardarà la gestió de l'incident per demanar dades.

En qualsevol cas de rebuig de protocol s'ha de demanar les dades de filiació sanitària.

Interrogarem a l'alertant: **Te vostè el CIP /DNI del afectat a mà?**

En cas de resposta positiva omplirem les dades en les caselles corresponents (CIP/DNI/NIE) validem i les confirmarem abans de reemplaçar-la en els camps corresponents.

En cas de resposta negativa, demanarem dades: nom, cognoms, edat i marcarem les caselles de desconegut. **Si el alertant diu que ho pot trobar, restarem a l'espera de la informació.** Sempre que siguin incidents relacionats amb consultes ICO, Atenció No Presencial No Urgent (sanitari), Malaltia Lloc Públic (Consulta Sanitària).

A la resta d'alertes, el Gestor de demanda haurà d'omplir tots els camps amb les excepcions previstes per incidents classificats com **Atenció No Urgent**.

L'edat és necessària per decidir la resposta una vegada classificada la demanda. L'edat té un espai per escriure números i una etiqueta que permet seleccionar si es tracta d'anys, mesos, setmanes o dies.

L'etiqueta mostra "Anys" per defecte (ex: 11 mesos, 45 anys...). L'edat és fonamental per a la decisió de la resposta, sobretot en la resposta automàtica protocol·litzada, per això, si no es pot precisar, però es tracta d'un adult, és millor introduir l'etiqueta "Anys", encara que no es registri el número.

El sexe es registra en una etiqueta amb les opcions home, dona o "?". Aquest últim, s'ha d'introduir quan l'alertant ho desconeix. Si no s'ha realitzat la pregunta, el registre resta en blanc.

Existeix un mecanisme de validació a l'hora de introduir el CIP o Document (DNI, NIE, Altres) en la pantalla d'afectats i en la pantalla de nova trucada. També, fa recerca introduint el telèfon.

La opció Altres no té validació.

Per agilitzar la gestió de la trucada hem de demanar com a primera opció el DNI i com a segona opció el CIP.

En els transports sanitaris ha de constar sempre les dades de filiació. En aquests casos, demanarem com a primera opció el CIP.

És important demanar SEMPRE que sigui possible el CIP / DNI / NIE / Altres, a tots els serveis d'ACD, per tal que les regions sanitàries puguin accedir a la informació de l'afectat.

- És important aconseguir-lo per part dels gestors de demanda des de la trucada inicial que genera la intervenció.
- Si no és possible obtenir-lo durant la trucada, per qüestions varies, com pot ser que l'alerta inicial sembli més urgent que el recurs assignat finalment, el gestor d'ACD (Sala Hospitalet de Llobregat i Barcelona) o Coordinador de Sala (Sala Reus), haurà de trucar al domicili i aconseguir el DNI o CIP de l'afectat.

El camp CIP al SITREM™ ha de complir un format concret pel que fa a la seva estructura i, quan aquesta no es compleix, el Gestor de demanda serà avisat mitjançant un missatge en pantalla, forçant-lo a que introdueixi en el camp CIP un valor que compleixi aquest format.

El camp CIP és vàlid si conté el següent :

- Es deixa el camp en blanc, és a dir, no s'informa.
- Si el camp conté 14 dígit amb el format "**XXXXGAAMDDCCC**" on:

XXXX han de ser lletres (incloses "Ñ" i "Ç").

G que correspon al gènere i ha de valdre 0 o 1.

AAMDD que correspon a la data de naixement.

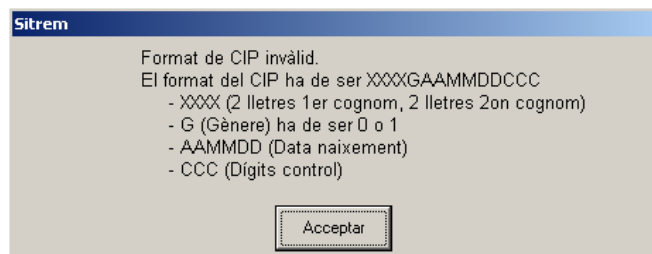
AA: valors numèrics entre 00 i 99.

MM: valors numèrics entre 01 i 12.

DD: valors numèrics entre 01 i 31

CCC que correspon als dígit de control, que han de ser numèrics.

En qualsevol altre cas fora d'aquests dos, es presentarà el missatge:



Aquesta validació s'ha implementat a la pantalla de nova trucada i la pantalla d'afectats. Si valida confirmarem les dades carregades (NOM, COGNOM, EDAT, TELEFON)

- Pantalla Nova Trucada

A la pantalla de **"Nova Trucada"** hi ha el botó anomenat **"Validar"**.

A continuació del camp CIP, de manera que quan l'operador de demanda premi aquest botó, SITREM es posa en comunicació amb la "HC3" mitjançant el CIP i/o Document (DNI/NIE/Altres) i/o el telèfon de l'afectat. L'objectiu és que es puguin recuperar una sèrie de dades referents a l'afectat des de la Historia Clínica Compartida (HC3) per complimentar-les a la pantalla de nova trucada de l'incident.

Si el Document (DNI/NIE/Altres) i/o el CIP estan sense informar, al prémer aquest nou botó donarà error:

"S'ha d'informar el CIP o el DNI/NIE per cercar les dades al Departament de Salut".

Si la crida al RCA dona error o no torna cap dada, s'informarà a l'usuari mitjançant un missatge de error:

"No s'han trobat dades al Departament de Salut per aquest CIP o DNI"

En cas de ser un error, quedarà internament registrat i podrà ser explotat pel departament de sistemes per veure les causes de l'errada.

Com a resposta de aquesta crida, es poden rebre diferents registres de persones, **sempre confirmarem les dades abans de carregar-les**.

Aquestes dades rebudes es presentaran en una finestra perquè l'usuari pugui escollir aquelles que vol fer servir o si no vol utilitzar cap; per això, aquesta pantalla tindrà dos botons: **"Copiar dades"** i **"Sortir"**.

El botó **"Sortir"**, tancarà la finestra sense escollir cap dels registres rebuts i, per tant, s'haurà de complimentar les dades de **"Nova trucada"** com habitualment.

Si es prem el botó **"Copiar dades"** es tancarà la finestra i es copiaran les dades seleccionades als camps corresponents de la pantalla de **"Nova trucada"** reemplaçant el contingut dels camps existents. Confirmarem amb l'alertant les dades carregades: NOM, COGNOMS, TELEFON, DNI, CIP, aquests camps són:

NOM, COGNOMS, TELEFON, DNI, SEXE, CIP, DNI, GRUP DE RISC

El TIPUS_GR correspon al "Grup de Risc" de l'afectat i té els següents valors:

- PCC (pacient crònic complex)
- MACA (malaltia crònica avançada)

Nom	Cognoms	Telefon	DNI	Sexe	CIP	Data	Value
JOSEP	ROEQUE		123456782	Home	ROE20620427014	01/01/0001	

En tot incident en el qual hem de demanar DNI / CIP, si la alertant no el facilita o no el té.

S'ha de clicar la pestanya **"DESCONEGUT"** que hi ha a la pantalla de nova trucada. No cal posar el genèric "xxxx.....".

Form fields: Nom i Cognoms, Edat, Anys, Sexe, Doc., DNI/NIF, C.I.P., Tel. Afectat, Validar. Two 'Desc.' buttons are circled in red.

5.7 Classificació

L'ordre d'aquest manual (identificació de l'alerta → localització de l'incident → dades de l'afectat → classificació de la demanda) és l'ordre de complementació de SITREM (reformular totes les dades per evitar errades). **És molt important fer ESCOLTA ACTIVA de la trucada i conèixer el motiu de demanda i estat del pacient, abans de seguir estrictament aquest ordre, amb l'objectiu de no demorar la resposta a afectats greus realitzant interrogatoris excessius o innecessaris.**

En cas que no s'hagi expressat, el gestor de demanda de primer nivell haurà de fer la següent pregunta: (abans de demanar dades de localització)

“Quin és el motiu de la seva trucada?”

En cas que no s'hagi expressat i la trucada es refereixi a un pacient, caldrà preguntar el següent:

“Què li passa al pacient ara mateix?” (això s'ha de preguntar abans demanar les dades de filiació per si es tracta d'una situació d'emergència)

NO cal interrogar respecte a antecedents patològics i/o tractaments que efectuï l'afectat ni induir la resposta de l'alertant llegint tots els camps de les diferents carpetes.

A continuació mitjançant el botó **Ω** i el desplegable **Codi Omega** es pot seleccionar el tipus de demanda de l'incident (malaltia, traumatisme, transport sanitari, etc.). Només després fer la zonificació i d'escollir un tipus de demanda es podrà crear un incident nou.

Per a seleccionar mitjançant aquest menú s'ha d'escollir un tipus de demanda i a continuació prémer **“Acceptar”**. Per a sortir del menú, utilitzar el botó **“Cancel·lar”**. Omega obre també els tipus de demanda i compleix la mateixa funció.

Si es coneix el codi del tipus de demanda es pot introduir directament en la caixa de text que hi ha a l'esquerra del desplegable. Al fer clic sobre el desplegable es mostrarà el tipus de demanda seleccionat.

A continuació cal prémer el botó “Crear un nou incident”.

Cal codificar tota la informació que facilita l'alertant a l'aplicació OMEGA, seleccionant i prement els botons adients. Només aquelles dades que no sigui possible codificar a l'aplicació, es faran constar textualment al camp “A”.

5.7.1 Accident/traumatisme

En aquest apartat classifiquem totes les demandes que siguin provocades per un accident o traumatisme, de les quals només recollirem DNI/CIP davant d'una caiguda a domicili de caràcter LLEU.

En primer lloc cal esbrinar el **tipus d'accident**, que pot ser:

- **Agressió.** atac intencionat a un altre per matar-lo, ferir-lo o fer-li mal.
- **Escolar.** com tipus d'accident que també inclou la localització del mateix.
- **Laboral.** episodi que genera lesions, i que es produeix durant el treball, o en els trajectes d'anada i/o tornada al treball (accident “In-itinire”)
- **Trànsit**
- **Altres,** que només utilitzarem en cas que no es pugui classificar en cap dels anteriors.

Un cop identificat el tipus d'accident cal fer constar la **localització** i la **causa**.

Si l'alertant ens informa d'algun **condicionant**, cal fer-ho constar en el camp (El concepte **“Desnonament”** refereix a aquelles alertes de desnonaments en els quals ens informin que hi ha persones que necessitin assistència sanitària, és a dir, *si a conseqüència del desnonament l'afectat ha patit una caiguda, classifiquem aquest omega. En el cas que refereixi ansietat o altres símptomes per la situació, serà classificada a altres omegas, és a dir, domicili o lloc públic*).

A continuació cal complimentar sempre el camp afectats, interrogant pel número i estat dels mateixos. Per diferenciar la gravetat, considerarem:

- **Ferit lleu.** L'afectat està a peu dret. En un accident de trànsit, està fora del vehicle. L'afectat ha caigut de menys de 2 m. **respira i contesta.**
 - *Aclariment: ens podem trobar un 'afectat estès al terra per mobilitat reduïda (Afectació extremitats inferiors, peu torçat, invalides,) però conscient i orientat per tant marcarem Lleu.
- **Ferit greu.** L'afectat està estirat al terra (no està a peu dret, o ha tingut un impacte d'alta energia col·lisió, caiguda moto..), no es pot moure. En un accident de trànsit, aquell que no ha sortit del cotxe. **L'afectat no respira i/o no contesta.**
- **En cas de que no sàpiga la gravetat de l'afectat cal marcar “?”**
- **En cas de alertant cossos de seguretat i rescat que informin sobre L'estat del afectat marcarem aquest que indiqui.**
- **Aquest apartat es d'obligat complementari.**

En els accidents de trànsit, si és possible cal conèixer el tipus i número de vehicles implicats, i prémer les icones corresponents del camp **MÒBILS IMPLICATS**, però **sempre s'haurà fet constar la gravetat dels afectats.**

En el cas que l'accident comporti la implicació d'una matèria perillosa, cal prémer la casella: **MATÈRIES PERILLOSES IMPLICADES.**

Els camps **perill, producte, direcció del vent i Fan falta equips de protecció?**, només es complimentaran si l'alertant facilita aquestes dades (habitualment l'alertant serà Protecció Civil o Control de Bombers).

Accidents / Traumatismes				
CONDICIONANTS	AFECTATS	TIPUS D'ACCIDENT	LOCALITZACIO	CAUSA
☐ Dificil accés ☐ Embarassada ☐ Esfondrament (edifici, paret) ☐ Ferit atrapat ☐ Foc / Fum ☐ Metro / Tren ☐ Nens / Nadons ☐ Desnonament ☐ Sortida de via ☐ Túnel / Subsòl ☐ Via ràpida ☐ Altres condicionants	? 1 2 3 Lleus: ☐ ☐ ☐ ☐ Greus: ☐ ☐ ☐ ☐ ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sense ferits ☐ Cadàvers ☐ Accident múltiples víctimes (>4 Afectats)	☐ Agressió ☐ Escolar ☐ Laboral ☐ Trànsit ☐ Altres	☐ Domicili ☐ Indústria ☐ Lloc Públic ☐ Mar obert ☐ Muntanya / Barranc ☐ Piscines ☐ Platja / Costa ☐ Port ☐ Pous ☐ Rius i embassaments ☐ Via interurbana ☐ Via urbana ☐ Zona de risc especial ☐ Zona esportiva ☐ Altres ☐ Ascensor	☐ Atropellament ☐ Bolcat ☐ Caiguda < 2 mts ☐ Cremades ☐ Col·lisió ☐ Contusió ☐ Explosió ☐ Ferida Arma Blanca ☐ Ferida Arma de Foc ☐ Ferida incisa ☐ Incendi ☐ Intoxicació ☐ Maquinària ☐ Ofegament ☐ Precipitació >= 2 mts ☐ Sospita Violència Sexual ☐ Punxada amb xeringa o similar
MÒBILS IMPLICATS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Patinet ☐ Múltiples vehicles				
MATÈRIES PERILLOSES IMPLICADES ☐ Perill ☐ Producte ☐ Direcció Vent ☐ Fan falta equips de protecció? ☐ Si ☐ No ☐ ?				
Cancel·la Accepta				

Quan es rebí una alerta per un possible ofegament i/o persona ofegada s'ha de registrar de la següent manera:

1. Pantalla accidents / Traumatismes
2. Tipus d'accident: Altres
3. Causa: Ofegament
4. Localització: Dependrà del que ens informin: Mar obert, Piscines, Platja / Costa, Port, Rius / Embassaments.
5. Afectats: Si tenim informació del número d'afectats i estat (lleu/greu **sempre s'haurà fet constar la gravetat dels afectats**) ho informarem.
6. Si és un incident de 112 l'equivalència de protocols que podem trobar és:

- Accidents / Traumatismes + Mar obert
- Accidents / Traumatismes + Platja / costa
- Accidents / Traumatismes + Pous
- Accidents / Traumatismes + Rius / embassaments

Davant d'un incident en platges, piscines, rius o embassaments, si existeix una causa coneguda diferent a l'ofegament, s'haurà de classificar segons la informació de la situació concreta.

5.7.1.1 Sospita Violència Sexual

Definició:

La violència sexual és tot acte o temptativa de caire sexual (Agressió sexual, abús sexual i assetjament sexual), realitzat sense consentiment de la víctima, amb independència de que l'agressor tingui o no relació conjugal, de parella, afectiva o familiar amb ella (OMS, 2003). No distingeix sexe o orientació sexual.

Classificació:

- En cas que l'agressió, tot i sospita de violència sexual, es produeixi per ferides per arma blanca o arma de foc, precipitació o s'identifiqui un ferit greu, prioritzarem aquesta classificació sobre la sospita de violència sexual.
- La resta de situacions amb sospita de violència sexual les codificarem com Accident/Traumatisme, Agressió, Sospita Violència Sexual.

Tipus demanda: Accident/Traumatisme

Tipus accident: Agressió

Causa: Sospita Violència Sexual

Un cop hem codificat sospita de violència sexual realitzarem la següent pregunta:

“Situació en curs o immediatament ocorreguda?”

- Si, es tracta d'una situació en curs o immediatament ocorreguda (últimes 24 hores)
- No, no es tracta d'una situació en curs o immediatament ocorreguda (més de 24 hores)

Clicar botó D'acord, acceptar i llegir instruccions de SITREM.

- c) Per demandes de suport psicològic de centres sanitaris per casos de violència sexual **que no han estat assistits/traslladats pel SEM**, el Cap de Torn del SEM pot activar el psicòleg clínic del SEM a petició d'un centre sanitari per realitzar una assistència presencial en casos que no han estat assistits pel SEM (si l'incident s'ha assistit pel SEM ja s'haurà valorat l'assignació de suport psicològic). La demanda d'aquesta petició arriba al SEM a través del telèfon específic per a professionals sanitaris 900555101.

En el cas de la **Sala Motors**, s'avisarà a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn** (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

Operativa a realitzar per el gestor de demanda de primer nivell en aquests tipus de demanda:

Crear un nou incident:

- **Alertant:** "Hospital o centre sanitari"
- **Adreça:** S'ha de posar la del centre on trobarem el/la afectat i al complement d'adreça posarem la localització dins del centre.
- **Dades de Filiació del pacient:** S'han de demanar dades de filiació CIP o DNI.
- **Classificació Omega:** Triarem l'omega Consulta especialista > Suport Psicològic.

Davant d'aquest tipus de demanda, s'ha de tenir en compte el següent circuit de traspàs de trucades :

- **De 8 a 20h:** traspàs pel combo **Hospitalet Coordinadora de Torn**, i si no respon en 8 tons, traspàs al Cap de Torn, sala motors, podent alternar-se fins que un dels dos contesti. **Mai es deixarà en cua.**
- **De 20 a 8h:** traspàs pel combo a Cap de Torn sala Motores. **Mai es deixarà en cua.**

5.7.1.2 Punxades amb xeringues o similars en el context d'oci nocturn

El gestor de demanda generarà l'incident classificant l'omega d'Accidents/Traumatismes i seleccionant "Agressió", "ferit lleu" (si és el cas), "Lloc públic", "**Punxada amb Xeringa o similar**". El gestor/a ha de procedir amb el protocol de Sitrem (que en aquest cas, serà transferir en personal sanitari mitjançant el botó de "Consulta").

***Aquesta classificació es realitzarà independentment de quan s'hagi produït l'agressió** (és a dir, es procedirà amb aquesta classificació tant si s'acaba de produir com si es va cometre fa dies).

Accidents / Traumatismes				
CONDICIONANTS	AFECTATS	TIPUS D'ACCIDENT	LOCALITZACIO	CAUSA
☐ Dificil accés ☐ Embarassada ☐ Esfondrament (edifici, paret) ☐ Ferit atrapat ☐ Foc / Fum ☐ Metro / Tren ☐ Nens / Nadons ☐ Desnonament ☐ Sortida de via ☐ Túnel / Subsòl ☐ Via ràpida ☐ Altres condicionants	? 1 2 3 Llocs: ☐ ☐ ☐ ☐ Greus: ☐ ☐ ☐ ☐ ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sense ferits ☐ Cadàvers ☐ Accident múltiples víctimes (>4 Afectats)	☐ Agressió ☐ Escolar ☐ Laboral ☐ Trànsit ☐ Altres	☐ Domicili ☐ Indústria ☐ Lloc Públic ☐ Mar obert ☐ Muntanya / Barranc ☐ Piscines ☐ Platja / Costa ☐ Port ☐ Pous ☐ Rius i embassaments ☐ Via interurbana ☐ Via urbana ☐ Zona de risc especial ☐ Zona esportiva ☐ Altres ☐ Ascensor	☐ Atropellament ☐ Bolcat ☐ Caiguda < 2 mts ☐ Cremades ☐ Col·lisió ☐ Contusió ☐ Explosió ☐ Ferida Arma Blanca ☐ Ferida Arma de Foc ☐ Ferida incisa ☐ Incendi ☐ Intoxicació ☐ Maquinària ☐ Ofgament ☐ Precipitació >= 2 mts ☐ Sosпита Violència Sexual ☐ Punxada amb xeringa o similar
MÒBILS IMPLICATS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Patinet ☐ Múltiples vehicles				
MATÈRIES PERILLOSES IMPLICADES Perill: Producte: Direcció Vent: ☐ Fan falta equips de protecció? ☐ Si ☐ No ☐ ? Cancel·la Accepta				

5.7.2 Malaltia lloc públic

En aquest apartat classificarem totes les demandes que siguin provocades per una malaltia a un lloc públic, entenent com a tal la via pública i l'interior d'edificis sempre que no es tracti d'un domicili particular (oficines, grans magatzems, centres d'oci...).

En el cas dels hotels i càmpings, cal considerar com a domicili si l'afectat està a l'habitació, tenda, bungalow o caravana, i com a lloc públic si està a la resta de dependències de l'hotel/càmping.

Davant d'aquest Omega, només demanarem edat i sexe, exceptuant el botó 'CONSULTA SANITÀRIA'

El primer que cal interrogar és sobre l'estat de consciència i l'estat de la respiració de l'afectat. És important sempre que es tracti de **DISPNEA, INTOXICACIÓ ETÍLICA, ALTRES INTOXICACIONS i MAL DEFINITS/ALTRES PROBLEMES**, mitjançant les següents preguntes, que són de caràcter obligatori.

- **"El pacient està conscient? Si li parla li contesta?"**
- **"El pacient respira normalment?"**

Si la resposta a la primera pregunta és que el pacient està inconscient, cal prémer la casella: **No contesta**. En aquest cas el programa no deixarà continuar i generarà una resposta directa.

Si la resposta a la primera pregunta és que el pacient està conscient o amb algun nivell d'alteració de la mateixa, cal desplegar el camp **consciència**, i seleccionar una de les següents opcions:

- **Contesta incoherent.** La persona té un discurs des-estructurat i amb contradiccions i també aquella persona que està desorientada, i/o li costa despertar.
- **Parla amb dificultat.** La persona que quan parla no se l'entén. També la que vol parlar i no pot. **(possible classificació d'alteracions neurològiques)**
- **Pèrdua de consciència recuperada/ Mareig.** Es aquella persona que s'ha marejat i ha perdut la consciència per un breu espai de temps i que ara, encara que pot continuar marejada, ha recuperat la consciència.
- **Contesta normal.** Es aquella persona que presenta un estat de consciència normal.
- **¿?** Quan l'alertant manifesta que l'afectat pateix una alteració de consciència, però no sap explicar quina.

Si la resposta a la segona pregunta és que el pacient no respira, cal prémer la casella: **No respira.** En aquest cas el programa no deixarà continuar i generarà una resposta directa.

Si la resposta a la segona pregunta és que el pacient respira correctament o amb alguna alteració de la mateixa, cal desplegar el camp **respiració**, i seleccionar una de les següents opcions:

- **Respira amb dificultat.** L'afectat respira més ràpidament o més lentament de l'habitual; li costa agafar l'aire.
- **Respira normal.** No hi ha cap alteració de la respiració.
- **¿?** Quan l'alertant manifesta que l'afectat pateix una alteració de la respiració, però no sap explicar quina.

A més de la respiració i la consciència, als ítems superiors també podem trobar l'opció de seleccionar, si s'escau, dolor i hemorràgia:

- **Dolor.** Si l'afectat presenta algun tipus de dolor, cal desplegar el camp **dolor**, i seleccionar una de les següents opcions:
 - Cap. Presenta dolor a cara/cap.
 - Tòrax. Presenta dolor a regió toràcica (l'alertant pot parlar de possible "infart")
 - Abdomen. Presenta dolor a la regió abdominal.
 - Extremitats. Presenta dolor a braços i/o cames.
 - No localitzat. Presenta dolor sense especificar la zona concreta.
- **Hemorràgia.** Si l'afectat presenta algun tipus d'hemorràgia, cal desplegar el camp Hemorràgia, i seleccionar una de les següents opcions:
 - Sagna per la boca. Sortida de sang fresca, vermella, per la boca.
 - Sagna pel nas. Sortida de sang fresca, vermella, pels orificis nasals.
 - Altres. Hemorràgies per altres localitzacions.

A continuació, i en funció de la informació que faciliti l'alertant respecte als símptomes que presenta l'afectat, cal complimentar els següents camps que es divideixen en 2 grups:

Grup 1 (requadre a la dreta de la pantalla):

- **Alteració psiquiàtrica. Està agitat i/o agressiu.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta alguna alteració de caire psiquiàtric, i a més a més té un estat d'agitació i/o agressivitat envers ell mateix o el seu entorn.
- **Alteració psiquiàtrica. No està agitat i/o agressiu.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta alguna alteració de caire psiquiàtric, i no té un estat d'agitació i/o agressivitat envers ell mateix o el seu entorn.
- **Amenaça amb suïcidar-se.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat hagi expressat el sentiment d'un intent d'autòlisi acompanyat d'una idea estructurada, és a dir:
 - “Em tiraré per la finestra”
 - “Tinc la corda preparada per penjar-me”, etc.

Totes aquelles accions que ja hagin sigut **realitzades**, es classificaran a l'Omega corresponent: Accident/Traumatisme.

Una vegada classificat l'incident, haurem de llegir literalment l'apartat inferior esquerre de SITREM: “**No pengi parlarà amb personal sanitari**”.

Recordem que no haurem d'indicar les instruccions de SITREM a l'alertant, és a dir:

- **No dir** a l'alertant que s'avisarà a Mossos.
- **No dir** a l'alertant que li enviarem una ambulància.

Finalment, transferirem aquesta trucada mitjançant el botó de CONSULTA. **No deixar en cua.**

- **Ideació auto-lítica / idees de mort.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat expressi/verbalitzi idees de mort, sense idees estructurades, és a dir: “Ja no vull viure més” “Estic cansat/da de la vida, m'agradaria acabar amb ella”, etc. Al marcar aquesta casella, és important **NO deixar en cua** dita consultoria, hem de restar a l'espera que Taula de Salut Mental agafi la trucada.
- **ESMES:** Equip que realitza el tractament integral en salut mental a persones sense llar amb trastorns mentals greus que són atesos pels Serveis Socials específics de l'Ajuntament de Barcelona a la ciutat. Aquest equip, pot sol·licitar el trasllat voluntari/involuntari de l'afectat; quan demani el trasllat, sempre estarà amb l'afectat i facilitarà un informe assistencial a la unitat.

L'alerta de l'equip ESMES es realitza mitjançant el 061 (mai 112) i el psiquiatra sempre estarà present junt al pacient. A més, en el cas que es tracti d'un trasllat involuntari **no farà falta enviar l'informe**.

És important, seleccionar **alertant** “Metge ESMES”, demanar la **FILIACIÓ** d'afectat i marcar l'etiqueta “*Trasllat involuntari peticionat per psiquiatria ESMES*” sense afegir cap altre ítem. A continuació, es transferirà la trucada al telèfon 638355121, al **Cap de Torn** de Barcelona.

- **Testimoni de Suïcidi Consumat:** Cal prémer aquesta casella quan es compleixi alguna d'aquestes situacions:
 - La persona amb qui parlem és l'afectada i informa d'haver estat exposada directament a un suïcidi consumat en el darrer any. Entenent com a

“exposició directa” el fet d’haver patit una mort per suïcidi d’alguna persona del seu entorn proper (amistats, familiars, parella, etc.).

- La persona amb qui parlem és l’alertant i informa que la persona afectada ha tingut una exposició directa a suïcidi consumat en el darrer any i es compleix alguna d’aquestes situacions:
 - Alertant informa que la persona afectada ha estat exposada directament a un suïcidi consumat i aquest l’ha expressat/informat de missatges de comiat
 - Exemples: “No tornaré a l’escola/feina”, “No cal que em busqueu, quan em trobeu ja serà tard”, “No val la pena continuar”, etc.
 - L’alertant refereix que la persona afectada ha expressat missatges que poden ser entesos com acomiadament, sigui verbalment o amb qualsevol suport (WhatsApp, publicacions a les xarxes, etc.).
 - Alertant informa de la impossibilitat de contacte per part seva i/o de l’entorn amb la persona afectada. S’ha intentat contactar amb la persona afectada d’alguna manera i no ha estat possible.

Quan marquem la casella **Testimoni de Suïcidi Consumat** transferirem la trucada mitjançant el botó de **CONSULTA**, és important **NO** deixar en cua i hauréu d’esperar a transferir amb Personal Sanitari, si després d’un temps prudencial no podem transferir la trucada consultarem a l’equip de Coordinació.

**En aquest grup d’ítems, només hem de seleccionar una etiqueta*

Grup 2 (requadre a l’esquerra de la pantalla):

- **Convulsions.** Cal prémer aquesta casella quan l’afectat presenti un episodi de contraccions musculars, que afecti total o parcialment al cos.
- **Intoxicació etílica.** Cal prémer aquesta casella quan l’afectat presenta símptomes i/o conductes pròpies de la intoxicació per alcohol.

- **Altres intoxicacions.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta símptomes i/o conductes pròpies de la intoxicació per qualssevol substància diferent l'alcohol.
- **Part.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectada presenta un part en curs.
- **Mal definits/altres problemes.** Qualsevol altra simptomatologia no descrita als apartats anteriors.
- **Consulta Sanitària.** Aquesta etiqueta s'ha de seleccionar quan l'alertant s'ubica a lloc públic i expressa que vol realitzar una consulta. **Només en aquest cas, recollim dades de filiació d'afectat.**
- **Reacció al·lèrgica:** marcarem aquesta etiqueta quan ens informin de reaccions al·lèrgiques que es poden relacionar amb malalties de l'aparell respiratori, malalties a la pell (urticària) o amb reaccions greus d'inici ràpid que afecten conjuntament la pell, l'aparell respiratori i el cardiovascular (anafilaxi).
SEMPRE que seleccionem aquesta etiqueta preguntarem si existeix dificultat respiratòria.

Finalment cal interrogar si l'alertant es troba amb l'afectat, i aleshores cal prémer la casella: **L'ALERTANT ESTÀ AMB EL PACIENT** (si l'alertant és el propi afectat també cal prémer aquesta casella).

5.7.3 Malaltia domicili

En aquest apartat classificarem totes les demandes que siguin provocades per una malaltia a domicili. Davant de qualsevol demanda, recollirem DNI/CIP, exceptuant situacions com **No contesta, No respira, Convulsions, Ennuegament No pot parlar, Li costa respirar / No pot parlar.**

Existeixen un grup de camps comuns a totes les pestanyes de malaltia domicili, que caldrà confirmar sempre:

- **No contesta.** Cal prémer aquesta casella quan l'alertant informi que l'afectat presenta un estat d'inconsciència o contesti no a la pregunta **"El pacient està conscient? Si li parla li contesta?"**. En aquest cas el programa no deixarà continuar i generarà una resposta directa.

A més, també classificarem 'No Contesta' en aquells incidents en els que comuniquin que hi ha una persona dintre de casa que no agafa el telèfon i no obre la porta i creuen que li ha pogut passar alguna cosa.

- **No respira.** Cal prémer aquesta casella quan l'alertant informi que l'afectat presenta una manca de respiració espontània. En aquest cas el programa no deixarà continuar i generarà una resposta directa.

En qualsevol d'aquestes dues etiquetes no fa falta marcar cap casella més.

Existeixen altres camps comuns a totes les pestanyes de malaltia domicili, que caldrà complimentar en cas necessari, en funció de l'alerta:

Pex: si es selecciona la carpeta respiració es necessari fer constar el desplegable de respiració el nivell corresponent.

Inici problema actual. Es tracta d'un desplegable amb cinc opcions, per situar temporalment l'inici dels símptomes actuals. Cal escollir l'opció adient:

Respiració. Es tracta d'un desplegable amb quatre opcions. Cal escollir l'opció adient:

- Respira amb dificultat/no pot parlar.
- Respira amb dificultat/pot parlar.
- Respira normal.
- No ho sap.

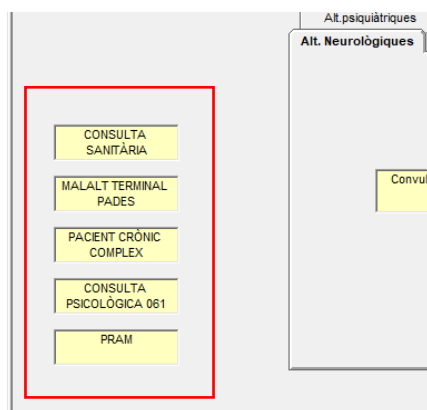
Consciència. Es tracta d'un desplegable amb cinc opcions. Cal escollir l'opció adient:

- Contesta incoherent.
- Sensació de desmai.
- Li donen voltes les coses.
- Contesta normal.
- No ho sap.

CONSULTA SANITÀRIA. Cal prémer aquesta casella sempre que el motiu de la demanda sigui voler realitzar una consulta sanitària. El gestor de demanda preguntarà pel motiu: “*Em pot dir el motiu?*” i intentarà classificar la demanda en les diferents opcions (pestanyes) de la pantalla, **en aquest cas no cal marcar consulta sanitària.**

MALALT TERMINAL PADES (Programa Assistència Domiciliaris Equips de Suport). Cal prémer aquesta casella sempre que l'afectat o alertant refereixi tractar-se d'un malat terminal o estigui assistit per l'equip del PADES.

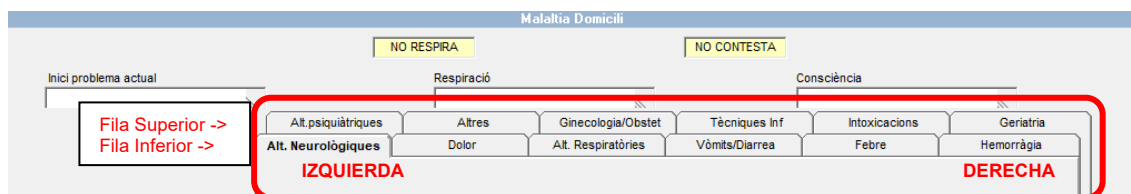
PACIENT CRÒNIC COMPLEX. Cal prémer aquesta casella quan l'afectat o l'alertant s'identifica com a tal. En prémer aquesta casella, no s'assignarà cap intervenció en cap motiu de demanda, i només sortirà per protocol, consulta mèdica. Amb la identificació del grup de risc des de la història clínica compartida l'ús d'aquesta etiqueta serà menor.



CONSULTA PSICOLÒGICA 061. Aquesta casella no s'ha de prémer mai. És d'ús restringit a els psicòlegs del SEM.

PRAM (Prestació D'Ajuda a Morir): Aquesta casella només s'ha de prémer quan alertant s'identifica com a Equip PRAM. (Punt 5.9.24)

Després, a diferència de la via pública trobem una sèrie de fitxes (pestanyes) de grans grups de símptomes tots ells agrupats per aparells (Alt. Respiratòries, Alt. Neurològiques...) o pel símptoma guia (Dolor, febre, hemorràgia...).



Només es pot complimentar una **ÚNICA PESTANYA**. Per aquest motiu cal diferenciar amb claredat quin és el símptoma principal que refereix l'alertant, i prémer la pestanya corresponent.

MAI S'HAN DE COMPLIMENTAR DUES O MÉS PESTANYES EN EL MATEIX INCIDENT. Davant de dubte per l'expressió de mes d'un motiu, que correspongui a més d'una carpeta: escollirem per la fila que estigui més a l'esquerra i si es entre ambos files triarem la inferior.

5.7.3.1 Alteracions neurològiques

Consta d'una etiqueta activable: **CONVULSIONS**.

Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenti un episodi de convulsions (contraccions musculars), que afecti total o parcialment al cos.

Hi ha un desplegable:

- **Desvia la comissura dels llavis quan riu?**
- **Pot aixecar braços i cames?**
- **Se l'entén quan parla?**

Per tant, li haurem d'indicar a l'alertant que demani a l'afectat que rigui, aixequi els braços i cames, i que parli. Les opcions de resposta són: Si, No, No ho sap.

Aquí classificarem totes aquelles demandes en que l'alertant digui que l'afectat ha tingut "una embòlia", "una feridura", "un ictus", té paràlitzat o no sent mig cos, etc.

S'haurà de preguntar **sempre** el temps que fa que ha començat i escollir l'opció correcta al desplegable **"Inici problema actual"**.

En aquesta pestanya, hem de diferenciar entre CONVULSIONS i una possible embòlia, hem de marcar una etiqueta o l'altre de forma individual.

5.7.3.2 Dolor

Consta de dos etiquetes activables:

- **Dolor + Traumatisme últimes 24h. No visitat.** Cal prémer aquesta casella quan l'origen del dolor sigui un traumatisme previ a les últimes 24 hores, i no hagi estat visitat per aquest motiu.
- **Dolor mamari.** Cal prémer aquesta casella quan indiquin dolor, sensibilitat o cremor a la regió de la mama.

A continuació, hi ha tres gràfics que representen la cara, el cos vista anterior i posterior.

Caldrà prémer la zona corresponent en funció de la informació que faciliti l' alertant.

Davant de un dolor toràcic automàticament es bloqueja la pantalla SITREM, i en aquests casos haurem prémer la casella de dolor tòrax. Si hi ha altres dolors associats s'han de enregistrar al camp A.

Quan l'alerta de dolor toràcic entra a través del 112 i han classificat prèviament dolor tòrax, al passar a l'Omega de malaltia domicili es bloqueja i no podem classificar res més.

És important diferenciar i prémer correctament quan l'alertant es refereix a dolor lumbar o dolor renal.

5.7.3.3 Alteracions respiratòries

Consta de tres etiquetes activables:

Dolor Tòrax. Cal prémer aquesta casella quan l'alertant refereixi que a més a més de l'alteració respiratòria, l'afectat també presenta dolor toràctic (en aquest cas no es bloqueja la pantalla de SITREM).

Està cianòtic. Cal prémer aquesta casella quan l'alertant refereixi que l'afectat presenta una coloració blavosa al cos (llavis, dits de les mans...).

Tos, Mocs, Refredat, Malestar general. Cal prémer aquesta casella quan l'alertant refereixi que l'afectat presenta un d'aquests símptomes.

Hi ha un desplegable: **Ennuegament**.

Aquí classifiquem tota demanda per una persona que s'ha ennuegat, ja sigui amb un sòlid o un líquid. En aquest cas caldrà preguntar:

- **“El pacient por parlar?”**

En funció de la resposta que faciliti l'alertant, caldrà obrir el desplegable i escollir l'opció vàlida:

- **No pot parlar**
- **Pot parlar**

Així mateix, hi ha un quadre: **Malalt crònic**. Si l'alertant ens informa que l'afectat pateix alguna malaltia respiratòria crònica, escollirem l'opció adient:

- **Asma**

- **MPOC/EPOC** (Malaltia pulmonar obstructiva crònica/Enfermedad Pulmonar Obstrutiva crònica)

5.7.3.4 Vòmits i diarrees

Consta de quatre etiquetes activables:

- **Vomita tot el que beu/menja**
- **Altres casos al seu entorn** (en el cas que hi ha altres persones afectades per la mateixa simptomatologia)
- **Més de tres deposicions a l'última hora**
- **Més de tres vòmits a l'última hora**

5.7.3.5 Febre

Escollirem aquesta pestanya si l'alertant indica que l'afectat presenta febre.

- **Molèsties urinàries.** Cal prémer aquesta casella quan l'alertant refereixi que a més a més de la febre, l'afectat també presenta molèsties urinàries (coïssor a l'orinar; orinar sovint i poca quantitat...).
- **Vòmits/Diarrees.** Cal prémer aquesta casella quan l'alertant refereixi que a més a més de la febre, l'afectat també presenta vòmits/diarrees.
- **Alteració de la pell.** Cal prémer aquesta casella quan l'alertant refereixi que a més a més de la febre, l'afectat també presenta alguna alteració de la pell (erupció, taques...).

De la mateixa manera, hi ha un quadre de: **Antecedents/Tractaments**. Si l'alertant ens informa que l'afectat a més de la febre presenta alguns dels tres paràmetres, podrà escollir l'opció més adient:

- Post-operat recent (48-72 hores)
- Químio/Radio (quimioteràpia, radioteràpia)
- SIDA/VIH (Síndrome Immunodeficiència Adquirida/Virus Immunodeficiència, Humana)

Alt. psiquiàtriques	Altres	Ginecologia/Obstet	Tècniques Inf	Intoxicacions	Fragilitat
Alt. Neurològiques	Dolor	Alt. Respiratòries	Vòmits/Diarrea	Febre	Hemorràgia

+
Convulsions

+ Molèsties
Urínaries

+ Vòmits/
Diarrees

+ Alteració
de la pell

Antecedents/Tractaments
☐ Post-operat recent
☐ Químic / radio
☐ SIDA / VIH

5.7.3.6 Hemorràgia

Consta de sis etiquetes activables, que ens indiquen diferents localitzacions de sagnat:

- **Boca**
- **Nas**
- **Orina**
- **Anal**
- **Ferida o traumatisme**
- **Altres**

Hi ha també un desplegable: **Quantitat**. Cal indicar la quantitat de l'hemorràgia:

- **Poc** (mocador)
- **Molt** (tovallola)

Hi ha una nota en color vermell: **Si es tracta d'una hemorràgia genital femenina, faci l'interrogatori a la fitxa de Ginecologia/obs.** Sempre que es tracti d'aquest tipus d'hemorràgia, caldrà dirigir-se a la fitxa mencionada.

Alt. psiquiàtriques	Altres	Ginecologia/Obstet	Tècniques Inf	Intoxicacions	Fragilitat
Alt. Neurològiques	Dolor	Alt. Respiratòries	Vòmits/Diarrea	Febre	Hemorràgia

Si es tracta d'una hemorràgia genital femenina, faci l'interrogatori a la fitxa de Ginecologia/obs

Boca

Nas

Orina

Anal

Ferida o
traumatisme

Altres

Quantitat

5.7.3.7 Alteracions psiquiàtriques

Consta de sis etiquetes activables:

- **Agitació**. Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta alteració del comportament. L'afectat no deixa de moure's (agitació psicomotriu).
- **Amenaçador/Agressiu**. Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta agitació amb comportament violent envers ell o envers el seu entorn (auto-heteroagressivitat).

- **Ansietat.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta preocupació i tensió mantingudes d'intensitat variable. Si és d'inici curt i espontani amb crisi recurrent i sensació de mort imminent parlem de crisi d'ansietat.
- **Depressió/ Tristesa.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta ànim decaïgut, manca de ganes de fer res, manca d'il·lusions...
- **Amenaça amb suïcidar-se.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat hagi expressat el sentiment d'un intent d'autòlisi acompanyat d'una idea estructurada, és a dir:
 - “Em tiraré per la finestra”
 - “Tinc la corda preparada per penjar-me”
 - Etc.

Totes aquelles accions que ja hagin sigut **realitzades**, es classificaran a l'Omega corresponent: Accident/Traumatisme.

Una vegada classificat l'incident, haurem de llegir literalment l'apartat inferior esquerre de SITREM: “**No pengi parlarà amb personal sanitari**”.

Recordem que no haurem d'indicar les instruccions de SITREM a l'alertant, és a dir:

- **No dir** a l'alertant que s'avisa a Mossos.
- **No dir** a l'alertant que li enviem una ambulància.

Finalment, transferirem aquesta trucada mitjançant el botó de CONSULTA.

- **Ideació auto-lítica / idees de mor.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat expressi/verbalitzi idees de mort, sense idees estructurades, és a dir: “*Ja no vull viure més*” “*Estic cansat/da de la vida, m'agradaria acabar amb ella*”, etc.
Al marcar aquesta casella, és important **NO deixar en cua** dita consultoria, hem de restar a l'espera que Taula de Salut Mental agafi la trucada.
- **Testimoni Suïcidi consumat:** Cal prémer aquesta casella quan es compleixi alguna d'aquestes situacions:
 - La persona amb qui parlem és l'afectada i informa d'haver estat exposada directament a un suïcidi consumat en el darrer any. Entenent com a “exposició directa” el fet d'haver patit una mort per suïcidi d'alguna persona del seu entorn proper (amistats, familiars, parella, etc.).
 - La persona amb qui parlem és l'alertant i informa que la persona afectada ha tingut una exposició directa a suïcidi consumat en el darrer any i es compleix alguna d'aquestes situacions:
 - Alertant informa que la persona afectada ha estat exposada directament a un suïcidi consumat i aquest l'ha expressat/informat de missatges de comiat Exemples: “No tornaré a l'escola/feina”, “No cal que em busqueu, quan em trobeu ja serà tard”, “No val la pena continuar”, etc.
 - L'alertant refereix que la persona afectada ha expressat missatges que poden ser entesos com acomiadament, sigui verbalment o amb qualsevol suport (WhatsApp, publicacions a les xarxes, etc.).

- Alertant informa de la impossibilitat de contacte per part seva i/o de l'entorn amb la persona afectada. S'ha intentat contactar amb la persona afectada d'alguna manera i no ha estat possible.

Quan marquem la casella Testimoni de Suïcidi Consumat transferirem la trucada mitjançant el botó de CONSULTA, és important NO deixar en cua i haurem d'esperar a transferir amb Personal Sanitari, si després d'un temps prudencial no podem transferir la trucada consultarem a l'equip de Coordinació

- Altres.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta altres alteracions psiquiàtriques que no hem pogut classificar en les altres etiquetes.

5.7.3.8 Altres

Si no hem pogut classificar l'incident en qualsevol altra pestanya, haurem d'anar a aquesta.

En aquesta carpeta no es pot clicar cap altre ítem de la mateixa o altres pestanyes.

Consta de nou etiquetes activables:

- Alteracions de la glicèmia i Alteracions tensió arterial:** En els dos casos es classificarà amb la nova etiqueta corresponent quan l'alertant informi sols de la detecció d'alteració dels valors. Si existeix simptomatologia associada, es classificarà en relació a aquesta i es recollirà el valor de la constant al camp A. Després de classificar el traspàs de la trucada s'ha de realitzar mitjançant del botó consultoria.
- Alteracions de la glicèmia:** Cal triar els valors d'aquesta casella quan l'afectat informa una alteració del sucre – glicèmia. Es creen tres etiquetes:
 - Alteracions Glicèmia < 60
 - Glicèmia entre 60 i 300
 - Glicèmia > 300

- **Alteracions tensió arterial.** Cal triar els valors d'aquesta casella quan l'afectat informa que pateix una hipertensió arterial, o no, i **presenta xifres de tensió arterial** que vol consultar. Es creen quatre etiquetes:

- TA Major a 210
- TA entre 160 i 210
- TA entre 90 i 159
- TA menor a 90

- **Possible èxitus.** Cal prémer aquesta casella quan l'alertant informa que l'afectat ha mort i confirma aquesta situació per tractar-se d'una mort esperada (pacient terminal...). Davant d'aquesta situació, és de **caràcter obligatori** preguntar a l'inici de trucada: “*És una mort esperada?*” si la resposta és SI, recollirem dades de l'afectat i classifiquem aquesta etiqueta. Si la resposta és NO, només recollirem EDAT i SEXE i tipificarem 'No Respira'.
- **Edema llavis/parpelles.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat informa que presenta una inflamació dels llavis i/o parpelles.
- **Mareig.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat informa que presenta malestar general inespecífic, dificultat per mantenir-se dret, que pot acompanyar-se de nàusees, pal·lidesa i sudoració freda, de vegades també, de vòmits, mal de cap, ansietat.
- **Arrítmies.** Cal prémer aquesta casella quan l'alertant informa d'alteració del ritme del cor: palpitations, ritme més ràpid (taquicàrdia), ritme més lent (bradicàrdia).
- **Altres.** Cal prémer aquesta casella quan l'afectat presenta qualssevol alteració que no hem pogut classificar en les altres etiquetes.
- **Molèsties urinàries sense febre.** Cal prémer aquesta casella quan l'alertant és un home i informa de coïssor a l'orinar, augment de la freqüència urinària, urgència urinària, sang a l'orina. Davant de símptomes en dones, la carpeta correcta serà 'Ginecologia/Obstetrícia' (Cistitis no complicades).
- **Reacció al·lèrgica:** marcarem aquesta etiqueta quan ens informin de reaccions al·lèrgiques que es poden relacionar amb malalties de l'aparell respiratori, malalties a la pell (urticària) o amb reaccions greus d'inici ràpid que afecten conjuntament la pell, l'aparell respiratori i el cardiovascular (anafilaxi). SEMPRE que seleccionem aquesta etiqueta o la de Edema llavis / parpelles preguntarem si existeix o no dificultat respiratòria.

5.7.3.9 Ginecologia / Obstetrícia

OBSTRETICIA ESTÁ EMBARASSADA

En cas que la afectada no sàpiga si està embarassada s'ha de marcar a la part de ginecologia.

El primer pas es esbrinar en quin trimestre de l'embaràs es troba l'afectada.

Habitualment la alertant ens indicarà del temps en setmanes de però cal introduir la dada en trimestres

Caldrà escollir l'opció més adient en funció de la informació que faciliti l'alertant:

- **1r trimestre (Fins les 12 Setmanes de gestació)**
- **2n trimestre(12 – 24 Setmanes de Gestació)**
- **3r trimestre (>24 Setmanes de Gestació)**

Després cal introduir la situació que explica l'alertant, caldrà escollir l'opció més adient en funció de la informació que faciliti l'alertant:

- **Hemorràgia.** Tant si es presenta en el decurs d'un embaràs com no.

- Poc (mocador)
 - Molt (tovallola)
- **Part en curs.**
- **Dolor abdominal.**
- **Contraccions.**
- **Ha trencat aigües:**
 - Sortida de líquid per la vagina, **en cas que expliquin aigües brutes, o vermelloses, marcar: “Hemorràgia Molt”**
- **Augment de secreció, molèsties i/o picor vaginal i genitals externs.**
 - L'afectada pot referir augment de la secreció vaginal (blanquinosa, amb grumolls, aspecte de iogurt, inodora), pruït vaginal, coïssor a l'orinar, coït dolorós, i sensació de coïssor als genitals externs.

GINECOLOGIA NO ESTÁ EMBARASSADA

Classificarem en aquest apartat les situacions NO relacionats amb l'embaràs.

Directament escollirem la situació que ens explica l'alertant.

Hi ha un quadre on trobarem diferents situacions. Caldrà escollir l'opció més adient en funció de la informació que faciliti l'alertant:

- **Hemorràgia:**
 - **Poc (mocador)**
 - **Molt (tovallola)**
- **Picor o molèsties**
- **Augment secrecions**
- **Canvis a la menstruació**
 - **Altres:** Especificar al camp A la situació indicada per l'alertant.

Seguir les instruccions donades per SITREM, una vegada classificat qualsevol de les situacions plantejades dins d'aquesta etiqueta.

5.7.3.10 Tècniques d'infermeria

Accedirem a aquesta pestanya sempre que es sol·liciti una intervenció per practicar una tècnica d'infermeria.

Consta de quatre quadres:

- **Injectables.** Quan l'alertant sol·liciti un infermer a domicili per administrar un injectable. Caldrà interrogar totes les opcions que consten en aquest quadre i prémer la o les opcions, segons la informació que ens faciliti l'alertant:
 - **Té prescripció mèdica.**
 - **Li han receptat al Sistema Públic.**
 - **Li han receptat al Sistema Privat.**
 - **Està programat.**
 - **No està programat.**
- **Sonda:** tub fi que s'introdueix en una persona per administrar-li aliments, extreure líquids o explorar una cavitat.

- **Sonda Vesical.** Quan l'alertant sol·liciti un infermer a domicili per alguna qüestió relacionada amb una sonda vesical (tub que s'introdueix per la uretra fins la bufeta de l'orina). Cal prémer l'opció més adient en funció de la informació que faciliti l'alertant:
 - **Obstrucció.** La sonda vesical s'ha obstruït i no hi ha sortida d'orina.
 - **Febre.** Portador de sonda vesical que a més presenta febre.
 - **Canvi.** Cal fer un canvi de sonda vesical programat.
 - **Hematúria.** Portador de sonda vesical que a més presenta sang a l'orina.
- **Sonda nasogàstrica.** Quan l'alertant sol·liciti un infermer a domicili per alguna qüestió relacionada amb una sonda nasogàstrica (tub que s'introdueix pel nas/boca fins l'estómac). Cal prémer l'opció més adient en funció de la informació que faciliti l'alertant:
 - **Obstrucció.** No és possible administrar aliment per la sonda.
 - **Canvi.** Cal fer un canvi de sonda nasogàstrica programat.
- **Cures.** Quan l'alertant sol·liciti un infermer a domicili per alguna qüestió relacionada amb una cura. Cal prémer l'opció més adient en funció de la informació que faciliti l'alertant:
 - **Retirada de punts.**
 - **Cremades.**
 - **Cànules traqueals.** Cures relacionades amb cànules introduïdes al coll per permetre la respiració.
 - **Colostomia.** Cures relacionades amb portadors de colostomia (anus obert a paret abdominal, amb bossa recol·lectora).
 - **Drenatges.** Cures relacionades amb ferides que porten tubs per permetre la sortida d'exsudat.
 - **Altres cures.** Cal prémer aquesta opció quan l'afectat sol·licita qualsevol cura que no hem pogut classificar en les altres opcions.

Alt. Neurològiques	Dolor	Alt. Respiratòries	Vòmits/Diarrea	Febre	Hemorràgia
Alt. psiquiàtriques	Altres	Ginecologia/Obstet	Tècniques Inf	Intoxicacions	Fragilitat

Injectables ☐ Té prescripció mèdica ☐ Li han receptat al Sistema Públic ☐ Li han receptat al Sistema Privat ☐ Està programat ☐ No està programat	Sonda vesical ☐ Obstrucció ☐ Febre ☐ Canvi ☐ Hematúria Sonda Nasogàstrica ☐ Obstrucció ☐ Canvi	Cures ☐ Retirada de punts ☐ Cremades ☐ Cànules traqueals ☐ Colostomia ☐ Drenatges ☐ Altres cures
---	---	---

5.7.3.11 Intoxicacions

Aquí classificarem totes les demandes causades per una intoxicació ja sigui per ingesta, inhalació o per via parenteral. Davant d'una intoxicació que afecti a l'estat de consciència, essent així un NO CONTESTA o bé NO RESPIRA, es tipificarà sempre l'estat de consciència.

Consta de nou etiquetes activables:

- Heroïna
- Cocaïna
- Alcohol
- Fàrmacs
- Productes de neteja
- Gas Domèstic
- Bolets
- Pesticides
- Altres.

5.7.3.12 Fragilitat

Aquesta pestanya cal escollir-la en trucades rebudes de Residències Geriàtriques, Residències de discapacitat intel·lectual i Residències psiquiàtriques (només en els casos de pacients de llarga estada o institucionalitzats, NO aguts) que demanen Transport Sanitari (tipus de recurs SVB).

Procediment de residències geriàtriques especificat a l'apartat 5.9.10 Procediment Atenció Residents amb suport Consultoria geriàtrica.

5.7.4 Atenció No Presencial No Urgent

Quan s'identifica una alerta amb un motiu de demanda referit als específics de la pantalla d'Atenció no urgent, el gestor de demanda de primer nivell ha de procedir d'acord amb les següents indicacions.

5.7.4.1 Consulta sanitària (requadre esquerre)

S'han de recollir les dades segons punts 5.1 (Recepció inicial) a 5.5 (Dades de l'afectat). S'ha de tenir en compte:

- Quan l'alertant és personal sanitari es concreta l'extensió i/o es demana un telèfon directe si existeix.
- En el cas de les consultes relacionades amb el VIH o la SIDA o línia verda (drogues i alcohol), si el pacient no es vol identificar, actuarem igual que a una consulta administrativa en quan a la recollida de dades de filiació (nom de l'afectat).
- En el cas de consell al viatger només confirmar telèfon i demanar Municipi, Nom de pila.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia "**aguda**" relacionada amb alguna de les etiquetes de la pantalla d'Atenció Urgent no urgent, el procediment de classificació serà l'habitual del 061, com Malaltia o Accident i no com consulta sanitària d'Atenció no urgent.

Drogues i Alcohol: Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

- Informació/consultes relacionades amb qualsevol tipus de drogues.
- Informació/consultes relacionades amb l'addicció a l'alcohol.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Si la consulta es refereix a una simptomatologia "**aguda**" relacionada amb drogues i alcohol es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l'alertant.

Exemples:

- Dubtes de familiars o entorn de l'afectat en relació amb com poden reconèixer que el seu familiar, amic, company... té algun d'aquests problemes.
- Informació relacionada amb l'aparició de noves drogues o notícies mediàtiques.
- Consultes sobre possibles hàbits additius.

- Què puc fer, on puc anar per deshabituarme?
- Quin tipus de centre tracten aquests problemes?

A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb alcohol i altres tipus de drogues.

Cal remarcar que, en aquest concepte, parlem d'addiccions a drogues i/o alcohol, per diferenciar-les d'altres tipus d'addiccions que es recullen en altres apartats.

Especificitat de la via d'entrada de les consultes "Drogues i Alcohol":

La trucada pot entrar directament pel 061 o per derivació al 061 del Telèfon de la Línia Verda.

El Telèfon de la Línia Verda és el servei d'atenció telefònica que la Subdirecció General de Drogodependències posa a disposició del ciutadà i es correspon amb el 900 900 540. És un telèfon gratuït que funciona 24 hores: de 9 a 20 h de dilluns a divendres és atès pels professionals del Departament de Salut i de 20 a 9 h, caps de setmana i festius, les 24 hores està derivat al 061 Catsalut Respon que és qui dona resposta.

Les trucades que entren al 061 des del 900 900 540, es visualitzen al display de terminal com "Línia Verda".

La nostra actuació serà la mateixa, però aquest tipus d'usuaris, estan exempts de facilitar dades si no volen, tot i així, les hem de demanar independentment del telèfon per on hagi trucat l'alertant.

Interrupció voluntària del embaràs (IVE)

061 CatSalut Respon és un dels recursos sanitaris on els ciutadans de Catalunya poden demanar assessorament i informació sobre la IVE.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

- Informació/consultes relacionades amb la IVE.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia "**aguda**" en afectades que manifesten haver rebut un tractament d'IVE recent, es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l'alertant.

Exemples:

- Dones que demanen informació sobre la tècnica de l'IVE i a les que hem de fer una atenció i acollida informant-les d'on han d'anar.
- Consultes relacionades amb els diferents tipus d'IVE (farmacològic/quirúrgic)
- Quins efectes secundaris donen?
- Informació sobre la normativa actual?
- Quin és el protocol de l'IVE farmacològic?
- On fan els IVES quirúrgics? Clíriques que estan acreditades i contractades pel CatSalut.
- Consultes relacionades amb símptomes POST-IVE (molèsties, dolor, pèrdues...).

A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb l'IVE.

Vacunes. Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

- Informació/consultes relacionades amb la informació, dubtes o qualsevol aspecte referit a les vacunes generals, les pròpies del calendari de vacunació oficial de Catalunya i campanyes de vacunació concretes (vacunació grip, vacunació brots epidèmics...).

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

No entren en aquest apartat les vacunes relacionades amb viatges internacionals, que seran codificades com Consell al Viatger.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia “**aguda**” en afectats que refereixin haver rebut una vacuna recentment, es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l'alertant.

Exemples:

- Quan toca una determinada vacuna?
- Quan puc vacunar al nen?
- On he d'anar?
- Puc vacunar al nen si té febre, està constipat, té mocs?
- Li farà alguna reacció?
- Ahir li vaig posar la vacuna...i ara està amb dècimes o neguitós. És normal? Què puc fer?
- Preguntes sobre vacunes concretes:
- Grip
- Vacuna en nenes d'11-12 (sisè de primària, que correspon a la vacuna del papil·loma)
- Brots epidèmics
- Vacunes en les quals el calendari especifica una població concreta per administrar-la i els pediatres indiquen una vacunació més massiva (per exemple la vacuna de la varicel·la). En aquests casos, la consulta pot estar relacionada en com l'han de comprar i si l'han de pagar.
- Noves vacunes i/o modificacions calendari vacunal.

Consell als Medicaments. Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

- Qualsevol informació/consulta sobre medicaments.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Si la consulta es refereix a una simptomatologia “**aguda**” per ingesta d'un fàrmac, accidental o autolítica, es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l'alertant.

Exemples:

- Consultes en les que el ciutadà comenta dubtes en relació amb la dosi d'un medicament que ha de prendre.
- Consultes amb dubtes en relació amb la coincidència de diferents fàrmacs.
- Dubtes en relació amb possibles efectes secundaris.
- Consulta en relació amb la presa d'algun medicament i la coincidència amb un període de lactància.
- Consulta en relació amb la presa d'algun medicament i la coincidència amb un embaràs.
- Dubtes relacionades amb els anticonceptius hormonals.
- Consultes relacionades amb la "pastilla del dia després" (post coital).
- Informació d'algun nou fàrmac (en general coincident amb notícies aparegudes en mitjans de comunicació).
- Consultes de pacients o familiars de pacients d'Alzheimer que tenen problemes per que els hi dispensin la medicació que prenen per aquesta malaltia.

A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes sobre medicaments.

ITS/Infeccions transmissió sexual

Identifiquem amb aquest concepte aquelles malalties que es transmeten per via sexual i son causades per virus, bacteries o paràsits. Les infeccions de transmissió sexual o ITS son: sífilis, gonorrea, clamídia, xancre tou, granuloma inguinal, herpes genital, condilomes acuminats (també coneguts com berrugues genitals), mol·lusc contagiós, hepatitis A, B i C, Sida (VHI), tricomoniasis, pediculosi púbica i sarna, virus del papil·loma humà.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Donat que tenim un identificador específic per la SIDA (VHI) utilitzarem l'etiqueta ITS/ Infeccions de transmissió sexual per a totes les consultes, tant des del punt de vista de petició d'informació com de consultes concretes relacionades amb aquestes malalties, excepte per a la SIDA/VHI.

Exemples:

- Consultes relacionades amb el risc de contagi per pràctiques sexuals de risc (sense mesures preventives,...).
- Preguntes sobre el període d'incubació.
- Informació i consultes en relació als diferents signes i símptomes de les diferents infeccions.
- Consells i informació sobre prevenció, diagnòstic i tractaments.
- Dubtes, consells i informació en relació a la profilaxis post exposició.
- Informació en relació als centres on realitzar les proves diagnòstiques.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia "**aguda**" en pacients afectats per infeccions de transmissió sexual, es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l' alertant.

Addicció al joc/Ludopaties

Inclou aquelles situacions que afecten a la capacitat de control sobre el joc i en la que l'impuls de jugar augmenta progressivament ocupant cada cop més àrees de la vida quotidiana (joc patològic). Existeix una addicció al joc, el que es coneix com ludopatia.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Exemples:

- Tinc un familiar amb problemes amb el joc, què puc fer? on puc anar?
- Tinc problemes amb el joc, què puc fer? on puc anar?
- El meu familiar no reconeix que té un problema amb el joc, què es pot fer?
- Què puc fer per aconseguir que no em deixin entrar en un casino?
- A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb el joc patològic.

Tabac. Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

- Informació/consultes relacionades amb el tabac.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Exemples:

- Consultes relacionades amb la normativa del tabac.
- Consultes relacionades amb els diferents fàrmacs per ajudar a deixar de fumar.
- Consultes relacionades amb l'hàbit tabàquic i l'embaràs o la lactància.
- Consultes de fumadors que volen deixar de fumar, saben que 061 CatSalut Respon té un servei de suport telefònic ("QUIT LINE") i volen accedir-hi.
- Consultes de fumadors que volen deixar de fumar i no saben el que han de fer.
- Consultes relacionades amb les cigarretes electròniques.
- A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb el tabac.

Proves diagnòstiques

Moltes vegades, els ciutadans que s'han de sotmetre a una prova diagnòstica consulten al 061 Catsalut Respon per aclarir dubtes relacionades amb les mateixes. Parlem de proves com: ecografies, gastroscòpies, analítiques, colonoscòpies, TACs, ressonància magnètica, etc.

Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

Informació/consultes que tinguin relació amb proves diagnòstiques, diferents a reclamacions sobre llista d'espera de les mateixes.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Exemples:

- Consultes per saber en què consisteix exactament una determinada prova que li han prescrit (li han demanat que es faci).

- Consultes per saber com es fan les diferents proves diagnòstiques i en alguns casos si els hi faran sedació (ex. colonoscòpies,...).
- Consultes, molt freqüents, sobre quin tipus de preparació prèvia han de fer: si poden o no menjar o beure alguna cosa abans de la prova i fins quan; si han de prendre algun tipus de “papilla” (contrast) com i quan; si han de prendre algun laxant, quant i que notaran, etc.
- Informació relacionada amb els possibles efectes que la prova pot tenir: si es tracta d’una prova radiològica que els hi pot passar, si han de prendre contrast quant trigaran a eliminar-lo, etc.
- Informació sobre si han d’anar acompanyats o no.
- Dubtes en relació a la realització de determinades proves en dones embarassades i amb els nens.
- Informació en relació a si poden seguir prenent la seva medicació habitual.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia “**aguda**” en pacients als que se’ls hi ha realitzat una prova diagnòstica, es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l’alertant.

Seguiment

Aquesta etiqueta la utilitza exclusivament infermeria. No s’ha de codificar cap trucada entrant amb aquesta etiqueta.

Consell al Viatger sanitària

Aquesta casella, és d’ús exclusiu per a Gestors Administratius o Personal Sanitari. Els Gestors de Demanda de Primer Nivell, només faran ús de la casella ‘Consell al Viatger administrativa’ (5.9.28.1.3.4 Consell al Viatger).

HIV/SIDA

Les sigles VIH i SIDA es corresponen respectivament a “Virus de la Immune deficiència Humana” i “Síndrome de Immune Deficiència Adquirida”, i es refereixen a l’agent i al conjunt de malalties que produeix.

Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

Informació/consultes relacionades amb els diferents aspectes de la malaltia causada pel VIH.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia “**aguda**” en pacients portadors del virus (VIH +) o malalts de SIDA es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l’ alertant.

Davant de la classificació d’aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP), tot i que el usuari que truquin per aquesta casuística, poden no donar les dades si no volen.

Exemples:

- Com es contagia?
- Què puc fer per prevenir-la?

- He tingut una relació sexual de risc. Què he de fer?
- Com es diagnostica?
- Quins centres o farmàcies fan la prova de la SIDA?
- Quins símptomes té la malaltia?
- Què és això de la prova ràpida de la SIDA? On i quan me la puc fer?

A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb diferents aspectes de la malaltia causada pel VIH.

Especificitat de la via d'entrada de les consultes "VIH/SIDA":

La trucada pot entrar directament pel 061 o per derivació al 061 del Telèfon de la SIDA.

El Telèfon d'informació confidencial sobre la SIDA és el Servei d'Atenció Telefònica que el Departament de Salut disposa al ciutadà per realitzar consultes sobre la malaltia, i es correspon amb el 900 212 222.

És un telèfon gratuït i confidencial i la seva resposta correspon al 061 CatSalut Respon les 24 hores.

Les trucades que entren al 061 des del 900 212 222, es visualitzen al display de terminal com "HIV/SIDA".

La nostra actuació serà la mateixa, independentment del telèfon on hagi trucat l'alertant.

Consulta sanitària

Utilitzarem aquesta etiqueta per a totes aquelles consultes que no són Malaltia ni Accident, i que tampoc disposen d'una etiqueta específica a la pantalla d'Atenció no urgent.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Salut mental/addiccions/T. Cond. Alimentaria

061 Catsalut Respon atén, freqüentment, consultes dels ciutadans que demanen informació, assessorament, consells i recursos relacionats amb la salut mental i que englobarien la patologia mental, les socioaddiccions i els trastorns de la conducta alimentària. La demanda pot venir del propi pacient, de l'entorn familiar, amics o del propi sistema sanitari.

Salut Mental: És, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), aquella situació de benestar en el que l'individu és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i es capaç d'oferir una contribució a la seva comunitat. Quant hi ha una alteració amb algun d'aquets aspectes, parlem d'un trastorn mental.

Els trastorns mentals tenen un important impacte en la qualitat de vida de la persona i afecten tots els àmbits de relació interpersonal (familiar, laboral i social).

Socioaddiccions: Són trastorns de dependència vinculats a usos, costums o activitats **no** relacionades amb la ingesta de substàncies químiques i que es caracteritzen per la pèrdua del control per part de la persona respecte a una activitat (en aquest cas estem parlant de l'addicció al sexe, a internet, a la compra compulsiva, a l'ús del mòbil, etc.).

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA): Tals com l'anorèxia nerviosa (deixar de menjar), la bulímia nerviosa (provocació del vòmit després de menjar) i els trastorns per afartament; són patologies causades per molts factors que afecten, majoritàriament, nens, nenes, dones joves i, cada vegada més, els adults.

Amb aquest concepte incorporaren els motius relacionats amb:

Informació i/o consultes relacionades amb la salut mental, les socioaddiccions i els trastorns de la conducta alimentària.

Davant de la classificació d'aquesta etiqueta, sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Exemples:

- Consultes relacionades amb els diferents tipus de símptomes dels diferents tipus de problemes indicats.
- Dubtes de familiars i entorn de l'afectat en relació a possibles conductes patològiques.
- Informació i consells en relació a què és pot fer i quina actitud han de tenir aquells que envolten al pacient.
- Preguntes relacionades amb els diferents centres on poden acudir.
- Associacions de suport.
- Altres informacions i consultes relacionades amb aquests temes.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia “**aguda**” en pacients amb problemes de salut mental, sociaddiccions o trastorns de la conducta alimentària, es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l'alertant.

SUVEC (Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya)

Quan un professional sanitari ha de notificar una malaltia de declaració obligatòria o un brot sanitari de qualsevol tipus ha de contactar amb les Unitats de Vigilància Epidemiològica Territorials (un per cada Regió Sanitària) en horari de 8 a 15 hores els dies laborables.

Les alertes de SUVEC entraran a través skill. Per tant, els gestors i gestores de demanda de 1º nivell s'hauran de logar per desplegable al entrar en SITREM com:

- Gestor de Demanda + SUVEC

Les trucades entrants a 1º nivell identificades com SUVEC ho faran de la mateixa manera que les trucades provinents del ICO.



Protocol de presentació:

En funció de la franja horària estipulada per manual de GD → **SUVEC, Bon dia / Bona tarda / Bona nit.**

Hauran de demanar les dades imprescindibles per gestionar una alerta **d'Atenció No Presencial No Urgent** (Administrativa) classificant la trucada com **SUVEC Administratiu** i transferir la trucada pel botó de consultoria que traspassa a gestora i/o gestor de Consulta Administrativa.

Si l'alerta entrés a través del 061 actuarem de la següent manera:

- Alerta personal Centre Sanitari (CAP / CUAP / HOSPITAL...):
 - **Classificar la trucada com At. No Pres. No Urgent/administrativa** recollint les següents dades:
 - Municipi+ Nom del Metge-telèfon de contacte+ Extensió. Camp A
Nom de la malaltia
 - **Traspassarem pel botó de consultoria a gestora i/o gestor de consulta administrativa** i no deixarem mai en cua.
- Alerta personal Unitats Assistencials SEM:
 - **Classificar la trucada com At. No Pres. No Urgent/ Consulta Sanitària** recollint les següents dades:
 - Municipi+ Adreça desconeguda+ Identifiquem la Unitat. Camp A
Nom de la malaltia
 - **Traspassarem la trucada a infermeria pel botó de consultoria.**

En el cas de rebre una trucada i que l'alertant **NO** sigui personal sanitari crearem un nou incident com a :

- At. No Presencial No Urgent / Consulta Sanitària recollint totes les dades:
 - Municipi + Adreça + Filiació de l'afectat.

Transferirem la trucada a Pr3 explicant breument al camp A les dades facilitades per l'alertant. **NO CLASSIFICAREM COM A SUVEC**

Desplegable Campanya sanitària

Aquest desplegable s'ha d'utilitzar **NOMÉS** quan 061 CatSalut Respon així ho indiqui i pel motiu que es notificarà al qual s'assignarà un número.

La imatge mostra una interfície d'usuari amb diversos botons de navegació. Els botons inclouen: 'transmissió sexual', 'Socioaddiccions / T.cond.alimentària', 'dispensació de fàrmacs', 'Consell medicaments', 'SUVEC', 'HIV/SIDA', 'Proves diagnòstiques', 'Consulta Administrativa Incidència COVID', 'Cribatge de Càncer i Neonatal', 'Consulta Sanit. PRAM', i 'Campanya Sanitària'. El botó 'Campanya Sanitària' està destacat amb un rectangle vermell.

5.7.4.2 Consulta administrativa (requadre dret)

Davant d'una consulta administrativa, demanarem telèfon, municipi amb adreça 'desconegut' i nom de pila, a excepció de les Traduccions.

La consulta administrativa té dos desplegable i etiquetes:

Desplegable Campanya administrativa

Aquest desplegable s'ha d'utilitzar **NOMÉS** quan 061 Salut Respon així ho indiqui i pel motiu que es notificarà al qual s'assignarà un número.

Actualment està activa la campanya COVID i es classificaran a aquesta campanya les trucades que facin referència al COVID **sense simptomatologia**.

Si la via d'entrada és a través del 112, haurem de classificar "Campanya COVID" i prémer la etiqueta de "Consulta administrativa" i desmarcar la classificació del 112 (habitualment queden classificades com "Consulta Sanitària").

Traduccions

061 CatSalut Respon pot rebre peticions de serveis de traduccions de qualsevol centre sanitari de la xarxa sanitària pública de Catalunya.

El servei el pot sol·licitar qualsevol professional que treballi en el centre i que atengui a un ciutadà estranger tingui dificultats de comunicació per l'idioma.

Davant d'aquesta demanda, hem de demanar una extensió del Dr/Dra/DUI que demani dita traducció.

Al prémer el botó de "Traduccions", s'obre un diàleg amb una pregunta:

El pacient que s'ha de traduir està amb vostè?

Al desplegable "Resposta a escollir" marcar la adient en cada cas:

- Sí, està amb l'alertant
- No, no està amb l'alertant

I seguir les indicacions del Sitrem.

També, podem rebre trucades que demanin un intèrpret de llengua de signes. En aquest cas, també, premerem la etiqueta "Traduccions".

Totes les traduccions relacionades amb Consulta Administrativa s'han de realitzar a través del Servei de Traducció.

Consell al Viatger

Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

Informació/consultes relacionades amb el risc sanitari dels viatges internacionals i les mesures sanitàries preventives a prendre.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia “**aguda**” en afectats que manifesten haver estat en un altre país últimament, es classificarà a SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l'alertant.

Exemples:

- Com s'ha de fer el tractament o la prevenció (quimioprofilaxi) per la malària o el paludisme.
- Quina durada té l'efecte de les vacunes?
- Quan temps abans d'un viatge ens hem de vacunar?
- Consultes relacionades amb dubtes sobre vacunació i viatges en nens i embarassades.
- Viatjo a un determinat país, m'he de vacunar d'alguna cosa?

A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb el risc sanitari dels viatges internacionals.

Davant de qualsevol consulta sobre el consell al viatger:

*Confirmar numero de telèfon + Municipi + Nom de Pila + Classificar trucada com At. No presencial no Urgent + **Consell al viatger** (casella administrativa) i posar al camp 'A' el destí del viatger + Botó consulta + Transferir, després de 4 tons ho deixarem en cua.*

Problemes en la dispensació de fàrmacs

061 CatSalut Respon és un dels referents als que acudeix el ciutadà quan va a una o més farmàcies i no troba o no li poden dispensar algun medicament dels que li ha prescrit el seu metge.

Les causes poden ser diverses: des proveïment d'algun fàrmac (no hi ha en el mercat per algun problema concret); problemes en la distribució (tot i que els laboratoris en tenen, les distribuïdores tenen algun problema i no arriba a les farmàcies); medicaments cars que les farmàcies no tenen en estoc.

Incorporarem en aquest concepte, tota trucada d'un ciutadà que ens fa perquè no troba algun medicament en les farmàcies i que no està relacionat amb un problema amb la recepta.

Cribratge Càncer

061 CatSalut Respon és un telèfon de referència per rebre informació o consultar dubtes al que els ciutadans de Catalunya es poden dirigir per fer consultes sobre els diferents Programes de detecció precoç de diferents tipus de càncer que realitza el Departament de Salut. Els programes de detecció precoç o cribratge de càncer consisteixen en oferir als grups de persones que tenen un risc més alt de patir un tipus de càncer que es facin una prova que permet detectar algun signe precoç d'aquest càncer

Aquests programes actualment són:

- Programa de detecció precoç de càncer de mama.
- Programa de detecció precoç de càncer de coll d'úter.
- Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte.

Aquestes persones reben, habitualment en el seu domicili, una carta en la que se'ls convida a la realització de la prova de detecció, indicant el què han de fer.

El nostre servei està sempre referenciat com un contacte per resoldre els dubtes o rebre una major informació.

Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

Informació/consultes relacionades els Programes de detecció precoç de càncer de mama, coll d'úter, colon i recte.

Altres informacions/consultes relacionades amb altres tipus de càncers.

Si la consulta es refereix a una simptomatologia "aguda" en pacients que pateixen un càncer, es classificarà SITREM com correspongui, Malaltia o Accident, segons el motiu actual expressat per l'alertant.

Exemples:

- He rebut una carta que hem diu que m'he de fer una prova. De què es tracta?
- Quin tipus de prova és?
- Què passa si no me la faig?
- Ja m'han fet aquesta prova (el meu metge), cal que me la torni a fer?
- Què passarà si em surt alguna cosa?

A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb els programes esmentats i altres tipus de càncers.

Voluntats Anticipades

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, s'adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en que les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat. Queden reflectides en un document conegut com **Document de Voluntats Anticipades (DVA)**.

L'objectiu dels documents de voluntats anticipades és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l'hora de respectar-les.

Marcarem aquesta etiqueta en totes les consultes dels ciutadans o dels professionals que arribin a 061 CatSalut Respon en relació a aquest tema i sempre demanarem totes les dades (Telèfon, Municipi, Adreça, DNI/CIP).

Els ciutadans poden trucar a 061 CatSalut Respon per demanar informació com per exemple:

- Com s'ha de fer el document de voluntats anticipades?
- Què puc dir i demanar en aquest document?
- L'he de fer amb un notari?
- Quants testimonis han de signar?
- Què he de fer per registrar-lo?
- Els metges que m'atendran en el futur ho podran consultar?
- Altres dubtes relacionades amb les voluntats anticipades.

També podem rebre trucades dels professionals sanitaris que manifestin dubtes en relació al DVA o bé, que no sàpiguen en quin lloc poden consultar el DVA d'un pacient.

Consulta administrativa

Abans de classificar com una consulta administrativa hem d'assegurar que no hagi símptomes o consulta sanitària associada, interrogarem sobre si presenta símptomes o vol realitzar una consulta amb personal sanitari.

¿L'afectat presenta algun símptoma en aquest moment?, si la resposta es afirmativa haurem de classificar en relació a la demanda associada.

La petició sobre centres oberts a les zones: Alt Pirineu, Plana de Lleida, Cadaqués i Segur Calafell, abans d'informar del centre, preval l'operativitat del centre segons GCS recollit al punt **5.14 ACD i GCS (apertura de centres tancats, metges localitzables)**.

S'ha d'utilitzar aquesta etiqueta per a totes aquelles consultes de caràcter administratives relacionades amb el sistema sanitari. Parlem de consultes del tipus: Informació de centres; farmàcies de guàrdia; dispensació errònia de fàrmacs; llistes d'espera; reclamacions del SEM (d'incidents tancats) o informació del SEM; reclamacions externes; consultes d'acreditació i assegurement; prestacions de l'asseguradora o d'accessibilitat; carpeta personal de salut (o La Meva Salut com es diu ara); servei d'interpretació o qualsevol altre consulta administrativa.

Davant de reclamacions d'objectes perduts a les ambulàncies, es procedirà a tipificar 'Consulta administrativa'

- Informació centres sanitaris (guia de centres):

Informació/consultes sobre centres sanitaris, associacions o diferents organismes en les que es demana, adreces, telèfons, horaris, etc.

- Farmàcies de Guàrdia:

Informació/consultes sobre farmàcies properes (horari laboral) o farmàcies de guàrdia (horari no laboral).

- Llista d'Espera:

Quan a un pacient li han de realitzar algun procediment (intervenció quirúrgica o prova), entra en el que coneixem com llista d'espera pròpia d'aquest procediment/prova al centre sanitari al qual l'han derivat.

El Servei Català de la Salut té 14 intervencions quirúrgiques (procediments quirúrgics) en els que garanteix als pacients que seran intervinguts abans dels 6 mesos, un cop són incorporats a la llista d'espera corresponent.

En aquests casos els pacients poden demanar un certificat en el que consti la data en la que s'han incorporat a la llista d'espera i que aquella intervenció quirúrgica està en garantia.

El concepte de llista d'espera també s'utilitza per a la realització de proves diagnòstiques, com per exemple ecografies, TAC, ressonàncies magnètiques i altres.

Amb aquest concepte es classifiquen els motius següents:

Informacions/consultes relacionades amb llistes d'espera

Exemples:

- Demanda d'informació en relació a la seva situació en una determinada llista d'espera.
- Fer una reclamació en relació amb la seva situació en la llista d'espera.
- Demanda d'un certificat de garantia.
- Demanda d'informació sobre quines són les patologies garantides.
- A més a més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb llistes d'espera.

- *Prestacions Asseguradora*

El concepte de prestacions és molt ampli i recull una gran diversitat d'aspectes. Les prestacions de l'asseguradora pública es corresponen amb serveis, ajuts, accessos a tractaments molt concrets, accés a la informació clínica i a drets inherents al servei sanitari.

Informació/consultes relacionades amb prestacions de l'asseguradora Pública.

Exemples:

- Informació de com, on, i de quina manera poden sol·licitar tractament d'oxigen teràpia o consultes per incidències amb un tractament que ja estan realitzant.
- Informació, incidències i dubtes relacionades amb el Transport Sanitari NO Urgent o programat.
- Informació, incidències i dubtes relacionades amb Rehabilitació.
- Informació, incidències i dubtes relacionades amb els articles ortoprotètics (Prestació d'articles ortoprotètics, PAOS) tals com:
 - Pròtesis
 - Cadires de rodes
 - Crosses
 - Altres prestacions d'articles
- Informació, incidències i dubtes relacionades amb el Transport Sanitari Extracomunitari (transport de pacients entre diferents comunitats autònomes o, fins i tot, de vegades des d'altres països).
- Informació, incidències o dubtes relacionades amb la Historia Clínica.
 - Accés a la informació
 - Sol·licitud de duplicats
 - Informes de la mateixa
 - Altres informacions/consultes sobre la Història Clínica.
- Informació, dubtes i incidències relacionades amb diverses prestacions farmacèutiques, tals com:
 - Medicaments amb aportació reduïda.
 - Medicaments genèrics.
 - Medicació estrangera.
- Pacients autoritzats per resolució directa del Director del CatSalut per accedir a medicaments amb el concepte de Farmàcia exclosa.

- Peticions de pacients amb un nivell de cobertura de farmàcia general que sol·liciten un canvi del nivell de cobertura per impossibilitat de fer front a la despesa que han d'assumir (farmàcia gratuïta).
- Informació, dubtes i incidències relacionades amb les sol·licituds de devolució de diners pagats pels ciutadans davant de determinats tractaments, assistències, proves o situacions lligades a un acte sanitari, i que el ciutadà demana que el CatSalut li retorni, el que és conegut com Rescabament de despeses.
- Informació, dubtes i incidències relacionades amb diferents tipus d'ajuts econòmics que els ciutadans poden sol·licitar:
 - Ajuts per rebre determinats tractaments en altres països.
 - Ajuts per rebre determinades assistències amb caràcter excepcional (no incloses en la cartera del CatSalut).
 - Ajuts per poder pagar factures de llum i aigua en el cas de tractaments de diàlisi peritoneal en el domicili del pacient.
 - Ajuts per afrontar despeses en concepte de dietes de pernocta i manutenció de l'acompanyant (situacions especials de tractaments autoritzats pel CatSalut i que s'han de fer fora de Catalunya).
 - Altres informacions/consultes relacionades amb ajuts econòmics.
- Informació relacionada amb l'atenció podologia a pacients diabètics.
- Informació, dubtes i incidències en relació amb que cobreix el CatSalut quant a la salut bucodental.
- Informació, dubtes i incidències relacionades amb tractaments amb productes dietotèrèpèutics complexos (aliments dietètics especials per pacients especials).
- Altres prestacions.
 - *Acreditació i Assegurament*

Els Servei Català de la Salut (CatSalut) és l'asseguradora pública de Catalunya. Els ciutadans són, la seva majoria, assegurats del CatSalut i tenen dret a una sèrie de serveis i prestacions que varien segons el seu nivell de cobertura, que pot ser diferent segons diferents aspectes, situació d'actiu o pensionista, nivells de renda, estrangers legals i temps d'estada en el nostre país, etc. Per acreditar la situació d'assegurat i el seu nivell de cobertura, cada ciutadà té una Targeta Sanitaria Individual (TSI).

En cas de voler viatjar a determinats països europeus es pot sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE) que donà cobertura sanitària en el país estranger al que es desplaça.

Informació/consultes sobre la TSI, la TSE, copagament farmacèutic i peticions de TSI de mutualistes de MUFACE, MUJEJU i ISFAS.

TSI

La Targeta Sanitaria Individual (TSI), tal com s'ha fet constar, serveix per acreditar la situació d'assegurat i el seu nivell de cobertura. Cada ciutadà en té una.

Exemples:

- He perdut la targeta sanitària i vull demanar un altre. Què he de fer?
- Vull canviar l'adreça de la TSI.
- Vull demanar un duplicat de la TSI.

- He demanat la TSI i encara no l'he rebut.
- M'han dit que jo no puc tenir TSI, per què?
- Peticions de TSI Braille (especial per invidents).
- Peticions de TSI Cuida'm (especials per pacients amb trastorns neurològics i psiquiàtrics).
- Quin nivell de cobertura sanitària tinc? I a que em dona dret?

A més a més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb la TSI.

TSE: Quan un ciutadà vol viatjar a determinats països europeus (no s'inclouen tots) pot sol·licitar la Targeta Sanitària europea (TSE) que li donà cobertura sanitària en el país estranger al qual es desplaça.

Exemples:

- Viatjo a ... puc demanar una TSE?
- On he d'anar a tramitar-la?
- Què he de portar per tramitar una TSE?
- Quina durada té?
- A què donà dret?

A més a més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb la TSE.

COPAGAMENT FARMACÈTIC

Existeix a tot l'estat espanyol i, per tant, també a Catalunya, una normativa que estipula que els ciutadans han de pagar un percentatge de la medicació a les farmàcies, que varia en funció de la situació d'actiu o pensionista i del nivell de renda. A això se li denomina COPAGAMENT farmacèutic.

Exemples:

- Per què jo fins ara pagava... i ara pago...?
- La farmàcia no em vol donar el rebut del que pago.
- Com puc reclamar per què he pagat més del que em correspon.
- He viatjat a un altre Comunitat Autònoma i allà m'han fet pagar..., com puc reclamar per tal de que m'ho tornin?

A més a més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes relacionades amb el copagament farmacèutic.

AFILIATS A MUTUALITATS MUFACE, MUGEJU O ISFAS QUE DEMANANEN PER PRIMERA VEGADA LA TSI

Afiliats a mutualitats MUFACE, MUGEJU o ISFAS (normalment funcionaris) que tenen una provisió de serveis sanitaris de titularitat privada i que, en alguns casos, encara no tenen TSI.

Tenen dret a tenir una Targeta Sanitària Individual (com ciutadà català), però amb un nivell de cobertura especial que li donà dret SOLS a unes prestacions molt concretes que estan considerades com Prestacions d'Interès Sanitari. La resta de prestacions les segueixen tenint per la via privada.

Exemples:

- Consultes, dubtes, informació amb petició de la primera TSI.
- Informacions, dubtes de mutualistes d'aquestes asseguradores.
- Petició de modificació de dades de la TSI.
 - *Accessibilitat*

Consultes que tenen relació amb l'accés dels ciutadans al Sistema de Salut.

Exemples:

- Informació, dubtes, incidències, relacionades amb l'atenció als desplaçats (ja siguin ciutadans catalans dins de Catalunya fora del seu domicili habitual; ciutadans catalans a altres comunitats; ciutadans catalans a l'estranger; ciutadans d'altres comunitats a Catalunya; ciutadans estrangers a Catalunya).
- Informació, dubtes, incidències relacionades amb les baixes i altes laborals mèdiques i, en relació amb el permís de maternitat o paternitat.
- Informació relacionada amb la lliure elecció de metge de capçalera, professional d'infermeria o pediatre. (Com s'ha de fer, què implica...).
- Informació relacionada amb el Consentiment Informat (consentiment lliure i informat que donà un pacient a un tractament o actuació sanitària).
- Informació relacionada amb transplants o donació de cordó umbilical.
- Informació relacionada amb la prova de paternitat.
- Informació relacionada amb normativa i acreditació de centres sanitaris. Els centres sanitaris han d'estar acreditats pel Departament de Salut per poder donar atenció. Poden existir dubtes sobre determinats tipus de centres, com per exemple els centres d'estètica o de tatuatges.
- Informació relacionada amb certificats mèdics.
- Informació sobre els Drets i els Deures dels assegurats del CatSalut.
- Informació en relació amb la sol·licitud d'una segona opinió mèdica.
- Informació relacionada amb la carpeta personal de salut.

A més d'aquests exemples, és possible la sol·licitud d'altres informacions/consultes administratives relacionades amb l'accés dels ciutadans al Sistema Sanitari per les quals s'ha de seleccionar igualment l'etiqueta consulta administrativa.

- *Reclamacions i informacions sobre incidents de SEM finalitzats*

Consulta que té relació amb informació de com un ciutadà pot tramitar una reclamació o queixa per un INCIDENT JA FINALITZAT relacionat amb el Sistema d'Emergències Mèdiques/061 CatSalut Respon o algun tipus d'informació sobre el SEM/061 CatSalut Respon.

5.7.5 Informació Breu

Simulacre SENSE activació de recursos: Totes aquelles trucades que informin d'un simulacre, en el que no cal activar cap recurs.

Simulacre AMB activació de recursos: En totes aquelles trucades que informin d'un simulacre, en el que si cal activar algun recurs sempre s'ha de avisar al Coordinador de demanda per tal que avisi al Cap de Guardia/Cap de Torn o Coordinador Tècnic/Infermer consultor en la seva absència.

En els casos de simulacres amb mobilització de recursos es preferible l'entrada/classificació de l'alerta en relació a la informació facilitada per l'alertant, fent constar al camp A que es tracta d'un SIMULACRE.

Informació / Reclamacions sobre serveis en curs: Aquesta etiqueta no s'ha d'utilitzar.

Informació premsa: Les trucades en que l'alertant s'identifica com a professional d'un mitjà de comunicació, essent traspassades a Cap de Torn. En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn** (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

Altres: La resta de trucades no enquadrades en els apartats anteriors.

5.7.6 Informació Ampla

Alertes procedents de centres sanitaris, cossos de seguretat i altres professional que volen informar d'alguna situació extraordinària com per exemple: Urgències de l'Hospital col·lapsada; talls de carrers per manifestacions; etc.

Totes aquestes trucades seran passades als Cap de Torn de la sala: Caps de Torn del territori on s'ha produït l'incident. En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn** (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

Davant d'aquestes situacions, a 'Informació sol·licitada' hem d'anotar la situació, un telèfon i número d'extensió si tenen.

Escollirem també aquest Omega quan ens informin d'un preventiu. S'ha de demanar nom i telèfon del responsable al lloc, unitats, hores, etc., i es transferirà la trucada a AC de zona.

A continuació, clicarem el botó 'ACCEPTAR'.

5.8 Finalització trucada

5.8.1 Trucada finalitzada pel gestor de demanda de primer nivell

Al finalitzar una trucada en que tota la gestió sigui realitzada pel gestor de demanda de primer nivell, a banda dels missatges indicats per SITREM, acabarà amb la següent frase de comiat:

“Gràcies per la seva trucada”

En el cas que la resposta del SITREM sigui derivació i l'alertant accepti el protocol, un cop facilitada tota la informació i penjada la trucada. Anirem a la pantalla d'Afectats i finalitzarem l'incident prement el botó “Finalitzar”.

En el cas que la resposta del SITREM sigui derivació i l'alertant accepti el protocol, **però abans de penjar la trucada canvia d'opinió:**

- NO finalitzarem l'incident.
- Ho anotarem al camp “A”.
- Traspassem la trucada pel desplegable de la barra de telefonia a Gran Via Consultoria Sanitària P3.
- Informem a coordinació que informi a personal sanitari que està fet com derivació, perquè si penja l'alertant abans de ser valorat, al no haver creat consulta no ho veuran i que ho tinguin present per retrucar.

En el cas que el gestor de demanda accepti la derivació abans de conèixer la resposta d'afectat i aquest vulgui parlar amb personal sanitari, s'anotarà al camp 'A' l'error, es tancarà pantalla i s'obrirà una nova per a que quedi com a consulta.

La transferència pel botó CONSULTA s'ha de fer sempre després de llegir la resposta de SITREM.

5.8.2 Trucada transferida a professional sanitari

Si la trucada genera una consulta sanitària i cal transferir-la, la frase de comiat serà la que apareix a la finestra de missatges de SITREM:

“Si us plau, no pengi, parlarà amb personal sanitari ”.

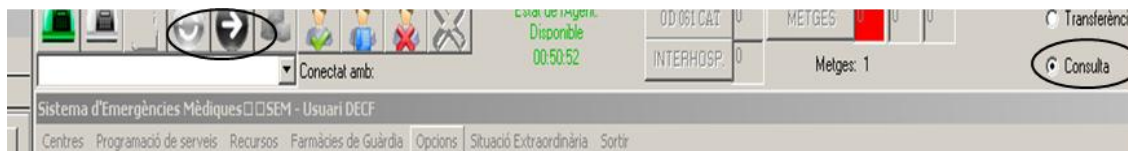
Si s'ha de transferir la trucada a un metge/infermer consultor, aquesta acció es realitzarà prement el botó **CONSULTA** que es troba a la barra de telefonia.

A la sala de Reus al prémer el botó CONSULTA, el Sitrem decideix a quina prioritat i professional sanitari transfereix la trucada. Cal distingir per prioritats:

- **Prioritat 0 i 1:** Hi ha 3 perfils de professional sanitari associats a aquestes prioritats i anirà saltant la trucada d'un a l'altre si estan ocupats. IC, després a l'altre IC-CT i CTO (Cap de Torn).
- **Prioritat 3:** Hi ha 1 perfil de professional sanitari associat a aquesta prioritat, Reus Consultoria Sanitària.

El Gestor de demanda, quan contesti el metge o infermer, l'informarà del número d'incident i donarà una **breu explicació** (no més de 5") sobre el motiu de l'alerta. Una vegada que doni aquesta informació i just abans de transferir la trucada, li dirà :

“Traspasso la trucada”.



A la sala d'Hospitalet o Gran Via, per prioritats diferents a la P0 si hi ha personal sanitari disponible, però no contesten de forma immediata, el Gestor de demanda esperarà 10" (4 tons telefònics) i si ningú contesta transferirà la trucada a la cua.

En cas d'incidents de P0 i localització corresponent a la sala d'Hospitalet sense metges consultors lliures d'aquesta prioritat, després d'esperar 4 tons (10"), s'ha de traspasar la consulta a Hospitalet Coordinadora de Torn, si no contesta es trucarà a Cap de Torn quan el motiu de la demanda és "no respira" i/o "no contesta" - inconscient o part. La resta de motius de demanda es deixaran en la cua de P0 d'Hospitalet.

En cas d'incidents P0 amb o sense recurs assignat i localització corresponent a la **sala de Barcelona** sense personal sanitari lliure s'ha de traspasar al Cap de Torn de Barcelona. Si després de 4 tons no respon passar la trucada a la cua de P0 d'Hospitalet.

De dilluns a diumenge en horari de 8 a 20h, **Hospitalet Coordinadora de Torn**, junt al Cap de Torn que atindrà, entre d'altres, les següents situacions sempre que estigui disponible.

Serveis de pacients **inconscients i no respiren / aturades cardiorespiratòries** que s'hagin de valorar, seguirem el següent protocol de valoració:

- **4 tons P0**, si no agafen el telèfon, recuperem la trucada.
- **4 tons Hospitalet Coordinadora de Torn (SEM)**, si no agafa, recuperem, en el cas de **zona Hospitalet**.
- **4 tons Cap de Torn (Hospitalet) o Cap de Torn (BCN)**, si no agafen, recuperem.
- **4 tons P0** i deixarem en cua la trucada.

En cas d'incidents de la zona geogràfica corresponent a la **sala de Reus**:

Davant d'una emergència vital procedent de la Sala de Reus (Lleida província, Tarragona província, La Cerdanya i Catalunya Central) de tipologia **NO CONTESTA, NO RESPIRA**, procedirem de la següent manera:

- Botó 'CONSULTA'(esperar 4 tons).
- Trucar a Reus AC per extensió 175010 / 175011 (esperar 4 tons).
- S'ha de mantenir a l'alertant en línia fins poder transferir.

Una emergència vital no pot deixar-se mai en cua, per tant, haurem d'esperar a que ens agafin la trucada. Si a la primera volta no ens l'agafen, tornarem a començar per botó 'CONSULTA'.

Tots els incidents que **mobilitzen recurs** es queden a la sala Reus, el botó consulta fa el traspàs a metge consultor, infermer consultor i coordinador tècnic automàticament.

Els incidents que no mouen recurs passen a Gran Via, també pitjant CONSULTA. Depèn de la prioritat, passen automàticament al consultor de la prioritat corresponent. Per tant, sigui la que sigui, seguim treballant sempre amb el botó de CONSULTA i si al traspassar a les altres sales no ens agafen llavors si transferim.

Les reclamacions que Si han empitjorat i que encara no surti recurs també es queden a sala Reus.

Quan per procediment es transferia la trucada al Cap de Guàrdia, a partir d'ara s'haurà de transferir al Cap de Torn del territori on s'ha produït l'incident.

En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual.

5.8.2.1 Transferència trucades ICO 061

En horari diürn entre 6:00 am i 01:00 am del dia següent: els gestors de demanda han de traspasar la trucada al consultor ICO per combo:

- Si consultor ICO 061 respon abans de 4 tons: traspàs de la trucada.

- Si el consultor ICO 061 no respon abans de 4 tons: indicar a l'usuari que el personal sanitari està ocupat, que pot penjar i que se'l retrucarà el més aviat possible.

En horari nocturn entre 01:00 am i 06:00 am: els gestors de demanda classifiquen els incidents ICO 061 i indiquen a l'alertant que pot penjar i que se'l retrucarà el més aviat possible.

- Els gestor de demanda comunica al coordinador de demanda l'entrada d'aquest incident.
- El coordinador de demanda comunica el número d'incident al metge ICO (indicat pel Cap de Torn). Aquest metge retrucarà a l'alertant.

Les trucades rebudes de personal sanitari mai les deixarem en cua.

5.8.2.2 Trucada transferida a gestor de segon nivell

Si la trucada genera una consulta administrativa i cal transferir-la, la frase de comiat serà la que apareix a la finestra de missatges de SITREM:

“Si us plau no pengi, li passo amb un operador que gestionarà la seva consulta”

Per transferir la trucada podem utilitzar el botó de “CONSULTA”. En el cas de les traduccions, s'ha de transferir escollint al desplegable la opció “Hospitalet Servei Traducció”.

Si a Segon Nivell hi haguessin cues i sempre que l'equip d'estructura doni la instrucció (amb indicació del Cap de Torn), tancarem el traspàs de trucades de Primer Nivell a Segon Nivell (excepte el servei de traducció). Informem a l'usuari/a amb la següent frase:

“En aquests moments tots els nostres gestors estan ocupats, el trucarem el més aviat possible, des d'un número ocult, per resoldre la seva consulta. Moltes gràcies.”

Si l'usuari comenta que prefereix alguna hora de retrucada concreta, s'anota al camp 'A'. Això, no és un suggeriment que li hem de fer a l'usuari, només ho hem d'anotar si ens ho indica.

5.9 Tipologia de trucades

En aquest apartat es fa una descripció del procediment en funció del tipus de trucada.

5.9.1 Trucades informatives

Trucades que fan referència a algun dels conceptes referits a la pantalla informació breu.

- **Simulacre SENSE activació de recursos:** Totes aquelles trucades que informin d'un simulacre en el que no cal activar cap recurs.
- **Simulacre AMB activació de recursos:** Totes aquelles trucades que informin d'un simulacre, en el que si cal activar algun recurs. Sempre s'ha d'avisar al Coordinador de demanda per tal que avisi al Cap de Torn o Coordinador Tècnic/Infermer consultor en la seva absència. En el cas de la **Sala Motors**, la

transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

En els casos de simulacres amb mobilització de recursos, és preferible l'entrada/classificació de l'alerta en relació a la informació facilitada per l'alertant, fent constar al camp 'A' que es tracta d'un SIMULACRE.

- **Informació premsa:** Les trucades en que l'alertant s'identifica com a professional d'un mitjà de comunicació.
- **Altres:** La resta de trucades no enquadrades en els apartats anteriors.

5.9.1.1 Trucades amb sol·licitud d'informació i/o documentació clínica

Per la L.O.P.D els gestors no poden facilitar informació sobre els serveis, únicament podran indicar si hi ha assignat un recurs i el seu estat (Ambulància, MMEE, Bombers, ...).

Les peticions d'informació sobre incidents per part de familiars o cossos de seguretat, són freqüents a la CECOS. Aquesta informació s'ha de facilitar en casos concrets i sempre respectant el previst a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals.

El següent procediment permet identificar aquelles situacions on el personal de CECOS podrà facilitar la informació:

Els gestors de demanda poden trobar-se amb diferents perfils de persones sol·licitants:

a) Usuaris:

No es poden donar dades com "centre de destí" i en cap cas trucar a Taula de Gestió de Recursos per demanar permís. S'informarà al usuari, que no podem donar informació segons Llei de Protecció de Dades personals.

No procedeix de forma immediata donar informació.

Els usuaris tenen dret a conèixer les dades d'identificació de tots els professionals que han intervingut en la seva assistència, telefònica o presencial, del personal del SEM o adjudicatari.

Igualment, tenen dret a obtenir còpia de totes les dades personals i de salut que formen part de la seva història clínica, inclosa la gravació de les converses.

Amb aquesta finalitat poden adreçar-se a la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

El Gestor de Demanda realitzarà incident (intervenció) com At. No Presencial No Urgent → Consulta Administrativa i transferirà la trucada al Gestor de Consulta Administrativa per tal de gestionar la seva petició.

b) Cossos de Seguretat/Jutjats:

Com a norma general, totes aquelles peticions que realitzi un cos de seguretat/jutjat a CECOS en relació a informació de la història clínica (HC) d'un

pacient, el Gestor de demanda realitzarà incident (intervenció) com Informativa Ampla i es sol·licitarà la següent informació, anotant al camp A:

- Institució que ho sol·licita
- TIP/identificació del professional
- Dades del pacient/Incident sol·licitat

Es traspasarà la trucada a l'equip cap de Guàrdia/Cap de Torn, si aquest no està present a Infermeria Coordinació Tècnica.

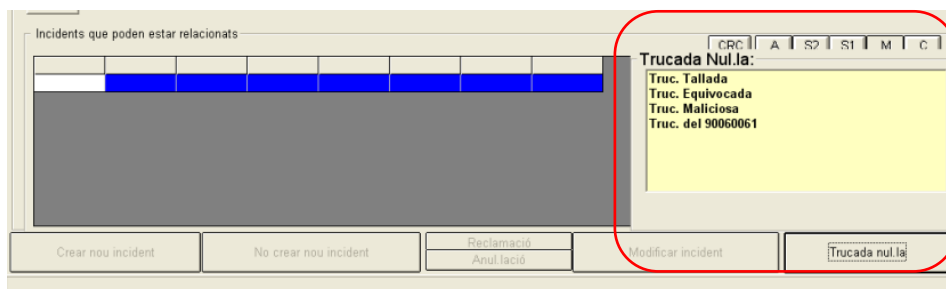
c) Centres Sanitaris:

En cas que un professional d'un centre sanitari, sol·licita informació d'un pacient, primerament buscarem l'incident i traspasarem trucada a Auxiliar de Coordinació de la zona.

5.9.2 Trucades nul·les

Són aquelles trucades que no requereixen cap tipus d'atenció:

- **Truc. Tallada:** Quan s'interromp la comunicació abans d'obtenir informació de les necessitats de l'alertant. Si es disposa del telèfon, el Gestor de demanda de primer nivell ha de retrucar (3 intents), crear i classificar l'incident segons la informació rebuda. En cas de no poder contactar, informarà al coordinador de demanda i seleccionarà Truc. Tallada.
- **Truc. Equivocada:** Aquelles que no volen contactar amb el nostre servei.
- **Truc. del 900600061:** Les trucades efectuades mitjançant aquest número de telèfon per personal assistencial per efectuar consultes amb els professionals de la central de coordinació.



- **Truc. Maliciosa: Les trucades de broma.** Procediment d'atenció de trucades malicioses
 Habitualment, els telèfons dels serveis d'emergències reben trucades malicioses (bromes, alertes falses o comentaris obscens) que afecten el desenvolupament de la tasca diària dels professionals.
 Per aquest motiu, el SEM ha dissenyat un procediment per gestionar aquesta tipologia de trucades amb l'objectiu de garantir un entorn de treball segur i eficient.
 En aquesta línia, s'ha implantat un sistema que identifica la numeració entrant i, en cas que estigui inclosa en una llista pre-definida, abans de transferir la trucada al professional, el alertant escoltarà la següent locució:

“El 061 dona resposta a urgències i emergències sanitàries. Aquesta trucada està sent gravada. Des d’aquest telèfon s’han rebut trucades falses, abusives, obscenes o insultants que suposen un ús fraudulent del servei i podran ser denunciades a l’autoritat competent. Si tot i això necessita assistència sanitària urgent o emergent, premi LA TECLA 1”.

ACCIONS DE GESTORA/GESTOR DEMANDA PRIMER NIVELL

- La resposta literal a l’usuari serà la següent, en un to de veu calmat i respectuós: ***“l’informo que la conversa està sent gravada i donat que està fent un ús inadequat del servei, procedeix a finalitzar la trucada”.*** Aquesta resposta s’ha de reproduir literalment ja que no la rebrem de SITREM.
- Haurà d’informar a Estructura de SERVEO, de forma verbal, indicant el numero d’incident SITREM.

ESTRUCTURA SERVEO: Realitzarà el procediment indicat, segons procediment, per informar a SEM.

5.9.3 Noves trucades sobre incidents actius que no el modifiquen ni reclamen

En totes les segones o posteriors trucades sobre un incident actiu, que no modifiquin, ni reclamin, ni anul·lin el mateix, cal fer la cerca mitjançant l’operativa descrita a l’apartat 5.4.5 (Relacionar incidents actius) i cal prémer el botó. **No crear nou incident.**

Un exemple seria l’entrada simultània de diverses trucades d’alerta sobre un mateix incident en un breu espai de temps, quan el primer ja està creat.

The screenshot shows the 'Nova trucada' (New call) form in the SERVEO system. The form includes fields for 'Alertant' (02), 'Alertant Accidental', 'M', 'Telèfon' (444444444), 'Comarca' (Barcelonès), 'Provincia' (BARCELONA), 'Lloc' (Barcelona), 'Lloc (SM2)' (Barcelona), 'Adreça' (Mallorca, de / c.), 'Complement', 'ABS' (Barcelona 2c CAP Eixample), 'Zonas', 'Nom i Cognoms', 'Edat', 'Anys', 'Sexe', 'DNI', 'C.I.P.', 'Tel. Afectat', 'Codi', and 'Tipus Demanda' (SubM1). Below the form is a table titled 'Incidents que poden estar relacionats' with columns: Municipi, Adreça, Comp. Adreça, C. Incident, Afectat, Tipus Demanda, and SubM1. The table contains one row: Barcelona, c. Mallorca, de 100, , 99990860, ACCIDENTS / TRA, Barcelona. At the bottom of the form are five buttons: 'Crear nou incident', 'No crear nou incident' (circled in red), 'Reclamació Anul·lació', 'Modificar incident', and 'Trucada nul·la'.

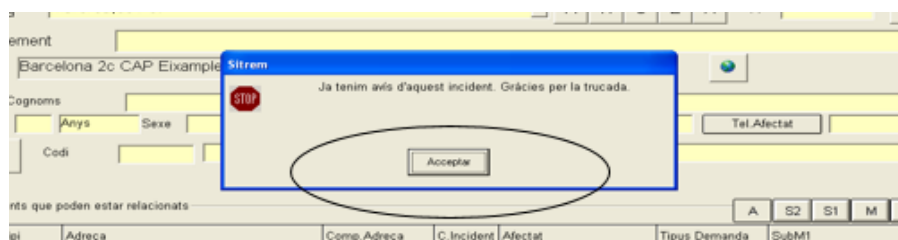
A continuació, apareixerà una finestra amb un desplegable i caldrà escollir l’opció adient i prémer acceptar.

The screenshot shows the 'Nova trucada' (New call) form. At the top, there are status indicators for 'Op. 061 Cat.', 'Metges', 'Cap Guard Cat.', and 'Transferir'. Below this, there are fields for 'Alertant', 'Alertant Accidental', 'M', 'Telèfon', and 'Cap Guard Bar.'. The form also includes fields for 'Municipi', 'Comarca', 'Província', 'Lloc', 'Adreça', 'Complement', 'ABS', 'Zonas', 'Nom i Cognoms', 'Edat', 'Anys', 'Sexe', 'DNI', 'C.I.P.', 'Tel. Afectat', and 'Codi'. A table at the bottom shows 'Incidents que poden estar relacionats' with columns for 'Municipi', 'Adreça', 'C. Incident', 'Afectat', 'Tipus Demanda', and 'SubM1'. A blue dialog box with the text 'No crea incident' is overlaid on the form, indicating that the incident should not be created because it has already been reported.

Finalment apareix una nova finestra amb el missatge que cal donar a l'alertant:

“Ja tenim avís d'aquest incident. Gràcies per la trucada”.

A continuació cal prémer Acceptar.



5.9.4 Trucades d'anul·lació d'incidents actius

Quan un alertant informa que vol anul·lar un incident actiu, cal fer la cerca del mateix mitjançant l'operativa descrita a l'apartat 5.4.5 (Relacionar incidents actius) i cal interrogar:

“Per quin motiu vol anul·lar el servei?”

Al camp “A”, anotarem el motiu de l'anul·lació.

En cas que el motiu del mateix fos la demora, el Gestor de demanda de primer nivell comprovarà l'estat del recurs i, si aquest està activat, informará d'aquesta situació a l'alertant, donant-li l'opció d'escollir l'anul·lació o no del servei.

Si finalment cal anul·lar l'incident, cal prémer el botó anul·lació. A continuació, apareix una finestra que demana la confirmació de l'anul·lació.

Nova trucada

Alertant: 02 Alertant Accidental M Telèfon: 444444444

☒ Adreça a Afectat

Municipi: Barcelona Comarca: Barcelonès Província: BARCELONA

Distr.: Eixample Barri: Esquerra Eixample

Adreça: Mallorca, de / c. N°: 100

Complement:

ABS: Barcelona 2c CAP Eixample Zonas:

Nom i Cognoms: Edat: Anys Sexe: Codi:

☐ Si ☐ No

Vol anul·lar aquest servei?

Incidents que poden estar relacionats

Municipi	Adreça	Comp. Adreça	C. Incident	Afectat	Tipus Demanda	SubM1
Barcelona	c. Mallorca, de 100		1303		Dolor	Eixample
Barcelona	c. Mallorca, de 100		1272		Alt. consciència	Eixample

Crear nou incident No crear nou incident Reclamació Anul·lació Modificar incident Trucada nul·la

Al prémer **Sí**, apareix una altra finestra amb un desplegable amb tres opcions a escollir l'adient:

- Anul·lació alertant
- Anul·lació per recursos propis
- Anul·lació millora

Incidents que poden estar relacionats

Municipi	Adreça	Comp. Adreça	C. Incident	Afectat	Tipus Demanda	SubM1
Barcelona	c. Mallorca, de 100		1303		Dolor	Eixample
Barcelona	c. Mallorca, de 100		1272		Alt. consciència	Eixample

Anul·lació

Anul·lació Alertant
Anul·lació per Recursos Propis
Anul·lació Millora

Crear nou incident No crear nou incident Anul·lació Modificar incident Trucada nul·la

El gestor de demanda davant d'una anul·lació amb recurs assignat, informa a l'Auxiliar de Coordinació. Si es tracta d'una anul·lació sense recurs assignat, només escriu el motiu de l'anul·lació al camp "A" i el personal sanitari tancarà l'incident.

Si la petició d'anul·lació és d'una Residència Geriàtrica sense recurs assignat, el gestor de demanda ha de traspasar la trucada a la taula de Fragilitat-Geriatria i anotar-ho al camp 'A'. En cas de no poder contactar, després de 4 tons, deixar en cua.

La taula de Fragilitat pot programar un servei de transport sanitari no urgent, i assignar a l'incident de Sitrem una intervenció de **TSNU**.

Si el gestor de demanda detecta que personal sanitari truca per anul·lar un recurs:

SAT – Amb. Transport – Transp

haurà de passar a valorar a la Taula de Fragilitat/Geriatria. I es pot deixar en cua després de 4 tons.

5.9.4.1 Trucada d'una unitat gestor d'un adjudicatari de Transport Sanitari No Urgent (TSNU)

Les unitats TSNU es podem activar per SEM, per assolir diversos serveis, en aquest cas les unitats contactaren amb el SEM per gestionar un transport derivat a TSNU, el gestor de demanda realitzarà el següent procediment:

- Demanar la localització de l'incident per poder associar correctament la gestió.
- Anotar l'acció al camp A.
- Transferir la trucada a ACTSSEE3 utilitzant el combo via combo telefònic de SITREM ACTSSEE3*.

*ACTSSEE3 – TSNU és l'auxiliar (AC) encarregat de controlar totes les assignacions d'aquest tipus d'incident via correu, SITREM i PANDOR

5.9.4.2 Trucades d'anul·lació d'incidents actius amb recurs assignat TSNU

L'objectiu d'aquesta operativa és permetre facilitar informació quan es fa una anul·lació d'un servei actiu que s'ha traspassat al Transport Sanitari No Urgent.

Alguns serveis, seguint criteris ben definits, poden ser traspassats al TSNU. Quan això passi està procedimental que ha de quedar registrat al camp 'A' l'evolució del servei i també el temps d'arribada.

En aquest cas, per les anul·lacions d'incidents actius on el recurs assignat sigui un TSNU cal seguir el procediment com està definit al Manual de Gestor de Demanda amb l'afegit:

- Si la petició d'anul·lacions és d'un servei traspassat a TSNU (al camp 'A' estarà anotada l'evolució del servei de TSNU i el temps estimat d'arribada) llavors el gestor de demanda si detecta una anul·lació del servei haurà de informar-ho a ACTSSEE3 via combo telefònic de SITREM ACTSSEE3*.

*ACTSSEE3 – TSNU és l'auxiliar (AC) encarregat de controlar totes les assignacions d'aquest tipus d'incident via correu, SITREM i PANDORA.

5.9.5 Trucades de modificació d'incidents actius

Quan un alertant informa que vol modificar alguna dada d'un incident actiu, cal fer la cerca del mateix mitjançant l'operativa descrita a l'apartat 5.4.5 (Relacionar incidents actius). Una vegada localitzat cal prémer-ho i a continuació prémer el botó Modificar Incident.

Aquesta acció portarà a l'incident i és aquí on el gestor de demanda de primer nivell farà el canvi de la dada corresponent i ho anotarà al camp "A", si la modificació fa referència a un àmbit operatiu s'informarà a l'Auxiliar de Coordinació i les que estiguin relacionades a àmbits sanitaris s'informarà a Coordinador Tècnic.

Nova trucada

Alertant: 02 Alertant Accidental M Teléfon: 444444444

☒ Adreça a Afectat

Municipi: Barcelona Comarca: Barcelonès Província: BARCELONA

Distr.: Eixample Barri: Esquerra Eixample

Adreça: Mallorca, de / c. A H C E X Nº: 100 Z

Complement:

ABS: Barcelona 2o CAP Eixample Zonas:

Nom i Cognoms:

Edat: Anys Sexe: DNI: C.I.P.: Tel. Afectat:

Ω Codi:

Incidents que poden estar relacionats:

Municipi	Adreça	Comp. Adreça	C. Incident	Afectat	Tipus Demanda	SubM1
Barcelona	c. Mallorca, de 100		1303		Dolor	Eixample
Barcelona	c. Mallorca, de 104		1272		Alt. consciencia	Eixample

Aquests incidents corresponen a la mateixa zona. Determini si és un nou incident

5.9.6 Trucades de reclamació d'incidents (intervencions)

Cal diferenciar si la reclamació s'efectua en referència a un incident finalitzat o a un encara actiu. Això ho podrem diferenciar a l'introduir les dades de localització i observar quins són els incidents relacionats o es pot utilitzar l'eina cercador (prismàtics).

5.9.6.1 Incidents Finalitzats

En aquest cas, l'usuari vol manifestar la seva disconformitat vers la qualitat dels serveis oferts per l'organització.

El gestor de demanda de primer nivell ha de recollir les dades bàsiques de l'incident (alertant, adreça, afectat) i confirmar que l'incident sobre el qual es reclama està finalitzat.

Ha d'obrir l'OMEGA, escollir el tipus de demanda Atenció No Urgent i, dins d'aquesta pantalla, dirigir-se a Consulta Administrativa, escollir l'etiqueta Consulta Administrativa.

Ha d'escriure al camp "A" el motiu de la reclamació/informació.

Ha de traspasar la trucada als gestors de demanda de segon nivell.

5.9.6.2 Incidents Actius

En aquest cas, l'alertant vol manifestar la seva disconformitat vers el no enviament o demora en l'assistència sol·licitada.

El gestor de demanda de primer nivell ha de recollir les dades bàsiques de l'incident (alertant, adreça, afectat) i confirmar que l'incident sobre el qual es reclama està obert.

Cal formular la pregunta:

"Com es troba el malalt? Ha empitjorat des de l'anterior trucada?"

En cas afirmatiu, cal transferir la trucada al metge o infermer consultor que ha valorat l'incident inicialment. Si això no fos possible, es transferirà a un altre metge consultor. Si aquesta segona opció tampoc és factible, es transferirà a Infermera de la Taula de Cap de Torn i si tampoc fos possible, es passarà en un final amb Cap de Torn.

En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

En cas negatiu, caldrà actuar en funció de la prioritat de la intervenció.

5.9.6.2.1 Reclamació intervencions prioritat 0

- Primera reclamació
 - Recollir les dades bàsiques de l'incident (alertant, localització, afectat).
 - Identificar l'incident relacionat.
 - Relacionar-ho com reclamació.
 - Interrogar si el pacient ha empitjorat.
 - Comprovar l'estat del recurs.
- a. Si el recurs no està activat, informar a l'alertant que:
 - a. "El recurs no està activat; prenc nota de la seva reclamació.";
 - b. al mateix temps preguntar: "El personal sanitari li ha explicat què cal fer fins que arribi el recurs?".

Aquesta segona qüestió, només es plantejarà en el cas que l'alertant es trobi amb el pacient.

Si la resposta a l'última pregunta és afirmativa, la trucada es finalitzarà. En cas de resposta negativa, es traspasarà la trucada al personal sanitari que ha fet la valoració inicial. Si això no fos possible, es transferirà a un altre personal sanitari. Si aquesta segona opció tampoc és factible, es transferirà la trucada a Infermera de la Taula de Cap de Torn i si no contesta es passarà amb el Cap de Torn. En el cas de la

Sala Motors, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

- b. Si el recurs està activat, confirmar que està mobilitzat i informar a l'alertant que:
 - a. *“El recurs està de camí; prenc nota de la seva reclamació.”*; alhora s'ha interrogar: *“El personal sanitari li ha explicat què cal fer fins que arribi el recurs?”*.

Aquesta segona qüestió, només es plantejarà en el cas que l'alertant es trobi amb el pacient. Si la resposta a l'última pregunta és afirmativa, la trucada es finalitzarà.

En cas de resposta negativa, es traspasarà la trucada al personal sanitari que ha fet la valoració inicial. Si això no fos possible, es transferirà a un altre personal sanitari. Si aquesta segona opció tampoc és factible, es transferirà la trucada a Infermera de la Taula de Cap de Torn i si no contesta es passarà amb el Cap de Torn. En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

- Segona o posteriors reclamacions
 - Recollir les dades bàsiques de l'incident (alertant, localització, afectat).
 - Identificar l'incident relacionat.
 - Relacionar-ho com a reclamació.
 - Comprovar l'estat del recurs.
 - a. Si el recurs no està activat, informarà a l'alertant que: *“El recurs no està activat; prenc nota de la seva reclamació.”*; la trucada es finalitzarà i alhora s'informarà a Infermera de la Taula de Cap de Torn, si això no fos possible s'informarà al Cap de Torn; si no és possible al Coordinador Tècnic/Infermer consultor, i si no és possible a l'Auxiliar de Coordinació/Coordinador Operatiu.
 - En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn** (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.
 - b. Si el recurs està activat, confirmar que està mobilitzat i informar a l'alertant que: *“El recurs està de camí; prenc nota de la seva reclamació.”*;
 - c. La trucada es finalitzarà.

5.9.6.2.2 Reclamació d'intervencions prioritat 1 a 4

- En el cas d'una primera reclamació cal:

- Recollir les dades bàsiques de l'incident (alertant, localització, afectat).
 - Identificar l'incident relacionat.
 - Relacionar-ho com a reclamació.
 - Comprovar l'estat del recurs.
- a. Si el recurs no està activat, informarà a l'alertant que: *“El recurs no està activat; prenc nota de la seva reclamació.”*; alhora interrogarà: *“Com es troba el malalt? Ha empitjorat des de l'anterior trucada?”*.
En cas afirmatiu, cal transferir la trucada al personal sanitari que ha valorat l'incident inicialment.
Si això no fos possible, es transferirà a un altre personal sanitari (metge prioritat no 0 a la sala d'Hospitalet). Si aquesta segona opció tampoc és factible, es transferirà a Infermera de la Taula de Cap de Torn i si tampoc fos possible, es passarà al Cap de Torn. En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació. En cas negatiu, finalitzar la trucada.
- b. Si el recurs està activat, confirmar que està mobilitzat i informar a l'alertant que: *“El recurs està de camí; prenc nota de la seva reclamació.”*; alhora interrogarà: *“Com es troba el malalt? Ha empitjorat des de l'anterior trucada?”*.
En cas afirmatiu cal transferir la trucada al personal sanitari que ha valorat l'incident inicialment. Si això no fos possible, es transferirà a un altre personal sanitari. Si aquesta segona opció tampoc és factible, es transferirà a Infermera de la Taula de Cap de Torn i si tampoc fos possible, es passarà al Cap de Torn.
En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació. En cas negatiu, finalitzar la trucada.
- En el cas d'una segona o posteriors reclamacions cal:
 - Recollir les dades bàsiques de l'incident, segons Manual de Gestors de demanda.
 - Identificar l'incident relacionat.
 - Relacionar-ho com a reclamació.
 - Comprovar l'estat del recurs.

Cal actuar com en una primera reclamació.

- Des de la tercera reclamació i posteriors s'informarà a Infermera de la Taula de Cap de Torn i si no és possible, s'informarà al Cap de Torn, si no és possible al Coordinador Tècnic/Infermer Consultor, i si no és possible a l'Auxiliar de Coordinació/Coordinador Operatiu.

En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

5.9.6.2.3 Reclamacions sobre la NO realització de la consulta

Reclamacions d'incidents actius en els quals l'alertant vol manifestar una **reclamació sobre la no realització de la consulta indicada en una trucada anterior**:

El gestor de demanda de primer nivell ha de recollir les dades bàsiques de l'incident (alertant, adreça, afectat) i confirmar que l'incident sobre el qual es reclama està obert. En aquest cas, s'ha de relacionar amb l'incident obert. En cas contrari, es generarà nou incident segons procediment habitual.

Cal formular la pregunta:

“Com es troba l'afectat? Ha empitjorat des de l'anterior trucada?”

- En cas afirmatiu, cal finalitzar la pantalla de nova trucada com Reclamació, seleccionant una de les propostes del desplegable segons el temps passat des de l'alerta i transferir la trucada a personal sanitari.

- En cas negatiu, el gestor de demanda ha de finalitzar la pantalla de nova trucada com Reclamació, seleccionant una de les propostes del desplegable segons el temps passat des de l'alerta i ha d'informar a l'alertant que es recull la reclamació i indicar-li:

“El personal sanitari està ocupat. Pengi i el retrucarem”

No deixarem en cua i tampoc passarem a valorar si no hi ha empitjorament.

5.9.6.2.4 Reclamacions d'alertant qualificat

Entenem per alertant qualificat aquells que són institucionals i alhora indirectes (Policia Local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, FFCC, Renfe...).

- En el cas d'una primera reclamació cal:
 - Recollir les dades bàsiques de l'incident, segons el Manual de Gestor de demanda (confirmar adreça).
 - Identificar l'incident relacionat.
 - Relacionar-ho com a reclamació.
 - Comprovar l'estat del recurs.
 - S'informarà a l'alertant de l'estat del servei i es finalitzarà la trucada.

Davant de qualsevol reclamació per alertant qualificat si hi ha canvis en l'estat del pacient amb patologia d'emergència en 1ª Reclamació s'intentarà transferir trucada i/o informar.

- En el cas d'una segona reclamació cal:
 - Recollir les dades bàsiques de l'incident, segons el Manual de Gestor de demanda (confirmar adreça).
 - Identificar l'incident relacionat.

- Relacionar-ho com a reclamació.
- Comprovar l'estat del recurs.
- S'informarà a l'alertant de l'estat del serveis i es finalitzarà la trucada. Alhora s'informarà a Infermera de la Taula de Cap de Torn, si no fos possible, s'informarà al Cap de Torn; si no és possible al Coordinador Tècnic/Infermer Consultor i, si no és possible, a l'Auxiliar de Coordinació/Coordinador Operatiu.

En el cas de la Sala Motors, la transferència es continuarà fent a la Infermeria de la Taula de Cap de Torn, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

- En el cas d'una tercera reclamació cal:
 - Recollir les dades bàsiques de l'incident, segons el Manual de Gestor de demanda (confirmar adreça).
 - Identificar l'incident relacionat.
 - Relacionar-ho com a reclamació.
- Comprovar l'estat del recurs.
- Es traspasarà la trucada a Infermera de la Taula de Cap de Torn, si no és possible, llavors es passarà al Cap de Torn; si no és possible al Coordinador Tècnic/Infermer Consultor i, si no és possible, a l'Auxiliar de Coordinació/Coordinador Operatiu.

En el cas d'una primera o posteriors reclamacions d'una intervenció que, per motiu de les seves característiques, (alertant sanitari, institucional, entorn excepcional...) tingui una especial consideració, es traspasarà la trucada a Infermera de la Taula de Cap de Torn i si no ens agafa la trucada es passarà al Cap de Torn, si no és possible al Coordinador Tècnic/Infermer Consultor i, si no és possible, a l'Auxiliar de Coordinació/Coordinador Operatiu.

En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

En els incidents que intervingui una unitat aèria hem d'informar o traspassar la trucada a Auxiliar UMA o CT UMA.

5.9.6.2.5 Reclamacions d'incidents d'interhospitalaris

Totes les reclamacions d'incidents d'Interhospitalari, de qualsevol prioritat, han de ser transferides pel gestor de demanda al metge de la Taula d'Interhospitalari o a l'infermer, en cas de no disponibilitat d'aquest.

5.9.6.2.6 Reclamacions d'incidents amb recurs assignat TSNU

L'objectiu d'aquesta operativa és permetre facilitar informació quan es fa una reclamació d'un servei actiu que s'ha traspassat al Transport Sanitari No Urgent.

Alguns serveis, seguint criteris ben definits, poden ser traspassats al TSNU. Quan això passi està procedimental que ha de quedar registrat al camp 'A' l'evolució del servei i també el temps d'arribada.

En aquest cas, per les reclamacions d'intervencions amb un recurs assignat de TSNU cal seguir el procediment com està definit al manual de Gestió de Demanda de la prioritat i el número de reclamació afegint els passos següents:

- Revisar el camp 'A'.
- Si el servei ha sigut traspassat a TSNU, l'evolució del servei estarà anotat al camp 'A', concretament hi serà el temps aproximat d'arribada. Aquesta és la informació que el Gestor de Demanda pot facilitar a l'alertant.
- Cal, preguntar sempre si l'afectat a empitjorat i seguir el procediment depenent de la prioritat i el número de reclamació que sigui.

5.9.7 Trucades emeses pel gestor de demanda de Primer Nivell

Aquesta situació es pot presentar en diferents casos:

- **L'alertant penja o es talla la trucada:** el GD **sempre** ha de retrucar, reconduir la trucada i gestionar-la des del punt a on estaven anteriorment.
- **L'alertant no es troba al lloc amb l'afectat:** Trucarem al telèfon que ens han facilitat de l'afectat o de l'alertant que estigui al lloc. Quan agafin la trucada ens hem de presentar i explicar d'on truquem, per quin motiu i confirmar que les dades que ens havien facilitat són correctes.

“Bon dia, bona tarda, bona nit, truco del 061 CatSalut Respon, ens ha trucat (Tele assistència, el seu familiar, el seu amic, PL, MMEE, Central metro...), ens ha demanat ajuda o consulta per ... (dades que disposem de l'afectat).”

Després, seguidament, hem de confirmar les dades de localització, començant sempre pel Municipi, Submunicipi o Barri, Adreça, Número, pis-porta-casa... i qualsevol altre dada facilitada de localització. Ex: *“Està vostè a Viladecans, carrer major, número 4, VP, al costat del Bar Copas?”*

Finalment, hem de confirmar amb l'afectat o alertant al lloc, el motiu de l'alerta i indicar-li el missatge que ens havia indicat Sitrem a la primera alerta (de l'alertant no al lloc).

En el cas que alguna dada no sigui correcte, procedir segons indica el manual gestionant la modificació.

Si ens trobem amb la situació en la que els símptomes de l'afectat no coincideixen amb els facilitats per l'alertant no al lloc, passarem a valorar amb

metge de consultoria Pr 1 o Pr 0 (segons la simptomatologia que indiqui), excepte si l'alertant al lloc ens indica: No Contesta/No Respira, dolor toràcic o dispnea que passarem sempre a metge Pr 0 i seguirem el protocol específic de cada una de les sales per aquestes situacions i si estan ocupats informarem a Coordinació de demanda.

Si no podem contactar amb l'afectat o alertant al lloc després de varies retrucades, procedirem segons cada cas:

- Hi ha recurs assignat i es passa a valorar: informarem a personal sanitari (segons indiqui Sitrem).
- Hi ha recurs assignat i Sitrem no indicava passar a valorar: escriurem al camp "A" que no ha estat possible contactar amb l'afectat o alertant al lloc.
- Sitrem indica passar a valorar, sense recurs assignat: informarem a personal sanitari (a la prioritat que indiqui Sitrem).

5.9.8 Trucades amb demanda d'una ambulància efectuada per un alertant professional sanitari no hospitalari (TSU)

Aquelles trucades en que hi ha una demanda d'una ambulància quan l'alertant és un professional sanitari (metge/metgessa, DUI) no hospitalari, és a dir un professional d'un centre d'assistència primària, soci-sanitari o privat.

El nom del professional sanitari l'anotarem al botó "M" al camp "Metge" i al camp "Servei" anotarem el centre mèdic on pertany. En el cas de les residències, hem de diferenciar si és el metge de la residència o pertany a un centre mèdic i anotar-ho.

Si es tracta d'una residència geriàtrica, cal seguir el procediment de l'apartat 5.8.10 (Procediment Atenció Residents amb suport Consultoria geriàtrica).

Cal demanar sempre el CIP, DNI, NIE o passaport.

En tots els transports sanitaris (TSU), s'ha de demanar el diagnòstic que s'ha de recollir al camp "A" (EX. "OD: GEA").

Si personal sanitari alerta per un pacient inconscient o aturada cardíaca/No respira classifiquem com "NO CONTESTA" o "NO RESPIRA".

Malaltia Lloc Públic si és un centre sanitari o Malaltia Domicili si el pacient està al seu domicili (domicili particular, residència,...). Aplicarem el procediment específic per aquest tipus de classificació (no procediment TSU).

Si el personal sanitari no està amb el pacient, cal d'interrogar **si ha fet la visita domiciliària o no** (és a dir, ha fet valoració telefònica). Aquesta informació s'ha de registrar al camp "Tipus de trasllat" de l'Omega Transport Sanitari: TSU-AMB VISITA · TSU-SENSE VISITA.

Hem de demanar de VEU un telèfon de l'afectat o d'un acompanyant al lloc, mai llegir-ho d'aquelles dades complimentades que apareixen amb el DNI/CIP d'afectat. Si personal sanitari ens indica que no l'ha visitat, hem de procedir a trucar a afectat per confirmar la seva direcció.

En totes aquelles peticions de trasllat des de CUAPs, el gestor de demanda haurà d'interrogar al professional que fa la petició, si el pacient que es deriva ha arribat al seu centre sanitari en una unitat SEM.

En cas afirmatiu, s'haurà de deixar constància al camp 'A' del número d'incident del servei anterior amb el text: **"Rederivació de l'incident 1111111111"**.

Cal diferenciar si el professional sanitari que realitza l'alerta sol·licita una unitat de SVA/SVI o una unitat de SVB.

5.9.8.1 Sol·licitud d'un recurs SVA/SVI

Cal procedir a la complementació de dades mitjançant l'operativa descrita als apartats 5.1 (Recepció inicial) a 5.5 (Dades de l'afectat).

A continuació:

Identificar l'alertant com a professional sanitari. Cal confirmar que l'interlocutor és un metge/metgessa i/o un/una DUI; si qui parla és un administratiu, cal sol·licitar que es posi al telèfon el professional sanitari, si això no és possible, anotar el nom del mateix i confirmar que es troba amb el pacient.

Desplegar l'OMEGA i prémer l'opció **"Transport Sanitari"**.

En aquesta situació, cal diferenciar si el professional es troba o no amb el pacient.

5.9.8.2 Professional sanitari es troba amb el pacient

Cal procedir a la complementació de dades mitjançant el procediment descrit de l'apartat 5.1 (Recepció inicial) al 5.5 (Dades de l'afectat).

A continuació:

Identificar l'alertant com a professional sanitari. Cal confirmar que l'interlocutor és un metge/metgessa i/o un/una DUI; si qui parla és un administratiu, cal sol·licitar que es posi al telèfon el professional sanitari, si això no és possible, anotar el nom del mateix i confirmar que es troba amb el pacient..

Desplegar l'OMEGA i prémer l'opció **"Transport Sanitari"**.

Complimentar l'adreça de destí, si l'alertant sol·licita un centre de destí: hospital, CUAP, CAC...

Desplegar el camp **"Tipus de recursos"** i prémer l'opció **"Amb. Medicalitzada-Mike"** o **"Amb. Sanitaritzada-India"**, segons necessitin.

Prémer al camp **"Prioritat"** fins a l'opció **"0"**.

Prémer el botó **"T.S.U."**, a continuació el botó **"Crear intervenció"** i, finalment, el botó **"Acceptar"**.

Traspassar la trucada al metge consultor, informant d'aquesta acció a l'alertant:

“L’ambulància ja està activada. No pengi, si us plau, que parlarà amb personal sanitari”.

Si un professional sanitari ens sol·licita una trasllat sanitari amb una SVA de pediatria per un pacient menor de 16 anys, s’haurà de classificar de manera habitual i es passarà a valorar directament al pediatra (**Hospitalet Consultoria Sanitaria Pediàtrica**).

En cas de que el pediatra no atén la trucada passats els quatre tons, aquesta s’haurà de passar a valorar a la taula de P0.

A la Sala Operativa Sanitària (SOS) de Reus, en cas que el personal sanitari estigui ocupat, s’activarà la unitat SVA/SVI. Se li dirà a l’alertant que pot penjar el telèfon i deixi la línia lliure, ja que el retrucaran a la major brevetat possible, recordant-li que la unitat ja està activada.

5.9.8.3 Professional sanitari no es troba amb el pacient

Cal procedir a la complementació de dades mitjançant l’operativa descrita de l’apartat 5.1 (Recepció inicial) al 5.5 (Dades de l’afectat).

A continuació:

Identificar l’alertant com a professional sanitari. Cal confirmar que l’interlocutor és un metge/metgessa i/o un/una DUI; si qui parla és un al telèfon administratiu, cal sol·licitar que es posi el professional sanitari, si això no és possible, anotar el nom del mateix i confirmar que no es troba amb el pacient.

Recollir les dades de l’adreça on es troba l’afectat, incloent-hi el número de telèfon, destí i DX.

Realitzar contacte telefònic amb el lloc on està l’afectat i confirmar les dades. Codificar la informació a l’ OMEGA (com a Malaltia a Domicili, no com a TSU) i traspasar la trucada al personal sanitari. Si no és possible el contacte telefònic amb l’afectat (cal intentar-ho durant un període de temps no superior a 2 minuts), cal anotar aquesta incidència al camp “A”: “No contesta l’afectat”, crear l’incident com “Transport Sanitari” i avisar/informar al Coordinador Tècnic/Infermer.

5.9.8.4 Sol·licitud d’un recurs SVB

Davant la sol·licitud d’un recurs SVB per personal sanitari amb independència de si es troba o no amb el pacient:

Cal procedir a la complementació de dades mitjançant l’operativa descrita de l’apartat 5.1 (Recepció inicial) al 5.5 (Dades de l’afectat).

A continuació:

Identificar l'alertant com a professional sanitari. Cal confirmar que l'interlocutor és un metge/metgessa i/o un/una DUI; si qui parla és un administratiu, cal sol·licitar que es posi al telèfon el professional sanitari, si això no és possible, anotar el nom del mateix i confirmar que es troba amb el pacient; alhora interrogar si necessita una unitat de SVB.

Desplegar l'OMEGA i prémer l'opció:

“Transport Sanitari”.

Complimentar l'adreça de destí

Per defecte, al camp **“Tipus de recursos”** apareix l'opció **“Amb. assistencial – Tango”** i no s'ha de modificar.

Per defecte, al camp **“Prioritat”** apareix l'opció **“1”** i no s'ha de modificar.

Prémer el botó **“T.S.U.”**. A continuació, prémer el botó **“Crear intervenció”** i, finalment, el botó **“Acceptar”**.

Cal informar a l'alertant que:

“Una ambulància anirà cap el lloc”.

EXCEPCIÓ: Davant d'una sol·licitud de transport sanitari de **Suport Vital Bàsic** per part d'un centre sanitari **amb orientació diagnòstica, sigui de caire respiratori**:

- *Dificultat respiratòria*
- *Infecció respiratòria*
- *Pneumònia*
- *Dispnea*
- *MPOC*
- *ASMA*
- *Emfisema*
- *Bronquitis*
- *Insuficiència respiratòria aguda(IRA)*
- *Edema Agut de Pulmó*

El gestor de demanda interrogarà la següent informació al alertant que sol·liciti el transport:

- *Saturació d'oxigen Basal?*
- *Freqüència respiratòria*
- *Si cal suport d'oxigen*

Anotarà aquesta informació al camp A després de la orientació diagnòstica. Exemple:

Dra. Sol·licita Trasllat
Dx Insuficiència Respiratòria
Sat 90%, FR 24rpm, Suport d'Oxigen

En cas que no es disposi de la informació clínica sol·licitada s'anotarà: **SENSE MÉS INFO**. No s'allargarà la trucada per obtenir aquesta informació.

Sol·licitud de Prioritzar un Recurs Tango: Si demanen prioritzar el tipus de recurs **“Tango”**, es deixa prioritat **“1”** i s'ha de passar a valorar amb personal sanitari. Anotar al camp 'A': **“Dr./a – DUI, demana prioritzar Tango”**.

En el cas que un Metge o Infermer ens truca des del Centre Sanitari i ens demana un Trasllat on el pacient és al domicili i ens diuen: **“Tinc un pacient ingressat al domicili.”**:

- Posarem a l'Omega de Transport Sanitari al camp **SERVEI**: **“Hospitalització Domiciliària”**.

També es poden rebre demandes de trasllats de pacients PCC/MACA a centres sociosanitaris i de subaguts que no consten com a hospitals de referència en el GCS. A la GCS es recull una pestanya dels centres sociosanitaris i de subaguts als quals es poden derivar aquests pacients.

Estat	Funció	Tipus Centre	Centre	Provincia	Comarca	Municipi	Submini 1
	XARXA SOCIOSA...	CENTRE DE PAL·LIATIU	Centre Sociosanitari Dolors Aleu	BARCELONA	Barcelonès	Barcelona	Sarrià-Sant Gervasi
	XARXA SOCIOSA...	CENTRE DE PAL·LIATIU	Centre Sociosanitari Mutuam Guell	BARCELONA	Barcelonès	Barcelona	Gràcia
	XARXA SOCIOSA...	CENTRE DE PAL·LIATIU	Sociosanitari Pere Virgili	BARCELONA	Barcelonès	Barcelona	Gràcia
	XARXA SOCIOSA...	CENTRE DE PAL·LIATIU	Centre Forum	BARCELONA	Barcelonès	Barcelona	Sant Martí
	XARXA SOCIOSA...	CENTRE DE SUBAGUTS	Sociosanitari Pere Virgili	BARCELONA	Barcelonès	Barcelona	Gràcia
	XARXA SOCIOSA...	CENTRE DE SUBAGUTS	Centre Sociosanitari Mutuam Guell	BARCELONA	Barcelonès	Barcelona	Gràcia
	XARXA SOCIOSA...	CENTRE DE SUBAGUTS	Centre Sociosanitari Dolors Aleu	BARCELONA	Barcelonès	Barcelona	Sarrià-Sant Gervasi
	XARXA SOCIOSA...	CENTRE DE SUBAGUTS	Centre Sociosanitari Mutuam Guell	BARCELONA	Barcelonès	Barcelona	Sant Martí

Si rebem una demanda de derivació a un centre que no és l'hospital d'aguts, però que apareix en la GCS com Xarxa Sociosanitària, realitzada habitualment per un professional d'atenció primària, metge/infermer/gestora de cas, s'ha de confirmar amb l'alertant que l'afectat ha estat acceptat per l'hospital receptor i disposa de reserva de llit.

1. L'afectat ha estat acceptat per l'hospital receptor i disposa de reserva de llit.
 - S'ha de crear un incident com transport sanitari amb les dades facilitades.
2. L'afectat no ha estat acceptat per l'hospital receptor i no disposa de reserva de llit.
 - S'ha d'indicar a l'alertant que confirmi l'acceptació de l'afectat i reserva de llit amb l'hospital receptor i torni a realitzar la petició al 061 CatSalut Respon.

5.9.9 Trasl·lat Residències MUTUAM: Obsolet eliminat.

5.9.10 Procediment Atenció Residents amb suport Consultoria Fragilitat

Aplicarem aquest procediment quan rebem una trucada des de:

- Residències geriàtriques.
- Residències de discapacitat intel·lectual.
- Residències psiquiàtriques: només en els casos de pacients de llarga estada o institucionalitzats (NO aguts).

Podem identificar les següents situacions:

Metge/sa, Infermer/a sol·licita Transport Sanitari des de Residència

(metge/infermer de la residència o del CAP que ha valorat al pacient)

El gestor de demanda ha de classificar com un transport sanitari ordinari. No ha d'utilitzar la classificació: Malaltia Domicili/fragilitat.

Ha de seleccionar Alertant: "Residència geriàtrica".

Ha de realitzar la recollida de dades habituals segons manual gestor de demanda, transport sanitari.

Ha de preguntar si el recurs requerit és una unitat de Suport Vital Bàsic o una unitat de Suport Vital Avançat i/o si es tracta d'un CODI IAM o un CODI ICTUS:

- a) En el cas de demanda de Suport Vital Bàsic, s'ha de fer la recollida de dades habituals classificant a OMEGA com transport sanitari segons manual i s'ha d'emetre la resposta prevista al manual.
- b) En el cas de demanda de Suport Vital Avançat, Codi IAM/ICTUS, s'ha de fer la recollida de dades habituals, classificar a OMEGA com Transport Sanitari segons manual i traspasar la trucada a consultoria prioritat 0.

Auxiliar clínica o gerontòleg refereix simptomatologia associada a emergència (no contesta, no respira, sagnat abundant, precipitat) sense demanda concreta de Transport Sanitari

El gestor de demanda ha de seleccionar:

Alertant: "Residència geriàtrica"

Recollir el nom del professional

Ha de seleccionar l'Omega corresponent i classificar segons l'emergència. Pej:

MALATIA DOMICILI > Ítem corresponent (no contesta, no respira, sagnat abundant.)

ACCIDENT TRAUMATISME > Ítems ferit greu, localització + causa (precipitat)

S'ha de traspasar la trucada mitjançant el botó CONSULTA (emergència).

Auxiliar clínica, gerontòleg o qualsevol professional del centre que no sigui metge o infermera, sol·licita transport des de residència que no ha sigut valorat

per cap metge o infermera o refereix simptomatologia no associada a emergència (no contesta, no respira, sagnat abundant, precipitat).

El gestor de demanda ha de seleccionar Alertant: **“Residència geriàtrica”** recollint el nom del professional.

Ha de desplegar Omega i classificar:

MALATIA DOMICILI > Fragilitat> Demanda Transport

S'ha de traspasar la trucada a la taula de Consultoria de Fragilitat mitjançant el botó CONSULTA, deixant en cua després de 4 tons.

5.9.11 Trucades amb demanda d'una ambulància per trasllats judicials i trasllats involuntaris

Davant d'una demanda d'una ambulància per Trasllats Judicials/Trasllat Involuntari s'ha de realitzar la següent operativa:

- Crear un transport sanitari amb les dades facilitades (assignar SVB).
- Anotarem qui demana el trasllat: metge o jutge al botó “M”.
- Demanar a l'alertant que enviï l'ordre judicial per fax al número: 902 106 971 (CECOS Hospitalet) o al 977 196 808 (CECOS Reus) o per correu electrònic a capdeguardia.sem@gencat.cat. Si la demanda de trasllat involuntari es des de CSM on afectat i psiquiatra (prescriptor) es troben al centre no s'ha de demanar l'enviament del fax.
- Preguntarem si necessiten Mossos d'Esquadra i contencions.
- Passarem a valorar a personal sanitari a la sala d'Hospitalet (no posarem la trucada a la cua) o al Cap de Torn a la sala de Reus.
- Al camp “A” anotarem “DX: Trasllat involuntari” i la resposta davant de la possible necessitat de Mossos d'Esquadra o contencions.

S'ha inclòs a SITREM el centre **‘Ciutat de la Justícia’** com els hospitals (H) amb la finalitat de codificar en el cas de peticions judicials el destí corresponent en un Transport Sanitari.

- En el cas que Gestió de Demanda identifiqui la petició d'un Transport Sanitari amb destí Ciutat de la Justícia, podran codificar-ho a la 'H' i sortirà el destí a la pestanya d'intervenció

5.9.12 Activació Codi ICTUS/IAM detectat per un Centre Sanitari no Hospitalari o personal sanitari que es trobi amb el pacient al domicili

La petició de trasllat sanitari per detecció de CODI IAM o codi ICTUS per personal sanitari d'un Centre Sanitari no Hospitalari o personal sanitari que es trobi amb el pacient al domicili es classificarà com a transport sanitari urgent (TSU+Crear intervenció).

5.9.12.1 Codi ICTUS

Es procedirà com a l'apartat 5.8.8.2 (sol·licitud de SVB amb presència de personal sanitari) confirmant que aquest és el nivell assistencial requerit pel trasllat. En el cas de l'Ictus, hi ha dos aspectes diferencials respecte del procediment general:

- En la sol·licitud de SVB per part d'un professional sanitari, s'assigna per protocol una intervenció de SVB prioritat 1; però, en el cas de l'Ictus, el Gestor de demanda **ha de canviar la "prioritat 1" a "prioritat 0"**. Al camp "A" cal anotar "ACTIVACIÓ CODI ICTUS".
- **Sempre ha de passar la trucada** a personal sanitari per tal d'iniciar el procés d'activació del codi. Informar a l'alertant: *"La ambulància ja està activada, si us plau, no pengi que pengi parlarà amb personal sanitari"*.
- **No s'ha de complimentar el destí hospitalari**

5.9.12.2 Codi IAM

Es procedirà com a l'apartat 5.8.8.1 (sol·licitud de SVA per part de personal sanitari). Recordar els diferents noms amb els quals es pot realitzar aquesta demanda: Codi IAM, IAM, infart, codi infart, SCA amb elevació del ST (SCAEST).

Les accions a realitzar són:

- Recollir les dades bàsiques de l'incident.
- Confirmar que l'alertant és personal sanitari i, si no ho és, demanar que es posi si és possible. Indicar l'alertant com professional sanitari i anotar el nom.
 - A l'Omega seleccionar "TRANSPORT SANITARI".
 - Com a "Tipus de recursos" triar "Amb. Medicalitzada".
 - No s'ha de complimentar el destí hospitalari.
 - Prémer el camp "Prioritat" fins a l'opció "0"
 - Prémer el botó "TSU", el botó "Crear intervenció" i, finalment, "Acceptar".
 - Al camp "A" cal anotar "ACTIVACIÓ CODI IAM".
 - Informar a l'alertant: *"La ambulància ja està activada, si us plau, no pengi que pengi parlarà amb personal sanitari."*

5.9.13 Gestió de demandes de transport des de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya

Davant les trucades entrant al 061 de la llevadora ALPACC sol·licitant un transport sanitari. Aquesta s'identificarà com a llevadora ALPACC i facilitarà el seu número de col·legiada. Des de gestió de demanda, es classificarà el tipus de alertant com "Llevadora ALPACC".

47 Llevadora Alpacc

Es complementarà dades de localització i filiació segons procediment de gestió de demanda.

Classificarem la trucada com a **Malaltia Domicili**→**Ginecologia/Obstet** → **Part en curs**

5.9.14 Sol·licituds de transports sanitaris a centres d'Atenció Intermèdia (ATINT)

Aquests trasllats sempre seran demanats pel metge responsable del pacient (generalment Atenció Primària, PADES,...) o per gestors de casos. Els trasllats tindran un destí concret que no es podrà canviar, en cap cas, des de la CECOS.

Prèviament a la sol·licitud, el professional sanitari responsable del pacient ja haurà esgotat les possibles vies de trasllat amb Transport sanitari no urgent (TSNU) i el pacient tindrà lliat concertat amb centre de destí indicat durant la demanda del servei

La gestió de demanda, quan rebí aquest tipus de petició les podrà identificar de diferents maneres:

- El sol·licitant s'identifica i demana explícitament un trasllat a un centre d'Atenció Intermèdia (ATINT) indicant que es un trasllat a Atenció Intermèdia.

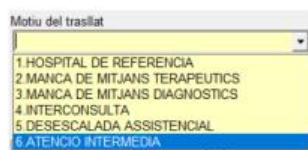
En aquest cas el gestor-a SERVEO actuarà com en qualsevol sol·licitud de transport sanitari per personal qualificat i anotarà **al Camp A: "SERVEI ATINT"**

- El sol·licitant s'identifica i demana el trasllat sanitari sense especificar el tipus de trasllat però sí indicant el destí, i aquest consta al programa de gestió d'incidents com tipologia ATINT.

En aquest cas el gestor-a SERVEO **interrogarà activament al sol·licitant sobre si el trasllat es de la tipologia ATENCIO INTERMEDIA**, si es afirmatiu s'actuarà com en el cas anterior.

Adreça Centre Forum **ATINT**

Un cop recollides les dades de l'afectat, es crearà pantalla de transport sanitari indicant origen i destí i s'emplenarà la casella de motiu de trasllat amb l'opció **"ATENCIO INTERMEDIA"**



Aquestes peticions, per norma general, no passaran per consulta sanitària a no ser que hi hagi una petició explícita del professional sanitari peticionari.

Per aquesta raó, des de gestió de demanda, **sempre s'assignarà SVB amb Prioritat 1. Indicant:**

Una ambulància anirà cap el lloc.

En cas de que la petició sigui d'alguna **altra tipologia de recurs o de prioritat es passarà a la taula de fragilitat per combo:**



Indicant: La frase d'acomiadament habitual per la tipologia de transport demanat (SVB P0 o SVA):

- SVA/SVI: "L'ambulància ja està activada. No pengi, si us plau, que parlarà amb personal sanitari"
- Tango Prioritat 0: "Una ambulància anirà cap el lloc. No pengi, si us plau, que parlarà amb personal sanitari"

5.9.15 Trucades amb demanda d'un trasllat Inter-hospitalari

La demanda de trasllats interhospitalaris al CECOS de SEM es realitza pel telèfon 902 33 50 33 a la sala d'Hospitalet. Aquesta trucada es direcciona a uns gestors específics de la sala d'Hospitalet, gestors de demanda d'interhospitalari, i si estan ocupats salta a qualsevol dels gestors de demanda de primer nivell de la sala d'Hospitalet.

Si la demanda d'un trasllat interhospitalari es produeix a la sala de Reus, el gestor de demanda de primer nivell de la sala de Reus ha de transferir la trucada al gestor de demanda de primer nivell d'interhospitalari a través del telèfon 902 33 50 33. Ha d'informar a l'alertant de la transferència i indicar-li el número al qual ha de trucar pel seguiment de l'incident o per properes peticions de trasllat (902 33 50 33).

"Li transfereixo amb interhospitalaris. Pel seguiment d'aquest trasllat o per properes peticions ha de trucar al 902 33 50 33."

El gestor de demanda de primer nivell de la sala de Reus tancarà l'incident com una informació breu i el gestor de demanda de primer nivell d'interhospitalari iniciarà la classificació de l'incident.

Considerarem Trasllat Interhospitalari totes les alertes que l'afectat estigui a un Hospital que al carregar al Sitrem consti (S) o (X).

Exemple: Bellvitge, Hospital Universitari de(S) / Hosp
Guttmann, Institut(X) / Hosp

5.9.15.1 Accions específiques del gestor de demanda de primer nivell

Entenem com a trasllat interhospitalari tots aquells centres que SITREM ho indica amb una (S) o una (X). Per tant, l'operativa serà:

- **El CSM Institut Pere Mata de Reus** que té el seu propi procediment, comunicat 2019_03_26_Procediment temporal trasllats IPM Reus.
- **L'Hospital Santa Creu i Sant Pau** que segons la localització del pacient es codificarà com un trasllat secundari o segons simptomatologia seguint el comunicat 2021_03_03_(62).
- **L'Hospital/Cuap Dos de Maig** si el pacient es troba localitzat a urgències que es codificaria com a transport primari.

1. Part superior dreta escollir l'opció 'Incident només'.
2. Alertant: (41) Hospitals o Centres Sanitaris.
3. Confirmar telèfon: **"El seu telèfon de contacte és el: "....."?"**
4. **M:** Ítem al costat del desplegable d'alertant. Cal complimentar amb el nom del personal sanitari (Dr. / Dra. o DUI) que sol·licita el trasllat IH així com, també, preguntarem a quin servei pertany.

En principi, qui ens ha de trucar per fer el trasllat és el metge/ssa responsable del pacient perquè ens ha de donar la informació clínica.

Si no ens truca el facultatiu/va, li podem agafar les dades que es necessiten amb l'alertant que ens truca, però els hi hem d'indicar que és necessari que ens passi al Dr. / Dra. per tal de passar-ho a valorar a IH.

****EXCEPCIÓ**:** DUI pot demanar el trasllat només quan aquests són ja pactats entre els Hospitals i només si necessiten una SVB i aquests serveis **s'han de traspasar a ACIH.**

En cap cas, **mai passariem la trucada a valorar a taula d'IH si qui alerta no és personal sanitari (metge/ssa), sol quan es compleix l'excepció a dalt indicada.**

5. Recollir municipi i adreça d'hospital. Cal escriure el nom de l'hospital o centre sanitari. S'ha de prémer el botó **H** i, a continuació, obrir el desplegable per confirmar si és correcte. Altra opció, és escriure part del nom, prémer el botó **H** i obrir el desplegable on apareixeran tots aquells centres que continguin les lletres marcades i, a continuació, prémer a sobre del que correspongui. I confirmar l'adreça que es carrega automàticament al 'Complement d'adreça'.
6. Ubicació del pacient i EXT (**"Si us plau, em pot facilitar el número d'extensió del servei?"**). Es deixarà anotat a "Complement d'adreça".

7. Dades de l'afectat: Cal complimentar el nom i els cognoms del pacient; l'edat; el sexe i el CIP / DNI / NIE, si es disposa del mateix (Demanar com a primera opció el CIP per validar, com a segona opció demanar el DNI / NIE).
8. Seleccionar tipus de demanda, és a dir, OMEGA Transport Sanitari.
9. Preguntar: **“És per activar un CODI IAM o qualsevol altre CODI?”**

a) Si es tracta d'un **CODI IAM** d'origen (no un retorn a l'Hospital que l'ha derivat per tractar el CODI IAM):

- No s'ha de complimentar el destí hospitalari.
- Seleccionar com a tipus de recurs Medicalitzada pr.0.
- Prémer “T. Secundari” + “Crear Intervenció” + Acceptar.
- Anotar al camp A: ACTIVACIÓ CODI IAM.
- Informar l'alertant: *“Si us plau no pengi, parlarà amb la taula d'interhospitalaris”*.
- Transferir la trucada pel botó INTERHOSP.
- En el cas que la taula estigués ocupada, es transferirà la trucada per Combo a “CODI IH”. Si continués ocupada, transferim a INFERMERIA CAP DE TORN, CAP DE TORN, CT1-2-3 i 4, per aquest ordre. Si no es pot contactar, posteriorment es seguirà amb la ronda de trucades iniciant per CG sense encuar en cap cas la trucada si no s'obté resposta.

a) Si no es tracta d'un CODI IAM d'origen, però si **d'un altre CODI**:

- No s'ha de complimentar el destí hospitalari.
- No seleccionar cap recurs.
- Prémer “T. Secundari” i “Acceptar”.
- Informar l'alertant: *“Si us plau no pengi, parlarà amb la taula d'interhospitalaris”*.
- Anotar al camp 'A': CODI XXX.
- Transferir la trucada pel botó INTERHOSP.
- En el cas que la taula estigués ocupada, es transferirà la trucada per Combo a “CODI IH”. Si continués ocupada, transferim a INFERMERIA CAP DE TORN. En el cas dels gestors de demanda IH, després de la trucada al tel·lèfon CODIS IH. Posteriorment es trucarà a INFERMERIA CG, sense encuar en cap cas la trucada si no s'obté resposta.
- Si la trucada no es pogués transferir perquè el personal sanitari estigués ocupat, s'informarà a coordinació de demanda urgentment.

b) Si la resposta fos negativa, preguntarem a l'alertant si es tracta d'una emergència, però no un CODI:

c.1) Si, es tracta d'una emergència

- No s'ha de complimentar el destí hospitalari.
- No seleccionar cap recurs.
- Prémer "T. Secundari" i "Acceptar".
- Informar l'alertant: *"Si us plau no pengi, parlarà amb la taula d'interhospitalaris"*.
- Anotar al camp 'A': **EMERGÈNCIA NO CODI.**
- Transferir la trucada pel botó INTERHOSP.
- En el cas que la taula estigués ocupada, es transferirà la trucada per combo a INFERMERIA CAP DE TORN, sense deixar en cua en cap cas la trucada si no s'obté resposta.
- Si la trucada no es pogués transferir perquè el personal sanitari estigués ocupat, s'informarà a coordinació de demanda urgentment.

Si la gestió de la demanda d'un trasllat interhospitalari NO és un CODI IAM o qualsevol altre CODI i l'alertant també ens indica que NO és una emergència. **Caldrà anotar al camp A NO EMERGÈNCIA**

c.2) No, no es tracta d'una emergència: S'haurà de preguntar si el trasllat es pot realitzar amb una convencional:

c.2.1) ES POT REALITZAR AMB CONVENCIONAL

- No s'ha de complimentar el destí hospitalari.
- No seleccionar cap recurs.
- Prémer "T. Secundari" i "Acceptar".
- Informar l'alertant: *"Si us plau no pengi, parlarà amb la taula d'interhospitalaris"*.
- Anotar al camp 'A':
 - **NO EMERGÈNCIA**
 - **SVB.**
- Transferir la trucada per combo a ACIH.
- En el cas que ACIH estigui absent, es realitzarà la transferència per botó INTERHOSP.

c.2.2) NO ES POT REALITZAR AMB CONVENCIONAL

- No s'ha de complimentar el destí hospitalari.
- No seleccionar cap recurs.
- Prémer "T. Secundari" i "Acceptar".
- Informar l'alertant: *"Si us plau no pengi, parlarà amb la taula d'interhospitalaris"*.
- Anotar al camp 'A':
 - **NO EMERGÈNCIA**
 - **SVA.**
- Transferir la trucada per botó INTERHOSP.
- En el cas que no es pugui transferir la trucada, passarem la trucada a:
 - ACIH i li indicarem que no és SVB, però que IH està ocupat.

Cal recordar que la posició d'ACIH actualment només està operativa en horari diürn de 08-20h, si no hi són, la trucada es transferirà a IH directament.

Transferències de trucades relacionades amb Auxiliar de Coordinació IH

Totes aquelles trucades relacionades amb ACIH es passaran de la següent manera:

- Hospitalet Auxiliar Coordinació SSEE 1:
 - Es passen les trucades de petició de SVB en trasllats Inter-hospitalaris
 - Peticions trasllats de psiquiàtrics Inter-hospitalaris.
- Hospitalet Auxiliar Coordinació SSEE 2:
 - OCATT
 - UCO
- Hospitalet Auxiliar Coordinació SSEE 3:
 - Totes les trucades relacionades amb extracomunitaris.

Si les posicions estan ocupades o buides, les trucades es deriven directament.

Totes les peticions de trasllat interhospitalari en que l'afectat sigui un **menor de 16 anys**: Han de ser derivades al Pediatre consultor que tenim a la sala utilitzant la opció de **Hospitalet Consultoria Sanitaria Pediàtrica**.

- Si no es pogués transferir la trucada, es preguntarà a l'alertant si es tracta d'una emergència i si és així, seguirem el procediment del punt C.1
- Si no es tractés d'una emergència, es contactarà per combo Hospitalet Auxiliar Coordinació SSEE 1 perquè informi al Pediatre quan estigui disponible.
- En el cas que no es pogués comunicar amb Hospitalet Auxiliar Coordinació SSEE 1, s'informarà a coordinació de demanda.

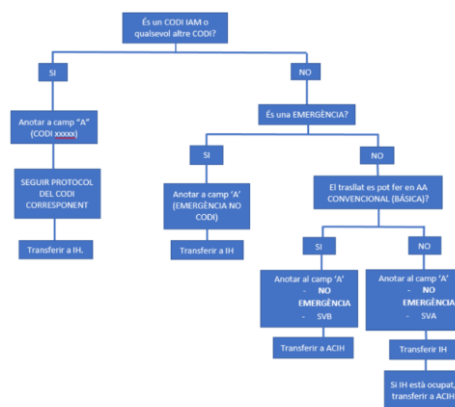
NO US CONFONEU amb Hospitalet Consultoria Sanitària Pediàtrica SP que es tracta del pediatre de l'Hospital Sant Pau. Sempre es mirarà si en el moment de passar la trucada està absent o està parlant amb un altre interlocutor.

Altres accions específiques

- Si personal sanitari que demana el trasllat demana parlar amb el **metge de crítics**, marcarem l'extensió 22714 i restarem a l'espera de ser atesos.
- En el cas de pacients psiquiàtrics d'origen de centres psiquiàtrics (X ó S), es transferiran per combo a la posició ACIH. En el cas que no es pugui transferir la trucada, s'indicarà a l'alertant que la taula d'IH està ocupada i que retruqui en 10 minuts.
- En el cas d'alertes de pacients de la Casa Sofia vinculat a l'hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues del Llobregat, la trucada pot entrar al 061 Salut Respon com a alertant VIP si es truca des del mòbil del pediatre o bé al 061Salut Respon. En tots dos casos, poden trucar per emergències vitals o al IH per trasllats no crítics i s'ha de traspasar la trucada al pediatre de sala independentment de l'edat del menor. Si no es pogués transferir la trucada, s'avisarà a coordinació de demanda.

Aquestes accions han de ser realitzades per qualsevol gestor de demanda de primer nivell, inclosos els gestor d'interhospitalari de les sales d'Hospitalet o Reus.

ESQUEMA TAULA RESUM PROCEDIMENT IH



5.9.15.2 Trasllats Inter-hospitalaris amb arribada-sortida pacient des de l'Aeroport del Prat de Llobregat

Arribada d'un malalt amb un vol des d'un altre territori o sortida cap a un altre territori des d'aquí.

Dades bàsiques que s'hauran d'obtenir i enregistrar des d'operació de demanda:

- Dades del demandant del trasllat (061-112 d'altres comunitats autònomes, hospitals...):
 - Nom i cognoms del responsable de la sol·licitud.
 - Telèfon directe de contacte.
- Dades del pacient a traslladar:
 - Filiació
 - Patologia que presenta a l'actualitat.
 - Mobilitat (precisa llitera, cadira rodes, deambula)
 - Acompanyants
- Característiques del trasllat:

En cas que sigui d'arribada a l'aeroport:

- Identificar si el malalt és greu o no, i si requereix unitat de SVB, SVI o SVA.
- Hora arribada a l'aeroport.
- Hospital receptor (unitat de destí i metge responsable).
- Equip assistencial acompanyant. Cal esbrinar si aquest efectuarà el trasllat fins a l'hospital receptor (trasllat de retorn a l'aeroport) o farà el trànsfert al mateix aeroport.

En cas de sortida a l'aeroport:

- Hora i unitat de sortida del centre emissor.
- Equip assistencial acompanyant. Cal saber si aquest efectuarà el trasllat fins a l'aeroport (trasllat de retorn de l'aeroport) o seguirà amb el trasllat a l'aeronau.
- Dades del vol:
 - Tipus aeronau i de vol (sanitari, comercial).
 - Aeroport de procedència o destí.

- Número de vol i nom companyia (si es tracta d'un vol comercial) o número de matrícula (vol sanitari).
- Hora estimada sortida i arribada.

S'haurà de sol·licitar l'enviament d'un fax amb totes les dades anteriors com a document de confirmació.

5.9.15.2.1 Transports sanitaris procedents Illes Balears i Canàries

Hi ha un protocol específic pels gestors de demanda d'Inter-hospitalaris referent a la sol·licitud de Transports Sanitaris procedents de les Illes Balears i Canàries.

Per tant, quan a primer nivell rebem una trucada referent a aquest tipus de sol·licitud, sempre consultarem amb coordinació de com procedir.

5.9.15.3 Pacients Procedents d'Andorra (SAAS)

A l'hora de gestionar les demandes de trasllat Inter-hospitalari procedents del SAAS (Servei Andorrà d'Atenció Sanitària)

Els gestors d'Inter-hospitalaris, per tal de tenir identificats tots els pacients provinents d'Andorra, s'anotaran sempre com a origen: Hospital Nostre Senyora de Meritxell, independent que el trasllat es faci amb l'helicòpter del SUM d'Andorra i la unitat SVA del SEM només faci el trànsfert des de l'helisuperfície a l'hospital receptor.

5.9.15.4 Excepcions en trasllats Inter-hospitalaris

Existeixen 2 excepcions relacionades amb l'Institut Pere Mata (ICM) de Reus i l'hospital Sant Pau de Barcelona.

Pere Mata, Institut(X) / CSM

En aquest cas, segons el motiu del trasllat s'ha de procedir d'una forma o altre:

1. **No es patologia psiquiàtrica:** Trasllat primari. (TSU + Crear intervenció).
2. **Patologia psiquiàtrica que requereix contenció:** Trasllat gestionat per Inter-hospitalaris (T. Secundari).
3. **Patologia psiquiàtrica sense contenció:** aquests tipus de trasllat ho fan les ambulàncies no urgents de la zona (TSNU) (derivar a segon nivell si no saben a quina empresa han de trucar per demanar el trasllat).

Davant de qualsevol dubte o reclamació consultar amb coordinació.

Santa Creu i Sant Pau, Hospital de la(S) / Hosp.

Davant d'una situació mèdica aguda i crítica generada fora de l'Hospital Sant Pau, però dins del recinte Hospitalari (diversos pavellons), haurem de gestionar la demanda de petició d'ambulància com una Emergència i, en funció, de la casuística de la trucada es classificarà com:

- Malaltia Lloc Públic
- Accident / Traumatisme

Les ubicacions dels diferents pavellons que formen el recinte són:

- Unitat de Conductes Additives- Pavelló 20, accés 3

- Unitat de Rehabilitació/RX ressonància-Pavelló 20, accés 1
- Consulta Externa de Psiquiatria- Pavelló 18, planta 1
- Hospital de Dia Onco-Hemato- Pavelló 18, planta 2
- Pavelló Santa Victòria- Unitat d'Alzheimer-Down
- Escola Patologia del Llenguatge
- Pavelló Sant Frederic
- Fundació Kalida

5.9.16 Trucades amb demanda d'un trasllat extracomunitari

La demanda sempre serà informada per correu electrònic a la bústia: **Bústia Extracomunitaris**, que reben els gestors de demanda de primer nivell d'interhospitalari, els professionals de la taula d'inter hospitalari i el ACIH amb la documentació clínica adjunta.

Hi ha un telèfon específic per a extracomunitaris, 933038159 que es el que s'ha de facilitar per aquest tipus de servei.

Els gestors de demanda podran rebre trucades de les unitats de l'empresa proveïdora (Falck) que realitzen aquests tipus de trasllats per informar de les hores del servei, aquestes trucades s'han de passar per combo a Hospitalet Auxiliar Coordinació SSEE 3.

5.9.17 Consulta Especialista

En aquest punt es poden trobar la consultoria amb el Metge de Complexitat, la consulta de Suport Psicològic, la Consultoria Pediàtrica, la Consultoria de Fragilitat i la Consultoria ICO que es disposen en una mateixa pantalla, **sense variació en l'operativa d'utilització que existeix fins ara, a excepció de la classificació del Suport Psicològic**, on apareix una variació i la Consulta a Taula Risc Suïcidi que s'afegeix com a nova Consulta Especialitzada.

La classificació per Tipus de Consulta (Consultoria Metge complexitat, Consultoria Pediàtrica, Consultoria Taula Risc Suïcidi) **estan restringides a alertants qualificats sanitaris (metges o infermeria)**:

5.9.17.1 Taula de Risc i Suïcidi

És de nova creació. **Està restringida a alertants metge/infermeria de primària.**

Es farà servir quan ens expressin que volen fer una consulta a la Taula de Risc Suïcidi.
Es traspassa la consulta a Taula de Salut Mental.

5.9.17.2 Consultoria ICO

Aquesta classificació està restringida a pacients oncològics que tenen com a referència els diferents Centres de l'Institut Català d'Oncologia.

Els centres de referència ICO que hi ha són els següents:

- ICO Municipal Badalona
- ICO Badalona
- ICO Esperit Sant
- ICO Girona
- ICO Hospitalet
- ICO Igualada
- ICO Sant Joan Despí
- ICO Tarragona
- ICO Tortosa
- Fundació Hospital Esperit Sant (FHES), Santa Coloma de Gramenet (Tel: 933860202)
- Xarxa de Santa Tecla, Tarragona (Tel: 977259900)
- Hospital de Mataró, Mataró (Tel: 937417700)

En aquest cas, la trucada d'alerta pot entrar per diverses vies i ens podem trobar davant de diverses casuístiques:

- Pel 061 o 112 i es pot identificar que l'afectat està dins del grup de pacients ICO 24 hores. Descartada la situació d'emergència vital, si la trucada entra a la Sala CECOS Hospitalet, cal classificar-la com: CONSULTORIA ICO 061 i seguir l'operativa descrita.
- Si la trucada entra a la Sala CECOS Reus, s'ha de transferir la trucada al 934014105 (redirigit a la Sala CECOS d'Hospitalet) i cal informar al gestor de demanda de la Sala Hospitalet de la incidència. Aquest gestor ha d'obrir un nou incident com Consultoria ICO 061 i realitzar la seva gestió. El primer gestor ha de finalitzar l'incident com Informació Breu.
- En ambdós casos anteriors s'ha d'identificar a l'alertant que el número al qual ha de trucar per noves demandes és el 934014105 (ICO 24h).

Després, els passos a seguir són els següents:

- **Selecció de l'alertant:** segons indicacions del manual.
- **Dades de localització de l'incident:** segons indicacions del manual:
 - Emergència Vital i Consultes Sanitàries: localització completa.
 - Consultes Administratives: Municipi + Adreça Desconegut
- **Dades de filiació de l'afectat:** segons indicacions del manual:
 - Emergència Vital: només edat i sexe.
 - Consultes Sanitàries: és obligatòria la recollida del nom i cognoms de l'afectat així com del D.N.I. / CIP.
 - Consultes Administratives: només el nom de l'afectat.

- **CLASSIFICACIÓ:**

d) En el cas que l'alertant ens informa de:

- **Emergència Vital:** no respira i/o no contesta, respira amb dificultat/no pot parlar.
- **Altres situacions d'emergència:** Hemorràgia (sagna molt), Convulsions o Accidents Greus.

OMEGA: Malaltia Domicili > Seleccionar les pestanyes corresponents i seguir indicacions de SITREM. El gestor ha de realitzar el traspàs de la trucada pel botó de CONSULTA.

e) En el cas que l'alertant ens informa de qualsevol **ALTRE SITUACIÓ CLÍNICA** diferent a l'anterior, **el gestor de demanda ha de classificar l'incident a l'OMEGA DE CONSULTA ESPECIALISTA:**

- El gestor de demanda ha de preguntar a l'alertant:
 - **Quin és l'ICO de referència de l'afectat.**
 - **Si l'afectat està realitzant quimioteràpia.**
- Prémer el botó "Consulta Sanitària ICO 061" + Acceptar.
- Al camp 'A': Escriure el motiu de la demanda.
- Traspassar la trucada a través del botó Consulta Sanitària de la barra de telefonia al metge consultor ICO. Si no contesta als 4 tons, indicar a l'alertant que pengi i el metge el retrucarà (confirmar el telèfon de contacte).

f) En cas de que l'alertant **SOL·LICITI INFORMACIÓ SANITÀRIA** (telèfons de centres sanitaris, adreces, incidències sobre ambulàncies programades, farmàcies de guàrdia, etc.), el gestor ha de recollir el nom de pila de l'afectat. S'ha de classificar com **Consulta Especialista:**

- Recollir al desplegable "Centre ICO de Referència del pacient".
- No s'ha de preguntar res sobre si està realitzant quimioteràpia o no.
- Prémer l'etiqueta "Consultoria Administrativa ICO 061" + Acceptar.
- S'ha de traspassar la trucada a segon nivell a través del botó de CONSULTA de la barra de telefonia.

Davant les consultes referents a la **normativa accés a la UACO de l'ICO Hospitalet per familiars i acompanyants** hem de procedir de la següent manera:

- Classificar com "Consultoria ICO 061".
- Recollir al desplegable "Hospitalet" com a centre ICO referència del pacient.
- Seleccionar l'etiqueta "Consulta Administrativa ICO 061".
- Traspassar la trucada a Consulta Administrativa.

Les alertes que entren a través del telèfon de ICO 24 hores, hem de tenir en compte que són trucades derivades i el telèfon que apareix no és de l'alertant/afectat, per tant, sempre demanarem un telèfon de contacte de l'alertant/afectat.

5.9.16.2.1 Sol·licitud de Transport Sanitari a través del servei ICO 24 hores

A través de la línia de l'ICO 24h podem rebre trucades de personal sanitari sol·licitant un transport sanitari per pacients que es troben al domicili.

Aquests casos haurem de diferenciar a quin servei o centre pertany el personal sanitari que fa la sol·licitud:

- **Personal sanitari de la UACO:**
 - Farem Transport Sanitari (TSU) amb l'operativa habitual.
 - Anotarem el nom del metge/ssa o DUI i al camp "Servei" anotarem UACO.
 - Destí: ser molt curós amb la classificació del centre sol·licitat.
- **Resta de personal sanitari (CAP, CUAP, ...):**
 - Traspassarem la trucada al 061 (marcant el 38001).
 - Informarem a l'alertant que li traspassem la trucada al 061 Salut Respon, perquè per aquest tipus de sol·licituds no ha de trucar al servei ICO 24h, sinó que ha de trucar directament al 061 Salut Respon i, que ho tingui en compte per les següents ocasions.

5.9.17.3 Suport Psicològic

Aquesta classificació està restringida al personal sanitari qualificat: metge/ssa o infermeria / centres sanitaris, personal sanitari de hospital Mutua Terrassa i hospital Trueta, cossos de seguretat, cossos de rescat, entitats responsables com: ajuntaments, responsables escolars. No pot ser utilitzada per altres alertants.

Al seleccionar Suport Psicològic s'obre una pregunta encadenada que demana concretar el tipus de suport:

- Violència Sexual: aquesta opció s'utilitza, com fins ara, per classificar peticions de suport psicològic de centres sanitaris en situacions relacionades amb la violència sexual en la gestió dels quals no ha participat SEM (no hi ha incident previ a SITREM).
- Altres: aquesta opció s'ha d'utilitzar per altres raons (demandes suport psicològic per Mossos en incidents en els que no ha intervingut SEM, ...).

Cal seleccionar el tipus, clicar d'Acord + Acceptar.

Aquesta classificació traspasa la consulta a l'equip de Cap de Torn / Infermera de Cap de Torn per valoració.

En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

CONSULTA ESPECIALISTA

INSTRUCCIONS:

- Si s'escull un ítem de Tipus de Consulta NO s'ha de seleccionar cap ítem de Consultoria ICO
- Si és Consulta ICO NO seleccionar cap ítem de Tipus Consulta, i escollir obligatòriament entre Sanitària i Administrativa

Tipus de Consulta
Tipus de Consulta només per alertants qualificats / entitats

☐ Consulta Fragilitat
☐ Consultoria Metge Complexitat
☒ Suport Psicològic
☐ Consultoria Pediàtrica
☐ Taula Risc Suïcidi

Consultoria ICO

☐ Consulta Sanitària ICO 061
☐ Consulta Administrativa ICO 061

Centre ICO referència del pacient:

Realitzant quimioteràpia? ☐ Si ☐ No ☐ ?

Cancel·la Accepta

Preguntes

Tipus de suport?

Resposta a escollir

Cancel·la d'Acord

El traspàs d'aquestes consultes es farà a través del botó CONSULTORIA SANITARIA de la barra de telefonía.

5.9.17.4 Consulta Fragilitat

Si ens truca metge/ssa, infermer/a, auxiliar clínica, gerontòleg o altre personal sanitari que vol realitzar una consulta a l'especialista de fragilitat.

S'ha de recollir les dades habituals segons el manual d'operador de demanda:

- Alertant: Residència Geriàtrica / Recollir el nom de metge/ssa, infermer/a, auxiliar o gerontòleg i si és personal sanitari preguntar també a quin centre pertany.
- Afectat: dades de la persona per la que es demana la consulta.

S'ha de desplegar l'OMEGA i classificar com:

CONSULTA ESPECIALISTA > Tipus de consulta > Consulta Fragilitat.

El traspàs d'aquesta trucada es farà a través del botó CONSULTORIA SANITÀRIA de la barra de telefonia.

5.9.18 Trucades d'idiomes

Quan entra trucada en un idioma NO anglès o francès al 061 Cat Salut Respon:

a) **Si l'avís ve de 112 i tenim dades de Localització i Classificació:**

- Generem incident a partir de la simptomatologia escrita a 'Ext. Org' i, després, transferirem la trucada a 'Hospitalet Servei de Traducció'. En aquest cas, segon nivell ja s'encarregarà de passar-ho on derivi Sitrem. Gestors de primer nivell no s'han de quedar a la conferència.

b) **Si NO tenim dades de Localització o Classificació farem:**

- A Nova Trucada: Dades Desconegudes.
- A Omega: At. No Presencial No Urg + Consulta Administrativa.
- Contactem amb Hospitalet Servei de Traducció i facilitem el nº d'INCIDENT que hem generat com a consulta administrativa i ens quedem en línia.
- 2º Nivell es posa en contacte amb el traductor.
- Un cop en línia amb el traductor, segon nivell ha de retirar-se de la conferència, quedant només gestor de primer nivell, alertant/afectat i traductor: Fem 'Nova Trucada' amb les dades de Localització i Classificació que aconseguim amb el traductor en línia.
És important anotar al 'camp A', l'incident anterior de 'Consulta Administrativa' per saber a partir de quin incident s'està realitzant la traducció.
- Un cop classificada la trucada, a l'hora de transferir on derivi Sitrem, mai deixarem en cua una conferència a 3. I, un cop contactem amb personal sanitari, transferirem tant a alertant/afectat com a traductor, quedant gestor de primer nivell fora de la trucada.

- Un cop finalitzada la traducció, personal sanitari s'encarregarà de finalitzar el servei de l'incident anotat al camp 'A'.

c) **Si l'alertant ens penja a 1º Nivell:**

- Gestor de 1º Nivell tanca comunicació posant-se en DISPONIBLE i continua amb la gestió 2º Nivell.

Quan entra trucada en anglès o francès al 061 Cat Salut Respon:

a) **Si l'avís ve de 112 i tenim dades de Localització i Classificació:**

- Generem incident consultant el botó "Org. Ext." I, després, transferim al gestor de demanda d'anglès o francès pel desplegable de la barra de telefonia escollint l'opció: Hospitalet Operador Anglès o Hospitalet Operador Francès, quedat el gestor de primer nivell fora de la trucada.

b) **Si NO tenim dades de Localització o Classificació farem:**

- Un cop rebuda la trucada, se'ns obrirà la pantalla 'Nova Trucada' i, sense demanar cap tipus de dades, contactem amb Hospitalet Operador Anglès o Hospitalet Operador Francès, informem de trucada en anglès o francès, facilitem telèfon de l'alertant i traspassem la trucada i fem:
 - A 'Nova Trucada': Dades Desconegudes
 - A Omega: Informativa breu, al camp "A" escriurem Traducció anglès o francès i passo a GD anglès o francès.

En el cas que el **GD d'idiomes** (anglès/francès) estigui **ocupat** i no pugui atendre la trucada immediatament, s'ha de **transferir la trucada al GD de segon nivell** per a que contacti amb el servei de traducció (Omega Aten. No presencial/No urgent - Consulta Administrativa). Si el **GD d'idiomes queda lliure** mentrestant intentem contactar amb l'empresa de traducció, **li transferirem la trucada** a aquest i anul·larem el servei a l'empresa de traducció.

5.9.19 Servei d'interpretació de llengua de signes

El 061 Salut Respon disposa d'un servei d'interpretació de llengua de signes. Aquest servei s'adreça tant a la ciutadania com als professionals de la salut, per donar resposta a les possibles dificultats que sorgeixin quan atenguin persones sordes.

La classificació davant la sol·licitud d'aquest servei serà:

- Omega: AT. NO PRESENCIAL / NO URG.
- Etiqueta: Consulta Administrativa

Per realitzar la transferència diferenciarem 3 possibles situacions:

- Centres mèdics o ciutadans que sol·liciten informació de com accedir al servei d'interpretació de llengua de signes:
 - Primera opció: Gestor de llengua de signes (4 tons de trucada).
 - Segona opció: Gestor de consulta administrativa (si el gestor de llengua de signes està ocupat o no pot atendre la trucada). Es pot encuar.

- Centres mèdics que necessiten contactar en aquest moment amb un usuari sord al domicili (no es troba al centre):
 - Gestor de llengua de signes
- Centres mèdics, personal sanitari i unitats assistencials que necessiten un intèrpret de llengua de signes per un pacient in situ:
 - Gestor de llengua de signes

La transferència als gestors de llengua de signes s'ha de fer a través de la barra de telefonia (combo) escollint l'opció "Hospitalet Servei Traducció Llengua de Signes" i no es pot deixar en cua. Si es demora la transferència als gestors de llengua de signes, informarem immediatament a coordinació.

5.9.20 Incidències concretes Atenció Primària

En tots els casos on l'alertant informa que no ha pogut contactar telefònicament amb el seu cap o quan el CAP no visita presencialment, el gestor de demanda haurà de registrar la incidència.

Es registra al desplegable de "Maniobres i Tractaments" a la pantalla d'afectat:

- AP NO ACCÉS TELÈFON: quan el CAP no contesta el telèfon
- AP NO VISITA PRESENCIAL: quan el CAP no visita presencialment.

The screenshot shows the 'Afectats' form in the Serveo system. The 'Maniobres i Tractaments' dropdown menu is highlighted with a red rectangle, showing options like 'AP No visita presencial' and 'AP No accés telèfon'. The form includes fields for patient data (Nom/Cognom, Edat, Sexe, etc.), address, and various medical and administrative details.

5.9.21 Alertant Banc de Sang i Teixits (BST)

El Banc de Sang i Teixits (BST) és una empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió, entre d'altres, de garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya.

Una de les moltes funcions del BST és l'extracció de sang fora dels seus laboratoris, ja sigui tant en domicilis, residències o els coneguts autocars itinerants.

Tot i que l'extracció de sang no suposa un perill, algunes vegades els pacients poden presentar quadres de mareig, lipotímia, quadres vagals, etc. La gran majoria de vegades, aquest contratemps son resolts pel propi personal sanitari que està realitzant

l'extracció tot i que, en alguna ocasió, el problema no es pot resoldre i cal el suport d'una unitat de Suport Vital Avançat.

És per aquest motiu que el Banc de Sang i Teixits ha estat inclòs en el llistat d'alertants de Sitrem.

Davant d'una trucada de BST, caldrà codificar correctament l'alertant, el telèfon de contacte i l'adreça corresponents (recordem que poden trucar des de qualsevol lloc).

Donat que seran infermers/es o metges/ses qui alerti de BST i que quan truquin al 061 serà per una situació urgent i no resolta, caldrà codificar **"NO CONTESTA"**, independentment que es tracti d'un domicili o via pública per tal de generar un recurs avançat i una consulta a prioritat 0.

La trucada es traspasarà a prioritat 0 i s'annotarà al camp 'A' qualsevol informació transmesa per l'alertant tal i com es fa habitualment.

5.9.22 Centres de Reducció de Danys (CAS)

Els Centres de Reducció de Danys són instal·lacions del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, vinculats a la Subdirecció General de Drogodependències, que tenen com a objectiu la prevenció, assistència i tractament de les persones amb aquesta patologia, disposen de professionals sanitaris i de l'àmbit social.

La seva tasca es realitza in situ a les instal·lacions físiques d'aquests centres, de forma domiciliària i/o en unitats mòbils per part de professionals desplaçats per prestar aquest servei.

Davant d'una trucada professionals sanitaris de Centres de Reducció de Danys, caldrà codificar correctament l'alertant "(49) CRD", el telèfon de contacte i adreça corresponents.

El professional sanitari que realitza l'alerta, informarà de l'estat clínic de la persona usuària del centre i el gestor de demanda procedirà a classificar l'incident segons la informació facilitada.

Sempre es passarà a valorar a Consulta sanitària prioritat 0.

A aquest tipus de serveis sempre s'activarà una Unitat assistencial i suport policial de Mossos d'Esquadra o Policia Local.

5.9.23 Servei preventiu TEDAX

Els membres que integren l'Àrea del TEDAX-NRBQ dels Mossos d'Esquadra s'encarreguen d'analitzar i neutralitzar principalment dos tipus d'artefactes explosius: els d'ús militar que han estat fabricats industrialment; i, els artefactes improvisats que fabriquen i/o utilitzen els delinqüents habituals, els grups armats o els terroristes. A més, també assumeixen l'especialitat NRBQ que els permet analitzar i manipular artefactes que suposin un risc Nuclear, Radiològic, Químic o Biològic per a les persones o béns. Davant de l'alerta per part de Mossos d'Esquadra demanant un servei preventiu TEDAX haurem crear l'incident classificant a l'Omega Accident/Traumatisme:

- Tipus d'accident: Altres

- Localització: Zona de risc especial
- Causa: No clicar cap opció
- Afectats: Sense ferits

CONDICIONANTS	AFFECTATS	TIPUS D'ACCIDENT	LOCALITZACIÓ	CAUSA
☐ Dificil accés ☐ Embarassada ☐ Estondrament (edifici, paret) ☐ Ferit atrapat ☐ Foc / Fum ☐ Metro / Tren ☐ Nens / Nadons ☐ Sortida de via ☐ Túnel / Subsòl ☐ Via ràpida ☐ Altres condicionants	? 1 2 3 Lleus ☐ ☐ ☐ ☐ Greus ☐ ☐ ☐ ☐ ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Sense ferits ☐ Cadàvers ☐ Accident múltiples víctimes (>4 Afectats)	☐ Agressió ☐ Escolar ☐ Laboral ☐ Trànsit ☒ Altres	☐ Domicili ☐ Indústria ☐ Lloc Públic ☐ Mar obert ☐ Muntanya / Barranc ☐ Piscines ☐ Platja / Costa ☐ Port ☐ Pous ☐ Rius i embassaments ☐ Via interurbana ☐ Via urbana ☒ Zona de risc especial ☐ Zona esportiva ☐ Altres	☐ Atropellament ☐ Bolcat ☐ Caiguda < 2 mts ☐ Cremades ☐ Col·lisió ☐ Contusió ☐ Explosió ☐ Ferida Arma Blanca ☐ Ferida Arma de Foc ☐ Ferida incisa ☐ Incendi ☐ Intoxicació ☐ Maquinària ☐ Oregament ☐ Precipitació >= 2 mts

MÒBILS IMPLICATS

Múltiples vehicles

Sempre passarem la trucada a la UCO.

5.9.24 Centres de vacunació massiva

Davant una trucada en la qual l'alertant s'identifica com personal qualificat (professional mèdic i infermeria) d'un centre de vacunació massiva, seleccionarem el següent tipus d'alertant:

59 – Centre de Vacunació Massiva

Aquesta trucada s'haurà de traspasar a la posició de Infermeria de Cap de Torn i, en la seva absència, a Cap de Torn. En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

5.9.25 Prestació d'Ajudar a Morir (PRAM)

Operativització de la participació de SEM a la Prestació d'Ajuda a Morir (PRAM) en relació a la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia (Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia), en vigor des del 25 de juny del 2021. L'objecte de la llei és regular el dret que correspon a qualsevol persona que compleixi les condicions exigides a sol·licitar, rebre l'ajuda necessària per morir, el procediment que s'ha de seguir i les garanties que s'han de complir.

Així mateix, determina els deures del personal sanitari que atengui aquestes persones amb la definició del seu marc d'actuació i regula les obligacions de les administracions i les institucions concernides per assegurar l'exercici correcte del dret que reconeix aquesta Llei.

S'han identificat una sèrie de situacions que impliquen d'una forma transversal al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM):

- Canal d'accés als ciutadans a la informació administrativa sanitària.

- Complicacions sobrevingudes o no previstes que precisin de l'actuació dels recursos assistencials del SEM, ja sigui per l'abordatge in situ com un possible trasllat sanitari urgent o no urgent.

S'ha creat un nou tipus d'alertant per les demandes de l'equip PRAM. En cas de rebre una trucada provinent d'aquest equip, l'alertant a registrar serà EQUIP PRAM.

Alertant:

Si el que es demana és informació, s'ha d'utilitzar l'alertant corresponent:

- Pacient que sol·licita o es planteja PRAM i/o el seu entorn
- Personal de centre sociosanitari
- Personal de residència
- Personal de centres sanitaris hospitalaris

Si la demanda la fa un equip PRAM, s'ha d'utilitzar: Alertant Equip PRAM

Classificació:

Si l'alertant demana informació sobre aquesta llei, s'haurà de classificar com:

- **At. No Presencial No Urgent/Consulta administrativa PRAM** registrant les dades habituals de les consultes administratives i traspasar la trucada a través del botó "Consulta", com es fa habitualment, traspassant la trucada a Gestor de Consulta Administrativa.

Possibles consultes que s'han de derivar a Personal Sanitari

- Si la consulta està relacionada amb la pregunta: *Què entén la Llei per malaltia "greu i incurable"?* (punt 8 de Preguntes freqüents).
- Si la consulta està relacionada amb la pregunta: *Què entén la Llei per "patiment greu, crònic i impossibilitant"?* (punt 9 de Preguntes freqüents).
- Si la consulta està relacionada amb la medicació aplicable o els efectes de les mateixes del procés de l'eutanàsia.

En el cas que la consulta sigui similar a les consultes esmentades, a continuació, codificarem com:

- **At. No presencial No Urgent/ Consulta sanitària PRAM**, recollint totes les dades de localització i filiació com és habitual en les consultes sanitàries No Urgents. Es traspasarà la trucada a través del botó “Consulta”, com es fa habitualment, traspassant la trucada a Pr3.

En el cas que l'alertant sigui un Equip PRAM classifiquem com:

- **Malaltia Domicili/ Etiqueta PRAM** recollint totes les dades de localització i filiació com és habitual en les consultes de malaltia domicili. Es traspasarà la trucada a través del botó “Consulta”, com es fa habitualment, traspassant la trucada a la Taula de Fragilitat.

5.9.26 Teleassistència (TASS)

El Servei Local de TeleAssistència és un servei que ofereix acompanyament a usuaris majors de 75 anys i/o amb alguna discapacitat.

Davant d'emergències de caràcter sanitari, els gestors d'aquest servei truquen al 061, entrant la trucada a gestors de primer nivell. El guió a seguir és:

1. Confirmar telèfon de TASS.
2. Demanar Municipi i Adreça d'afectat.
3. Saber què ha passat abans de demanar DNI/CIP.
4. Demanar DNI/CIP si s'escau.

5. Classificar simptomatologia (Acceptant totes les 'Accions protocol·litzades' a excepció de 'Derivació a Centre d'Atenció Primària').
6. Demanar telèfons de contacte de veu i anotar-los al camp 'A'. De la mateixa manera, també, preguntarem si afectat es troba sol o acompanyat.
7. Indicar a TASS que ens posarem en contacte amb afectat.
8. Trucar a afectat, confirmar símptomes, adreça i seguir indicacions de Sitrem.

5.9.27 Guió alertant MMEE, PL, BB, GU, GUB:

- Confirmar telèfon i demanar extensió: *"El telèfon de contacte és És un telèfon directe o tenen una extensió?"*
- Hem d'afegir la pregunta obligatòria: *Estan de camí o van cap al lloc? I ho anotarem sempre al camp "A".*
- Si no estan al lloc: *Tenen un telèfon de contacte d'algú que estigui al lloc?*

5.9.26 Operativa de traspàs de trucades a segon nivell i consultoria

S'ha de seleccionar una opció d'aquesta pantalla i prémer acceptar. El programari indicarà el missatge a emetre i accions a realitzar:

5.9.26.1 Passar la trucada a consulta administrativa

A les sales del CECOS d'Hospitalet, Barcelona i Reus:

En tots els cassos s'ha de comunicar a l'usuari: **"Li passo amb l'operador que gestionarà la seva consulta"**. S'ha de transferir la trucada a través del botó CONSULTA i encuar. En cas que els gestors de demanda de segon nivell estiguin ocupats i després de 30 segons en cua, es reproduïx una locució que informa a l'alertant d'aquesta situació i l'indica que pot esperar a que hi hagin gestors lliures o penjar i se'l retrucarà (la locució es repeteix cada 30 segons).

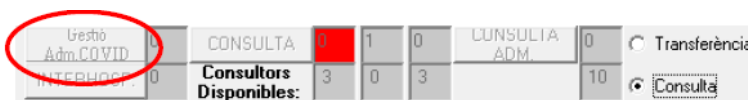


Si a Segon Nivell hi haguessin cues i sempre que l'equip d'estructura doni la instrucció, tancarem el traspàs de trucades de Primer Nivell a Segon Nivell (excepte el servei de traducció). En aquest cas, informem a l'usuari/a amb la següent frase:

"En aquests moments tots els nostres gestors estan ocupats. El trucarem el més aviat possible, des d'un número ocult, per resoldre la seva consulta. Moltes gràcies."

Al camp A haurem d'anotar **"Pendent de retrucar"**.

Per contactar amb els gestors/es de Consulta Administrativa que poden resoldre dubtes administratius associats al COVID s'ha de seleccionar el botó de 'Gestió Adm. COVID'.



Si no ens contesten, actuarem de la mateixa manera com si no hi haguessin gestors/es administratius disponibles i si així ens ho indica l'equip d'estructura.

Si l'usuari comenta que prefereix alguna hora de retrucada concreta, s'anota al camp 'A'. Això no es un suggeriment que li hem de fer a l'usuari, només ho hem d'anotar si ho indica.

5.9.26.1.1 Passar la trucada a Consultoria Sanitària

La barra de telefonia diferencia el número d'agents disponibles entre els metges, el personal d'infermeria i el pas de trucades a consultoria sanitària.

Visualment es presenten les cues de telefonia corresponents segons marquen els Diagrames 3 (Zona Franca) i 4 (Reus) amb el nombre d'usuaris disponibles per cadascuna d'elles dins dels requadres corresponents.

A la vegada es presenta el text "Consultors Disponibles:" davant de les noves caselles on s'informen les cues.



(Diagrama 3)



(Diagrama 4)

El botó CONSULTA dirigeix la consulta a la sala de l'àmbit geogràfic corresponent a l'adreça de l'incident.



A la sala de l'Hospitalet:

- Consulta sanitària pertanyent als motius de demanda de la pantalla Atenció No Urgent (excepte Consell Viatger):
 - El gestor de demanda de primer nivell ha de transferir la trucada a través del botó CONSULTA de la barra de telefonia i als 4 tons (10 seg.) deixar en cua.
- Consulta sanitària de la pantalla Atenció No Urgent motiu Consell Viatger:
 - El gestor de demanda de primer nivell ha d'indicar a l'alertant *"Pengi la trucada i en breu li trucaran per gestionar la seva consulta."*
- Quan una trucada de l'àmbit geogràfic de la sala de Reus es respon des de la sala d'Hospitalet, hem d'utilitzar el combo de la barra de telefonia "Consulta sanitària prioritat 3" per tal que la consulta es dirigeixi al personal sanitari d'Hospitalet que és qui l'ha de respondre.

A la sala de Reus:

- Consulta sanitària pertanyent als motius de demanda de la pantalla Atenció No Urgent (excepte Consell Viatger, Consell Medicaments i Consulta Sanitària):
 - S'ha de traspasar la trucada a través del combo a "Gran Via Consulta Sanitària Prioritat 3". S'ha d'informar de l'incident i s'ha de transferir la

trucada. Si després de quatre tons no contactem amb el personal de prioritat 3, es deixarà en cua.

- Consulta sanitària pertanyent als motius de demanda de la pantalla Atenció No Urgent Consell de Medicaments i Consulta Sanitària ho valora personal sanitari de la sala de Reus i sempre es deixarà pendent de retrucar com s'indica al punt 5.7.2 Trucada transferida a personal sanitari.
- Consulta sanitària de la pantalla Atenció No Urgent motiu Consell Viatger:
 - El gestor de demanda de primer nivell ha d'indicar a l'alertant ***“Pot penjar i el retrucarem en breu.”***

5.9.26.1.2 Trucades on es selecciona Traduccions

A les dues sales:

En el cas d'haver seleccionat l'etiqueta Traduccions, apareix una interrogació que s'ha de plantejar al personal sanitari que ens la demana aquesta traducció: ***“El pacient que s'ha de traduir està amb vostè?”***. Haurem de seleccionar del desplegable la resposta que ens indiqui el personal sanitari: ***‘Si, està amb el pacient.’*** o ***‘No, no es troba amb el pacient’***.

Si es troba amb el pacient ens permet continuar amb la gestió de l'incident.

Es traspassa la trucada a través del combo de la barra de telefonia a “Hospitalet Servei de Traducció”.

S'informa a l'usuari ***“Li passo amb l'operador que gestionarà la seva consulta”***; es transfereix la trucada i es penja.

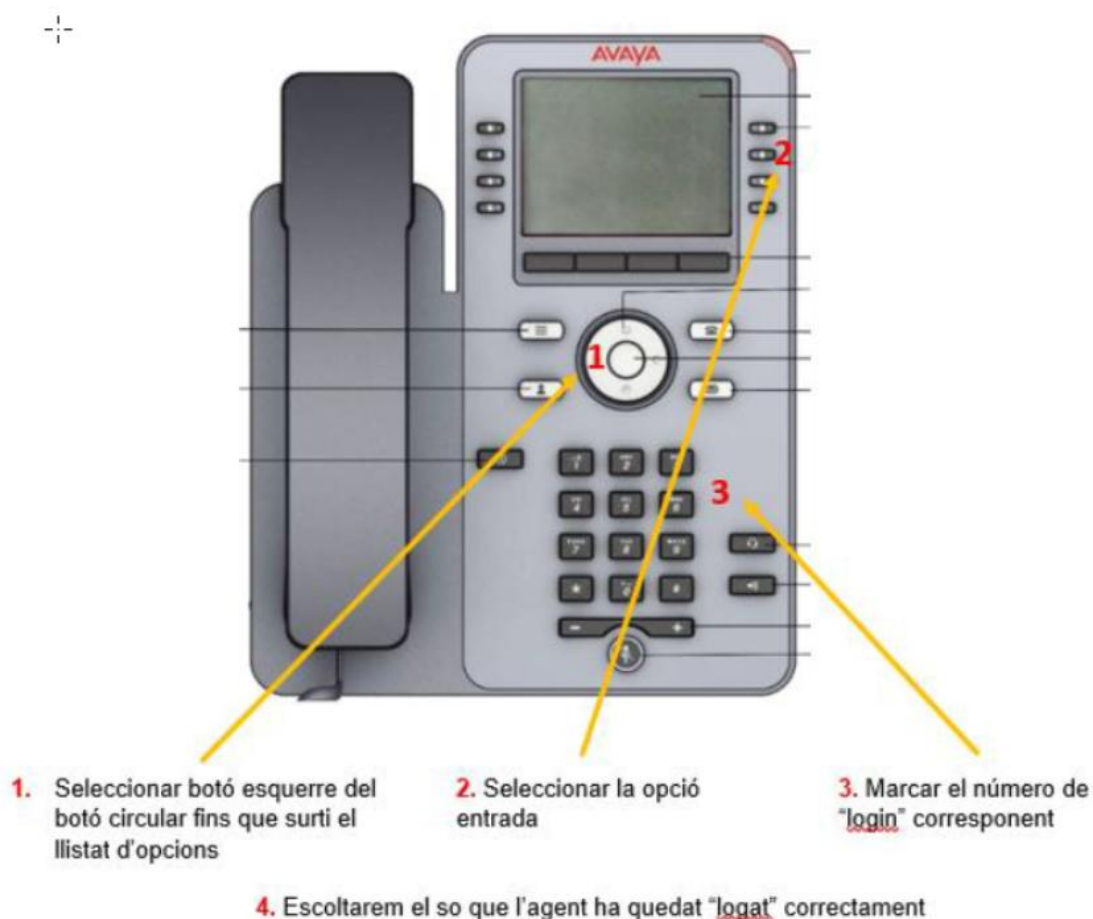
Si el personal sanitari i la persona a traduir no estan junts, SITREM ens indica que li demanem que han d'estar junts per iniciar la traducció ***“Torni a trucar quan estigui amb el pacient”***.

5.10 Sales en situació de caiguda de SITREM

5.10.1 Operativa Logat manual a la telefonia

Cada sala disposa de terminals telefònics específics als quals, en situació de caiguda de SITREM, cal logar-se manualment descriurem el procediment per part dels usuaris per accedir manualment en cas de talls del sistema informàtic SITREM i la seva integració amb la telefonia en els terminals AVAYA J169 i J179:

Logar-se:



1. Seleccionar botó esquerra del botó circular fins que surti el llistat d'opcions.
2. Seleccionar l'opció entrada.
3. Marcar el número de "login" corresponent.

Estat treball auxiliar

Si volem posar-nos en treball auxiliar (no rebre trucades):

1. Amb el mateix botó circular, anar a la llista d'opcions i seleccionar TrabAux.
2. Si volem tornar a rebre trucades hem de prémer el botó circular esquerre de nou i un cop a la llista d'opcions, seleccionar AutoInACD
3. Finalització del "login" manual:
4. Botó circular esquerre, anar a la llista d'opcions i seleccionar Salida..

5.10.2 Recollida de dades

- Utilitzar la aplicació Web de PAPIRUS o el full de treball de paper, en cas que el problema tècnic sigui per una connexió a internet, per tal de registrar les dades de l'incident.
- Omplir els camps de la planella / Aplicació Web que es troben dins del requadre de línia blava.
- Especificar l'hora d'entrada de la trucada. Utilitzar majúscules i lletra clara.

- En aquesta situació, totes les trucades es passaran a valorar per personal sanitari i es tancaran amb la indicació:

“Si us plau no pengi que parlarà amb personal sanitari.”

Un cop recollides les dades al full de paper, s'ha de facilitar al coordinador o a la persona designada per ell que lliuri el full personalment al metge consultor amb qui s'ha parlat per telèfon, per tal que pugui valorar l'incident.

- Recuperada la situació de treball amb SITREM s'ha de procedir a la introducció dels incidents al programa.

emergències mèdiques			
DATA:	HORA D'ALERTA:	Núm. INCIDENT:	
ALERTA:	TELÈFON:	RECLAMACIONS: 0	1 >/=2
MUNICIPI:	PROVINCIA: BCN GIRONA TARRAGONA LLEIDA		Núm:
ADREÇA:			
COMPLEMENT D'ADREÇA:			
NOM:	COGNOM:		
EDAT:	SEXE:	DOCUMENT (DNI, CIP):	
ACCIDENT:	MALALTIA LLOC PÚBLIC:	MALALTIA DOMICILI:	CONSULTA SANITÀRIA:
TRANSPORT URGENT:	TRANSPORT SANITARI:	TRANSPORT INTER HOSPITALARI NO CRÍTIC:	TRANSPORT ITH:
GESTOR DE DEMANDA:			CODI GESTOR DEMANDA:
CONSULTA:			CODI PERSONAL SANITARI:
T. DE REC: M I T V B CH L			
PRIORITAT: 0 1 2 3 4			
RECURS:			
Hora activació:			
Hora assistència:			
CENTRE SANITARI DESTI:			
H. Transport:			
H. Arribada Hospital:			
H. Transferència:			
Hora finalització:			
Tipus finalització:			
CODI GESTOR RECURSOS:			

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

5.10.3 Zones i Extensions diferents sales

SALA GRAN VIA

Cap de Torn	43502
Coordinador Tècnic Girona	43102
Coordinador Tècnic Metro Nord-Vallès Oriental	43112
Coordinador Tècnic Vallès Occidental	43122
Coordinador Tècnic L'Hospitalet- Baix Llobregat Interior	43132
Coordinador Tècnic Metro Sud- Baix Llobregat Litoral-Penedès Garraf	43142
Auxiliar Coordinació Girona	43101
Auxiliar Coordinació Metro Nord – Vallès Oriental	43111
Auxiliar Coordinació Vallès Occidental	43121
Auxiliar Coordinació L'Hospitalet- Baix Llobregat Interior	43131
Auxiliar Coordinació Metro Sud- Baix Llobregat Litoral-Penedès Garraf	43141
Gestora – Gestor Llenguatge de Signes	43235//43237

SALA BARCELONA

Cap de Torn	22790
Coordinador Tècnic	22781
Auxiliar de Coordinació	22787

SALA REUS

Cap de Torn	175015
Reus Consultoria	175001
Reus Consultoria	175002
Reus Consultoria	175004
Reus Metge DUI Consultor	175003
Auxiliar Coordinació Ponent Pirineu	175018
Coordinador Tècnic Ponent Pirineu	175022
Auxiliar Coordinació Centre	175016
Coordinador Tècnic Centre	175017
Auxiliar Coordinació Costa 30/31	175000
Coordinador Tècnic Costa	175005

****En horari 20h a 8h, se integra les posicions:**

Auxiliar Coordinació Costa 30/31	175000
Coordinador Tècnic Costa 30/31	175005
Auxiliar Coordinació Centre – Ponent-Pirineu	175016
Coordinador Tècnic Centre – Ponent-Pirineu	175017

TELEFONS INTERÈS

Nº Fax Ingress Involuntari	902.106.971
OCATT	93: 490.86.26/ 93: 339.83.03
Nº Fax Interhospitalaris	902.108.119 (Hospitalet) – 977 196 808 (Reus)

Degut a situacions extraordinàries a les diferents sales, poden haver canvis a la distribució de les posicions. Si es donés una caiguda de Sitrem, Supervisió i coordinació de demanda facilitarà als gestors el llistat actualitzat.

Zones:

Torn de dia de 8:00h a 20:00h:

SALA Gran Via AC1 / CT1

- Girona Interior i costa
- Vallès Oriental

SALA Gran Via AC2/CT2

- Hospitalet de Llobregat
- Baix Llobregat interior i litoral

SALA Gran Via AC2/CT4

- Garraf
- Alt Penedès

SALA Gran Via AC3/CT4

- Metro Nord
- Maresme

SALA Gran Via AC3/CT3

- Sabadell
- Terrassa

SALA Gran Via AC2/CT2

- Hospitalet de Llobregat
- Baix Llobregat interior i litoral
- Metro Nord
- Maresme
- Garraf
- Alt Penedès

Torn de nit de 20:00h a 8:00h:

SALA Gran Via AC1/CT1

- Girona interior i costa
- Vallès Oriental
- Sabadell i Terrassa

Torn continu 24h:

SALA HOSPITALET AC/CT UMA o AC1/CT1 **Serveis amb activació d'Helicòpter**

SALA REUS 08-20h

<u>NOM UCT</u>	<u>TERRITORI</u>
<u>UCT COSTA / COSTA 30</u>	<u>Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà</u>
<u>UCT COSTA / COSTA 31</u>	<u>Baix Camp, Priorat, Ribera d' Ebre, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta.</u>
<u>UCT CENTRE - UCT PONENT-PIRINEU</u>	<u>Bages, Berguedà, Solsonès, Osona, Moianès Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya Garrigues, Noguera, Pla Urgell, Segarra, Segrià, Urgell</u>

SALA REUS 20h – 08h

<u>NOM UCT</u>	<u>TERRITORI</u>
<u>UCT COSTA / COSTA 30</u>	<u>Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà</u>
<u>UCT COSTA / COSTA 31</u>	<u>Baix Camp, Priorat, Ribera d' Ebre, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta.</u>
<u>UCT CENTRE</u>	<u>Bages, Berguedà, Solsonès, Osona, Moianès</u>
<u>UCT PONENT-PIRINEU</u>	<u>Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya</u>
<u>UCT PONENT-PIRINEU</u>	<u>Garrigues, Noguera, Pla Urgell, Segarra, Segrià, Urgell</u>

5.11 Situació de caiguda barra de telefonia

Sitrem ens informa amb un avís (en vermell a sota de l'estat de l'agent) del mal funcionament de la barra de telefonia, tant per tasques de manteniment como possibles errors amb el servidor.

Si es deté el servei de telefonia com el servei de cues, apareixerà un missatge indicant-li a l'usuari de la situació actual i el propi procés realitzarà la reconexió cada X segons (també parametritzable) fins que el servei estigui funcionant.

La trucada no es perd i no es necessari logar-se manualment a telefonia.

L'avís quan les tasques son de manteniment es el següent:



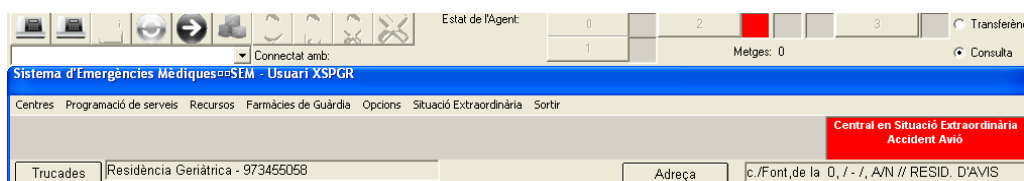
Avís si el servei ha caigut:



5.12 Situacions extraordinàries

Les situacions extraordinàries permeten cobrir esdeveniments o situacions amb incidents a diferents localitzacions, però que estan relacionats amb la situació extraordinària.

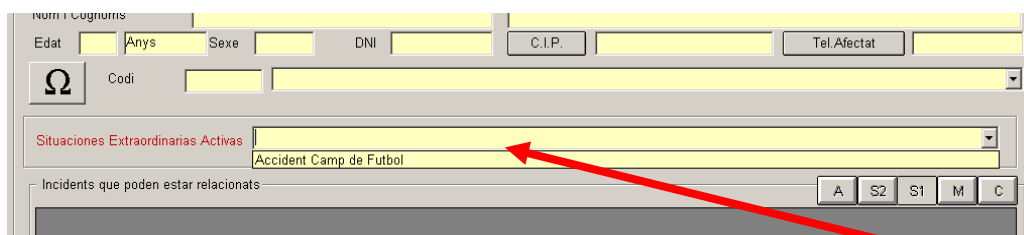
En el moment en el qual es crea una situació extraordinària, a tots els usuaris de SITREM els apareix un indicatiu al programa per tal què estiguin alerta en relació a aquesta nova situació.



Associar incidents a una situació extraordinària.

1. Des de la pantalla Nova trucada:

Es pot fer des de la pantalla de 'Nova Trucada' on es visualitzarà un desplegable amb totes les situacions extraordinàries obertes actualment.



Per agregar un incident nou a la situació extraordinària no fa falta fer-ho des del botó d'Associar incidents.

2. Després d'haver creat l'incident:

Fent doble clic al damunt del botó que informa sobre la Situació extraordinària s'accedeix a la pantalla que permet associar incidents a la mateixa.

Asciar	T.Demanda	Municipio	Dirección	T.Servicio	Id
	Emergència	Barcelona	c. Acer de l'1, Barcelona	SE	1000
	Tran. Sanitari	Girona	CR Camer X de Creu, Palau 1, Girona	ST	1004
	Emergència	Barcelona	c. Acer de l' (Atención número de calle no encontrado)	SE	1016
	Tran. Sanitari	Girona	CR Abeuradors 1, Girona	ST	1017
	Emergència	Sant Feliu de Llobregat	c. Baix Llobregat del 0, Sant Feliu de Llobregat	SE	1018
	Emergència	Sant Feliu de Llobregat	c. Agustí Domingo 0, Sant Feliu de Llobregat	SE	1019
	Emergència	Abdera	av. Energía de l'0, Abdera	SE	1020
	Emergència	Tarragona	Camí A de la Platja dels Cossis 0, Tarragona	SE	1021
	Emergència	Madremanya	c. Creu 0, Madremanya	SE	1022
	Tran. Secundari	Tarragona	Ca A Cossis 0, Tarragona	SS	1023
	Tran. Secundari	Tarragona	Ca A (Savinos) 12, Tarragona	SS	1024
	Emergència	Barcelona	c. Muntaner de 0, Barcelona	SE	1025
	Emergència	l'Hospitalet de Llobregat	c. Aigües del Llobregat de les 0, l'Hospitalet de Llobregat	SE	1026
	Consulta (Rebuig)	Madremanya	Cr Desconegut 0, Madremanya	SCR	1028

Botons

- Associar incidents: Mostra una llista dels incidents oberts actualment per associar-los a la situació extraordinària actual.



- : Recerca d'incidents associats.



- : Associa els incidents que s'hagin seleccionat.



- : Canvia la visualització d'aquesta pantalla.



- : Surt d'aquesta pantalla.

5.13 Procediments específics Sala Operativa Sanitària de Reus

5.13.1 Transferències específiques Sala Reus

Davant d'una emergència vital procedent de la Sala de Reus (Lleida província, Tarragona província, La Cerdanya i Catalunya Central) de tipologia **NO CONTESTA**, **NO RESPIRA**, procedirem de la següent manera:

- Botó 'CONSULTA' (esperar 4 tons).
- Trucar a Reus AC de la zona segons la seva extensió (esperar 4 tons):

VDN	NOM ACTUAL COMBO	NOM NOU COMBO	Extensió
177201	Reus AC 1	Reus AC COSTA 30 -31	175000
177205	Reus AC 4	Reus AC COSTA 31 estiu	175003

177208	Reus AC 2	Reus AC CENTRE	175016
177209	Reus AC 3	Reus AC PONENT-PIRINEU	175018

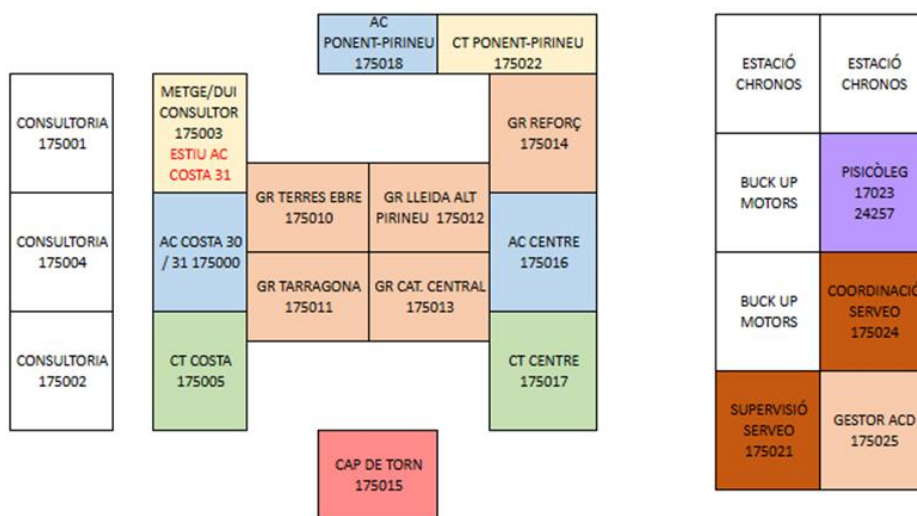
- S'ha de mantenir a el alertant en línia fins poder transferir.

Una emergència vital no pot deixar-se mai en cua, per tant, haurem d'esperar a que ens agafin la trucada. Si a la primera volta no ens l'agafen, tornarem a començar per botó 'CONSULTA'.

Tots els incidents que **mobilitzen recurs** es queden a la sala Reus, està creat amb un vector i VDN 177200 que ja fa el traspàs a metge consultor, infermer consultor i coordinador tècnic, automàticament, només **pitjant CONSULTA**.

Els incidents que no mouen recurs passen a Gran Via, també, pitjant CONSULTA. Depèn de la prioritat ja passen automàticament al consultor de la prioritat que sigui, seguim treballant sempre amb consulta, si al traspassar a les altres sales no ens agafen llavors si transferim.

Les reclamacions que Si han empitjorat i encara no surt el recurs, també, es queden a sala Reus.



consultoria no sempre operativa

5.13.2 Reclamacions

- Les reclamacions seguiran el circuit habitual de traspàs de trucades mitjançant el Botó CONSULTA.
- Les reclamacions que encara que hagin empitjorat, però no han generat recurs, excepte el Dolor Toràctic o la Dispnea es traspassarà mitjançant el botó CONSULTA.
- P3/P1 no ha empitjorat - passem a P3/P1 per botó CONSULTA.
- P3/P1 SI ha empitjorat:
 - Si ha empitjorat, però continua igual es traspassa per P3/P1.

Per exemple: L'afectat en la primera trucada indica que té mareig, però ara té també vòmits - passem a P3/P1- botó CONSULTA.

- Si ha empitjorat:

Per exemple: L'afectat en la primera trucada indica que té mareig, però ara té també dispnea, dolor toràcic i/o es troba en NO CONTESTA / NO RESPIRA - passem la trucada a la sala Reus per a la creació de recurs - mitjançant el combo (a tota la taula) i MAI consulta per botonera.

5.13.3 Transports sanitaris

5.13.3.1 Transports sanitaris a Via Pública

Us recordem que quan un metge sol·liciti una ambulància per un pacient que es troba a la via pública, generarem pantalla d'accident/traumatisme o de malaltia a lloc públic, segons s'escaigui, independentment de si el metge està de guàrdia o no.

No es generarà un transport sanitari, ja que afecta a la prioritat del recurs que s'assigna. D'aquesta manera, prioritzarà la situació d'emergència a la via pública (que sempre s'assigna amb una prioritat 0) a la petició d'ambulància efectuada per personal sanitari, ja que si sol·licita una convencional, al ser un transport, i s'assignarà una ambulància amb una prioritat 1.

5.13.3.2 Transport sanitari de Residència Santa Tecla Ponent a Centre Sociosanitari Llevant

Si truquen de la Residència Santa Tecla Ponent (SOSA) sol·licitant un trasllat al Centre Sociosanitari Llevant es realitzarà com un transport primari seguint el procediment habitual (no caldrà passar-ho a valorar).

Us informem que els dos centres els trobareu codificats a SITREM al botó "H".

5.13.3.3 Transports psiquiàtrics

Els transports sanitaris des d'un CSM a un centre psiquiàtric de referència (habitualment, A l'IPM de Reus) no s'han de passar a valorar.

Només es passaran a valorar els transports psiquiàtrics sol·licitats per un centre o personal sanitari no especialitzat en salut mental.

5.13.3.4 Trasllats judicials

Davant de demandes de trasllats judicials o d'ingressos involuntaris realitzades des de jutjats, l'operativa serà la següent:

- Crear transport sanitari amb les dades que ens facilitin (assignar SVB).
- Demanar a l'alertant que faci arribar l'ordre judicial a través del número de fax: 977196808.
- Traspasar la trucada, específicament, al Cap de Torn segons la zona.

5.13.3.5 Traslats IH - Codi IAM

Els gestors de demanda de la sala de Reus crearan incidents de transport secundari davant d'**alertes d'activació de Codis IAM demanats des d'un hospital** (CODIS IAM INTERHOSPITALARIS) que puguin entrar a la sala de Reus.

1. Per tal de discriminar si es tracta d'una CODI IAM o no, el gestor de demanda ha de realitzar:

- Personal Hospital informa motiu trasllat CODI IAM: accions descrites al punt 2.
- Personal Hospital informa motiu trasllat diferent a CODI IAM: tractament habitual de demanda d'interhospitalari.
- Personal Hospital no informa motiu trasllat: el gestor ha de preguntar: *'Es tracta d'un CODI IAM?'*:
 - Personal sanitari **confirma** CODI IAM: accions descrites al punt 2.
 - Personal sanitari **no confirma** CODI IAM: tractament habitual de demanda d'interhospitalari.

2. El gestor de demanda realitzarà les accions següents:

- El gestor no informará del telèfon de Interhospitalaris si no que gestionarà la pantalla de transport.
- Es recolliran les dades habituals d'un trasllat, demanant un **telèfon directe del contacte** i la **ubicació del pacient** dins de l'hospital.
- Crearà un **transport secundari** (clicant T. Secundari).
- Assignarà recurs **SVA prioritat 0**.
- Clicarà **Crear intervenció** i traspasarà la trucada pel combo a Hospitalet Interhospitalari.
- Si després de 8 tons no s'ha pogut contactar, es traspasarà la trucada Infermera de Taula de Cap de Torn i si no ens pot atendre passarem la trucada al Cap de Torn de la sala d'Hospitalet (també pel combo).

La resta d>alertes demanant activació de recurs per trasllats entre hospitals, que **no** siguin activació Codi IAM, es gestionaran de la manera habitual (Es facilitarà telèfon d'Interhospitalari i es traspasarà la trucada marcant el telèfon 902335033).

5.13.4 Modificació d'adreça per veu: adreça validada per 112

Quan entri trucada a través de 112 amb adreça validada, però el gestor de 112 ens indiqui per **veu** un altre municipi o submunicipi; modificarem l'adreça amb les dades que ens facilita.

Exemple: Incident codificat per 112 amb municipi a Tarragona, submunicipi Tarragona: el gestor de 112 indica per **veu** que és a Torreforta.

El gestor de demanda haurà de modificar l'adreça amb les dades facilitades pel gestor de 112.

5.13.5 Obertura de porta

En aquells incidents en els que s'ens comuniquin que hi ha una persona dintre de casa que no agafa el telèfon i no obre la porta i creuen que li ha pogut passar alguna cosa, la classificació correcta serà "Mal definits/altres", ja que realment no se sap què està passant. Seguidament, es transferirà la trucada a personal sanitari i si no és possible, s'informarà al coordinador de sala per a que informi a la taula de comandament.

Això mateix s'aplicarà a tots aquells incidents en què no se sàpiga què li passa a la persona. Per exemple, un alertant que indiqui que hi ha una persona a terra. No s'hi ha volgut acostar i no sap què li passa.

5.14 ACD (Atenció Continuada Domiciliària) i GCS (Guia de Centres Sanitaris)

5.14.1.1 Cornudella de Montsant

Dissabtes, diumenges i festius fins a les 21 hores han de trucar al telèfon 977312312 (CAP Sant Pere de REUS).

5.14.1.2 Gestió CAP's de Lleida i Província

A la província de Lleida, fora de l'horari de bastants CAP's, per a cada zona disposen d'un metge d'atenció continuada que es dedica a fer la visita del pacient.

Si el pacient està a la porta del CAP o de camí al mateix i aquest està tancat, el metge s'ha adreçar al centre d'atenció primària per obrir el CAP i, així, fer la visita del pacient.

Si el pacient es trobés al seu domicili, el metge aniria al domicili per fer la visita.

L'operativa variarà en funció d'on es trobi l'afectat:

Pacient a la porta del CAP o es dirigeix al mateix i vol que li obrin la porta:

- Codifiquem el municipi i l'adreça del CAP (Carrer i número. Al complement, escrivim DAVANT DEL CAP).
- Prenem nota del nom, cognoms i CIP/DNI del pacient.
- Tipifiquem la trucada com "Malaltia a Lloc Públic" o "Accident/Traumatisme", segons s'escaigui. Classifiquem què li passa i li indiquem a l'alertant: "Avisem al metge de la zona i aquest es posarà en contacte amb vostè."
- Al camp 'A' escrivim: "NO volen AA, volen que els hi obrin la porta del CAP".
- Passem la trucada al AC de sala Reus per tal que anul·lin l'ambulància i assignin un recurs "Derivació metge continuada" o les accions que calguin.

* El recurs "Derivació metge continuada" és el metge de la zona que es desplaçarà a fer la visita (Aquesta operativa és molt habitual en la zona de la Plana de Lleida -Noguera, Segrià-).

Pacient al domicili que vol ser visitat al domicili:

- Codifiquem l'adreça del domicili i demanem dades de filiació (CIP/DNI).

- Classifiquem la trucada de la manera habitual.
- Escrivim al camp 'A' el motiu de la trucada i l'estat del pacient, com fem habitualment.
- Missatge de SITREM:
 - *No pengi que parlarà amb personal sanitari* → Transferir trucada.
 - *El metge d'atenció continuada li trucarà* – El programa assigna un recurs "Derivació metge continuada" automàticament.

¡IMPORTANT!

A la província de Lleida, encara que a la GCS surti el CAP en vermell i el següent en verd, no vol dir que s'hagi de derivar al pacient al què està en verd, segurament estaran lluny l'un de l'altre.

Si el CAP està tancat, sempre hi haurà un metge de la zona que o anirà a obrir-lo per a assistir al pacient o bé l'anirà a visitar al domicili.

No ens hem de fixar en els colors en què figuren els CAPS a la GCS i hem de llegir tot el que estigui a "observacions".

Els colors de les boles dels registres de la Guia de Centres Sanitaris indiquen l'estat del centre:

Vermell: TANCAT

Verd: OBERT

Groc: CONSULTAR SEMPRE EL CAMP COMENTARIS (EL TEXT DELS COMENTARIS ESTÀ MARCAT EN GROC). Fent-hi doble clic, se'ns obrirà la informació en una nova finestra a la pantalla dreta.

Blau: RELACIONAT AMB UN RECURS

5.14.1.3 ACD Alt Pirineu

A la zona del Pirineu (municipis del ABS Pallars Sobirà, La Seu d'Urgell i Alt Urgell) hi ha metge localitzable tal com s'indica en la informació de la Guia de Centres Sanitaris:

Per llegir correctament el missatge dins de comentaris s'ha de fer doble clic dins de la casella per obrir la pantalla sencera i llegir la informació de dins; com exemple de la imatge anterior, el missatge que surt es el següent:

*“De 21.00h a 8.00h de dilluns a divendres i dissabtes, diumenges i festius 24 h. Tot i que el consultori esta tancat hi ha un **METGE LOCALITZABLE** que pot obrir-lo i realitzar la visita al consultori. **GENERAR a SITREM: INTERVENCIÓ "DERIVACIÓ METGE CONTINUADA"**”.*

Cal informar a l'alertant : QUE EL METGE ES POSARÀ EN CONTACTE AMB ELL.

Al obrir la pestanya del costat superior **dret A.D**, ens donarà la informació del horari d'inici de l'ACD.

No s'indicarà a l'alertant el CAP de Sort com a centre obert on poden atendre'l . Si tens dubtes pregunta a Cap de Torn”.

En el cas de la **Sala Motors**, la transferència es continuarà fent a la **Infermeria de la Taula de Cap de Torn**, tal com s'ha fet fins ara (Hosp. Coordinadora de Torn) en horari diürn (08h a 20h). De 20h a 8h la transferència de trucades es continuarà realitzant segons el procediment actual, en el cas que Cap de Torn no estigui disponible avisar a Coordinació.

5.14.1.4 Derivacions al Cap Segur de Calafell

Tots els pacients que hagin de ser derivats al CAP de Segur de Calafell per indicació de SITREM i de la GCS, es derivaran al CAP de Calafell.

D'aquesta manera, quan SITREM indiqui: *“Hauria de trucar al seu centre d'atenció primària.”* o *“Hauria d'anar al seu centre d'atenció primària.”* i el CAP obert més proper sigui el de Segur de Calafell, es facilitarà el telèfon del CAP de Calafell o bé es facilitarà a l'alertant l'adreça del mateix.

- El CAP de Segur de Calafell només atendrà les visites amb cita prèvia.

5.14.1.5 CAP i PAC Alcanar i ACD Falset

A arrel d'incidències detectades amb el CAP i el PAC d'Alcanar, us recordem que el CAP està obert fins les 21:00h i, tal com indica la GCS, a partir d'aquell moment funciona el PAC d'Alcanar (Punt d'Atenció Continuada) i així successivament.

Com podreu observar, a la GCS consta el CAP i el PAC son al mateix edifici. Així doncs, està **obert 24 hores**: fins les 21:00h com a CAP i a partir de les 21h fins al matí com a PAC. En un horari trobarem al metge d'atenció primària i, en l'altre, al metge de guàrdia d'atenció continuada; però el centre **està sempre obert**. Els caps de setmana el CAP està tancat, però el PAC està obert. **Per tant, aquest centre obre les 24 hores i els 7 dies de la setmana.**

Això mateix passa a altres municipis, com per exemple: **Sant Carles de la Ràpita, Gandesa, Deltebre, Flix, l'Ametlla de Mar**, etc.

Per altra banda, reiterar que la GCS **s'ha de llegir abans de donar una informació** (no fiar-se dels colors, llegir les observacions) i, en cas de qualsevol dubte, preguntar a coordinació.

ACLARIMENT:

CAP FALSET: Apareix CAP obert, però a partir de les 21h i fins les 8h, les trucades són derivades al 061.

A Falset, portem l'atenció continuada per remot. És a dir, que des del 061 Salut Respon es gestiona la demanda ACD des de les 21h a les 8h, en aquesta zona. Per tant, aquest centre té derivat el seu telèfon d'accés per ciutadans al 061.

No obstant això, recordar que el centre està obert. Si algú, per exemple, va al CAP l'atendran; però si truquen, aquesta trucada serà derivada al 061 perquè som nosaltres qui gestionem l'atenció continuada i, per tant, haurem de generar pantalla i no els hi haurem de facilitar el telèfon del CAP encara que aquest ens figuri com obert.

5.14.1.6 Municipi Major Vilanova de l'Aguda

Us informem de la següent situació mentre es pugui tenir una solució tecnològica.

Al municipi Vilanova de l'Aguda, el Carrer Germà Joaquim Donato ha canviat de nom per C/ Major.

- * Al carrer de SITREM continua sortint el nom vell.

Al municipi Vilanova de l'Aguda i, específicament, al submunicipi **Vilalta**, existeix un **C/ Major** que es carrega per defecte quan només es busca l'adreça pel nom del municipi (Vilanova de l'Aguda).

Tot i que les adreces del 112 vinguin codificades com C/ Major del Municipi de Vilanova de l'Aguda i submunicipi de Vilanova de l'Aguda, la GEO posició del mateix correspon al C/Major de Vilalta, submunicipi de Vilanova de l'Aguda.

Per tant:

- En demandes realitzades des del C/ Major del Municipi de Vilanova de l'Aguda s'haurà de confirmar si corresponen al submunicipi de Vilanova de l'Aguda o al submunicipi de Vilalta.
- Les demandes del carrer Germà Joaquim Donato del Municipi i del submunicipi de Vilanova de l'Aguda corresponen a l'actual C/ Major d'aquest lloc.

US DEMANEM ESPECIAL ATENCIÓ EN LA INFORMACIÓ QUE ES FACILITA AL USUARIS. HA DE SER SEMPRE CORRECTA. DAVANT DE QUALESVOL DUBTE PREGUNTEU AL VOSTRE COORDINADOR.

5.14.1.7 Cadaqués

- Horari d'atenció dilluns a diumenge de 8h a 20h.
- Fora d'horari no obriran la porta del CAP (20-08H).
- Quan SITREM surt derivació al CAP: Informarem a l'alertant que el metge es posarà amb contacte amb ell (Avisem a gestió ACD que trucarà a 638686243).
- Si està a la porta del CAP, descartada l'emergència, informem que vagi al seu domicili que avisarem al metge que es posarà en contacte amb l'afectat.
- Farem una pantalla d'Informativa Breu i avisarem al gestor ACD que trucarà al mateix telèfon.

5.14.2 Operativa Franja d'Aragó

Us recordem que, si entra una trucada d'un municipi de la **franja d'Aragó**, s'han de recollir totes les dades de localització i d'afectat i procedir a la classificació de la demanda de la manera habitual.

El municipis de la franja d'Aragó que gestiona el 061 de Catalunya són els següents:

Albelda	Camporrels	Laspaules	Sopeira
Alcampell	Castigaleu	Lledó	Tamarite de Litera
Altorricon	Catillonroy	Maella	Tolva
Arén	Cretas	Mazaleón	Torre del Comte
Arens de Lledó	Estopiñán del Castillo	Mequinenza	Torrente de la Cinca
Baells	Farbara	Monesma y Cajigar	Valderrobles
Baldellou	Fayón	Montanuy	Valdetormo
Beceite	Fornoles	Nonaspe	Velilla de la Cinca
Belver de Cinca	Fraga	Osso de la Cinca	Vencillón
Benabarre	La Fresneda	Peñarroya de Tastavins	Viacamp y Litera
Binéfar	Fuentespalda	Puente de Montañana	Zaidín
Bonansa			

Aquests municipis pertanyen a les comarques codificades al Sitrem com **"BAIX_CINCA_1"** (Huesca), **BAIX_CINCA_2** (Zaragoza), **"LITERA"** (Huesca), **MATARRANYA_1** (Teruel) o **"MATARRANYA_2"** (Huesca).

No es carregarà el carrer, però sí el municipi, la comarca i la província. Al prémer el botó “A” es carregarà automàticament “Desconegut”. Les dades relatives a l’adreça s’hauran d’anotar al “complement”.

Tots aquells municipis que codifiquin correctament al SITREM (municipi, comarca i província) hauran de ser gestionats pel 061 de Catalunya.

Amb tots aquells municipis que no codifiquin a SITREM es farà una Informativa Breu i s’indicarà a l’usuari que truqui a 112 per tal que els derivi a 061 d’Aragó.

5.14.3 112: Modificació Adreça per veu

Quan entri trucada **a través de 112 amb adreça validada**, però el gestor de 112 ens indiqui per **veu** un altre municipi o submunicipi, modificarem l’adreça amb les dades que ens facilita.

Exemple: Incident codificat per 112 amb municipi a Tarragona, submunicipi Tarragona, el gestor de 112 indica per **veu** que és a Torreforta.

El gestor de demanda haurà de modificar l’adreça amb les dades facilitades pel gestor de 112.

5.14.4 Traduccions

Davant una trucada d’anglès o francès s’ha de trucar a través del combo als operadors d’idiomes de la sala de l’Hospitalet del Llobregat. Les traduccions dels operadors de SERVEO d’anglès i francès serà per trucada directa.

Altres tipologies de trucades que no siguin d’entrada directa al 061 es farà per trucada al servei traduccions demanen l’idioma necessari.

En cas d’altre idioma diferent o si els operadors d’anglès o francès estan ocupats, trucarem a través del combo a “Hospitalet Servei de Traducció”.

6 Glossari

Arrítmia cardíaca per fibril·lació auricular (AC x FA): és un trastorn del ritme cardíac.

Aturada Càrdio-respiratòria (ACR): és l’absència de pols i de respiració. És la situació MÉS CRÍTICA.

Àngor: també conegut com angina de pit. És una malaltia cardíaca i pot ésser GREU.

Artràlgia: dolor a les articulacions.

Accident vasculocerebral (AVC): també pot denominar-se com: Ictus, Embòlia cerebral, Infart cerebral, Hemorràgia cerebral o Atac de feridura. Es tracta d’una malaltia GREU.

Cefalea: mal de cap.

Cervicàlgia: dolor a la regió cervical.

Cistitis no complicades: es defineixen com una infecció bacteriana aguda aïllada o recurrent que es produeix en el tracte urinari inferior no associada a anomalies del tracte urinari ni a altres malalties cròniques associades.

Contusió: traumatisme (cop) a una zona del cos.

Convulsions: es tracta d'una situació de contraccions musculars generalitzades, que acostuma a provocar una pèrdua de consciència. Pot ser degut a epilèpsia, atac epilèptic, convulsió febril. Pot ésser una situació GREU.

Cribratge: programa de detecció precoç dels càncers de mama i colon-recte.

Diarrea: alteració de les femtes, normalment, amb un augment del número de deposicions, amb femta tova i líquida. Pot anar acompanyada de febre, dolor i vòmits.

Dispnea: dificultat respiratòria. Pot arribar a ésser una situació MOLT GREU.

Diabetis (DM): diabetis Mellitus. Es tracta d'un augment del nivell de glucosa a la sang. Pot tractar-se amb insulina o amb fàrmacs per via oral. Ens podem trobar amb dos tipus: DMID (Diabetis Mellitus insulino dependent) o DMNID (Diabetis Mellitus No insulino dependent).

Dorsàlgia: dolor a la regió dorsal.

Ferida: lesió amb pèrdua de la integritat de la pell.

Gastroenteritis aguda (GEA): es tracta d'un trastorn gastrointestinal que cursa amb diarrees i/o vòmits. Acostuma a ésser una malaltia LLEU.

Hemorràgies: pèrdua de sang. Segons la localització d'aquesta pèrdua, es denominen:

- **Hematèmesi:** sortida de sang per la boca; procedent de l'aparell digestiu. Pot ésser sang de color vermell (fresca) o negra (pòsits de cafè).
- **Hemoptisi:** sortida de sang per la boca; procedent de l'aparell respiratori.
- **Otorràgia:** sortida de sang per l'orella.
- **Epistaxi:** sortida de sang pel nas.
- **Hematúria:** sortida de sang procedent de les vies urinàries.
- **Rectorràgia:** sortida de sang vermella (fresca) per l'anús.
- **Melenes:** sortida de sang digerida (negra) per l'anús.

Infart agut de miocardi (IAM): també es pot denominar com atac de cor. Es tracta d'una malaltia MOLT GREU.

Infeccions de transmissió sexual (ITS): infeccions o malalties que es poden transmetre d'una persona a un altre per contacte físic durant les relacions sexuals.

Intoxicació: alteració de l'estat de salut a causa de l'acció d'un producte tòxic. Pot ésser voluntari o involuntari.

Línia Verda: línia d'atenció telefònica a les drogoaddiccions i al consum d'alcohol.

Llevadora: és una especialitat d'infermeria dedicada a la cura de la dona des del punt de vista reproductiu, especialment durant l'embaràs, el part i el puerperi. Encara que, també, comprèn altres aspectes diversos: sexualitat, anticoncepció, menopausa...

Lumbàlgia: dolor a la regió lumbar.

Lumbàlgia aguda: es defineix com la sensació de dolor o molèstia localitzada entre el límit inferior de les costelles i el límit inferior dels glutis de menys de 6 setmanes de durada. El dolor a la zona lumbar pot variar en intensitat en funció de la postura.

Mareig: és una sensació molt inespecífica, sensació d'esvaïment, incapacitat d'estar dret.

Miàlgia: dolor muscular.

Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC): dificultat respiratòria crònica aguditzada. Sensació d'ofec. També denominada bronquitis crònica.

Nàusees: desig imminent de vomitar, encara que no sempre vagi seguit d'aquest. És una situació LLEU.

Neuràlgia: dolor que segueix el recorregut d'un nervi.

Otàlgia: dolor a l'oïda.

Pastilla o comprimit post coital: medicació anticonceptiva d'emergència. També coneguda com la pastilla del dia després.

Politraumatisme: múltiples traumes a diverses zones del cos.

Quimioprofilaxis: és el tractament que es fa per evitar agafar una malaltia (per exemple la quimioprofilaxis de la malària, del Sida...).

Quit line del 061 CatSalut Respon: línia d'atenció telefònica d'ajuda per deixar de fumar, atesa per infermeria de la sala Hospitalet.

Restrenyiment: disminució del número de deposicions.

Síncope (PTC): pèrdua sobtada i transitòria de la consciència amb recuperació espontània sense tractament.

Trombosi: obstrucció d'una arteria o d'una vena a causa d'un coàgul de sang.

Úlcera: és la necrosi (mort cel·lular) d'una zona de la pell. Habitualment es localitza en zones de pressió en persones amb mobilitat molt limitada i/o enllitats (regió sacra, turmell, natges...). Són zones que estan en contacte directe amb la cadira, el llit, etc. I que suporten el pes del pacient.

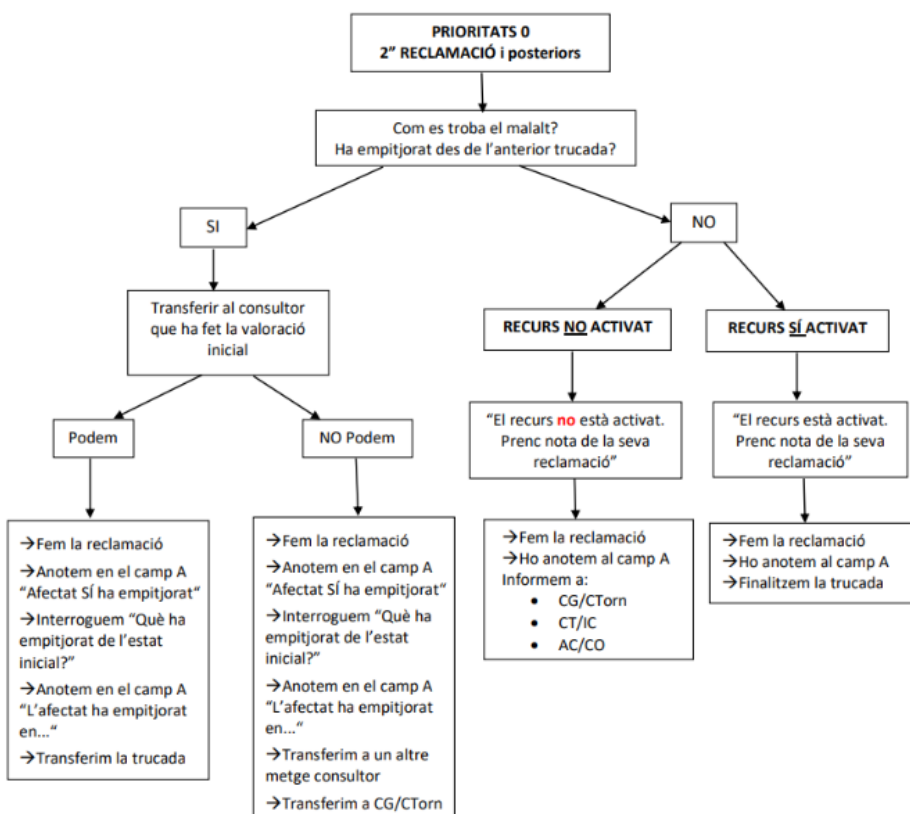
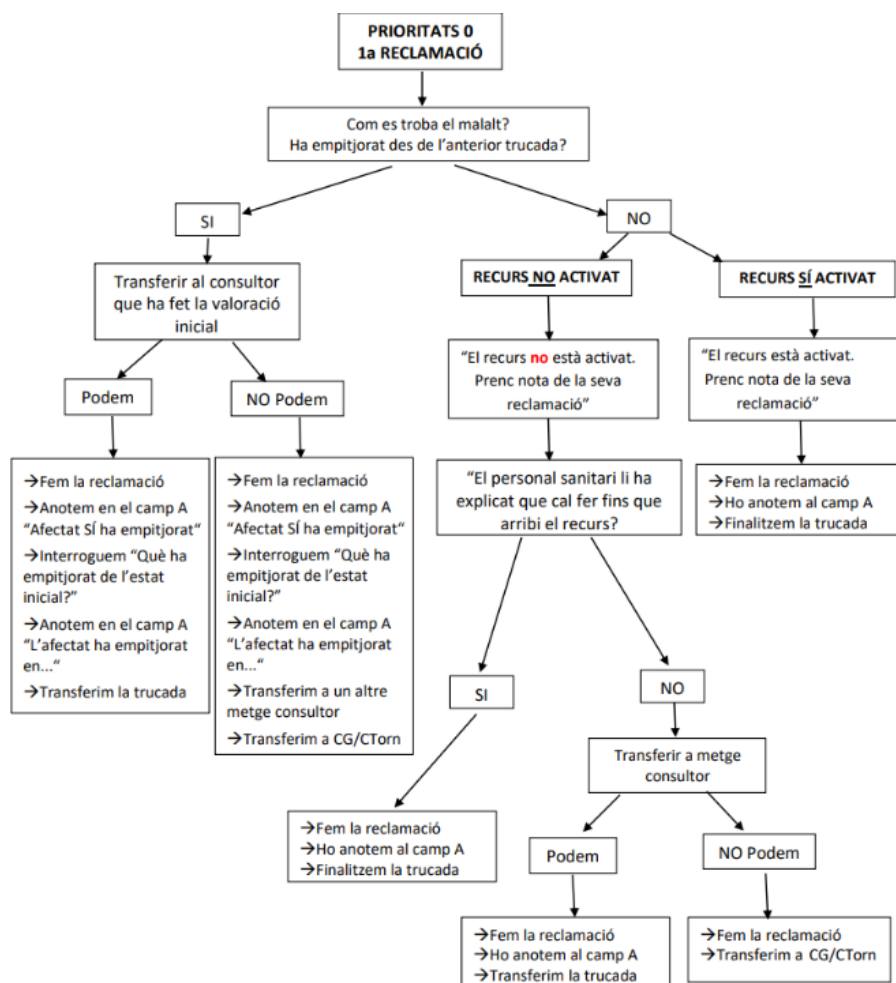
Vertigen: sensació subjectiva que els objectes que envolten a l'afectat giren al seu voltant. També pot definir-se com sensació d'inestabilitat, anar "en vaixell".

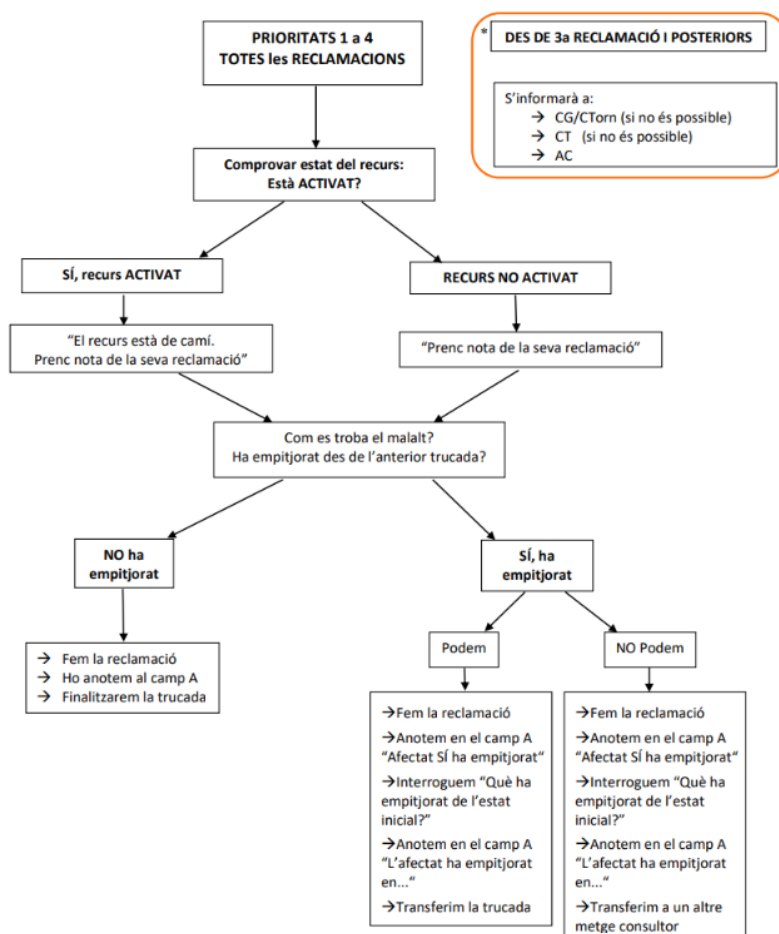
Vòmits: expulsió sobtada del contingut de l'estomac o de l'intestí a través de la boca.

Vulvovaginitis candida: inflamació de la mucosa vaginal i de la pell vulvar produïda per diferents espècies de fongs del gènere Candida.

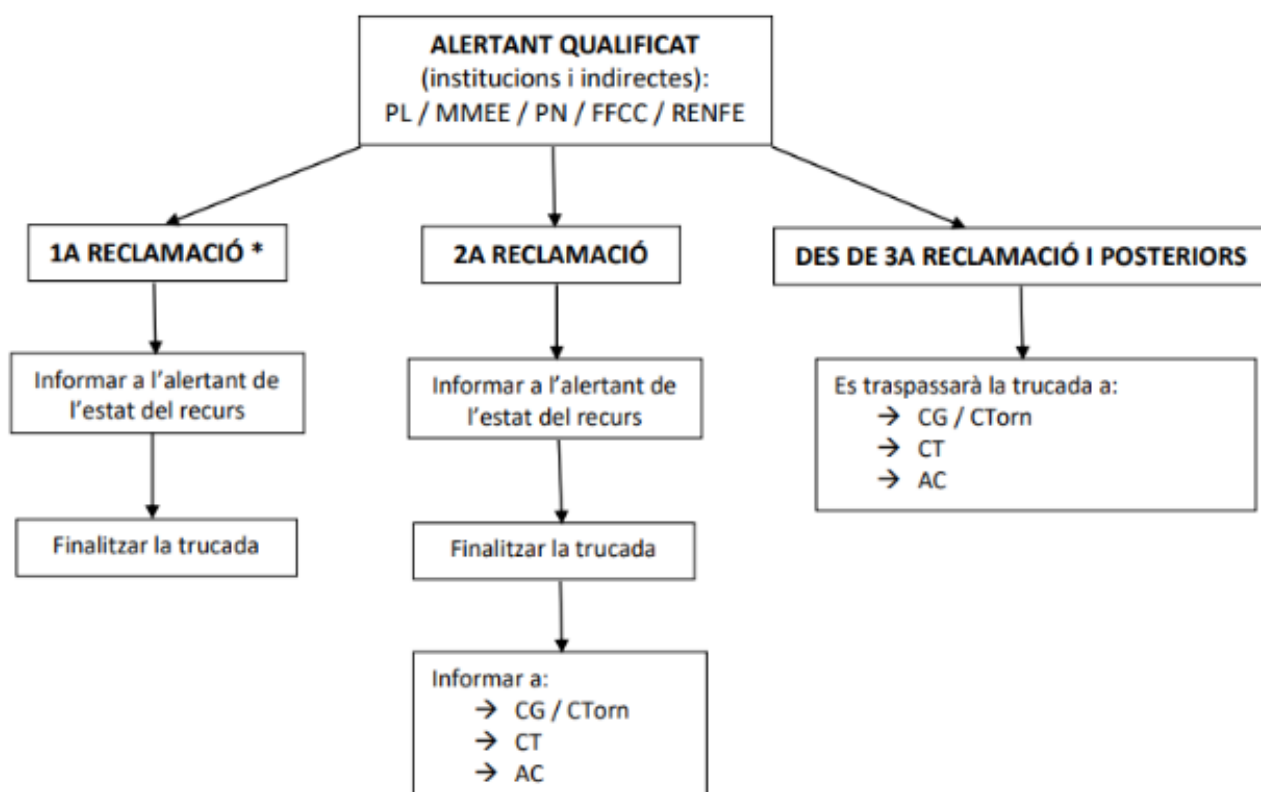
7 Esquema Reclamacions Incidents:

Esquema Reclamació Prioritat 0:



Esquema Prioritats 1 a 4:**Esquema Reclamació Alertant Qualificat:**

* Davant qualsevol reclamació per alertant qualificat si hi ha canvis en l'estat del pacient amb patologia d'emergència en 1ª Reclamació s'intentarà transferir trucada i/o informar.



**

En els incidents que intervingui una unitat aèria hem d'informar o traspasar la trucada a Auxiliar UMA o CT UMA.

8 Abreviatures més freqüents

AA:	Ambulància
ABS:	Àrea Bàsica de Salut
AC:	Auxiliar de Coordinació
ACxFA:	Arrítmia Completa per Fibril·lació Auricular
ACD:	Atenció Continuada Domiciliaria
ACR:	Aturada Cardiorespiratòria
AP:	Antecedents Personals
ASSIR:	Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
AVC:	Accident Vascular Cerebral
BB:	Bombers

CAC:	Centre d'Atenció Continuada
CAP:	Centre d'Atenció Primària
CAS:	Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències.
CG:	Cap de Guàrdia
CO:	Coordinador Operatiu
CT:	Coordinador Tècnic
CTO:	Cap de Torn
CUAP:	Centre d'Urgències d'Atenció Primària
DEA:	Desfibril·lador Extern Automàtic
DM:	Diabetis Mellitus
DMID:	Diabetis Mellitus Insulino Depenent
DMNID:	Diabetis Mellitus NO Insulino Depenent
DUI:	Infermer-a
DVA:	Document de Voluntats Anticipades
ECG:	Electrocardiograma
EEG:	Electroencefalograma
ELA:	Esclerosi Lateral Amiotròfica
EXT:	Extensió
FX:	Fractura
GEA:	Gastroenteritis Aguda
GLI:	Glicèmia
GW:	Escala Coma de Glasgow
HAB:	Habitació
HOSP:	Hospital
HTA:	Hipertensió Arterial
IAM:	Infart Agut de Miocardi
IC:	Infermer-a Consultor-a
IH:	Interhospitalari
INFO:	Informa
IQ:	Intervenció Quirúrgica
ITS:	Infecció de Transmissió Sexual
ITU:	Infecció Tracte Urinari
IVE:	Interrupció Voluntària de l'Embaràs
LMS:	La Meva Salut (Abans Carpeta Personal de Salut CPS)
MACA:	Malaltia Avançada Crònica
MAP:	Metge d'Atenció Primària
MEG:	Malestar General

MC:	Metge Consultor
MME:	Mossos d'Esquadra
MPOC:	Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica
NEO:	Càncer o Neoplàsia
O2:	Oxigen
OBS:	Observació
OD:	Orientació Diagnòstica
PACI:	Pacient
PB:	Planta Baixa
PADES:	Programa d'Atenció Domiciliària Equips de Suport.
PCC:	Pacient Crònic Complex
PDA:	Pla de Decisions Anticipades
PIIC:	Pla d'Intervenció Individual Compartit
PIUC:	Pla Integral d'Urgències de Catalunya
PL:	Polícia Local
POL IND:	Polígon industrial
PTC:	Pèrdua Transitòria del Coneixement
RCP:	Reanimació Cardiopulmonar.
RESI:	Residència
RX:	Radiografia
SAT:	Saturació
SISCAT:	Sistema Integral de Salut de Catalunya (anteriorment conegut com
XHUP:	Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública)
SMU:	Metge d' Atenció Continuada domiciliari (també conegut com Charlie)
SUVEC:	Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya
SVA:	Suport Vital Avançat.
SVB:	Suport Vital Bàsic.
TA:	Tensió Arterial
TASS:	Teleassistència
TCA:	Trastorn de la Conducta Alimentària
TCE:	Traumatisme Cranio-Encefàlic.
TS:	Transport Sanitari
TSNU:	Transport Sanitari No Urgent
TSU:	Transport Sanitari Urgent
UCIES:	Urgències
USVB:	Unitat Suport Vital Bàsic
USVAi:	Unitat Suport Vital Avançat (amb infermeria)

USVAm:	Unitat Suport Vital Avançat (amb metge)
VM:	Valora Metge-essa.
VI:	Valora Infermeria
VIH:	Virus Immunodeficiència Humana (SIDA)
VP:	Via Pública
VPH:	Virus Papil·loma Humà
VPS:	Valora Personal Sanitari

9 ANNEXOS

9.1 Annex– Guia de bones pràctiques per a gestor/a d'emergència

Per realitzar una trucada efectiva i correctament gestionada el/la gestor/a ha de tenir en compte les següents especificacions:

- La llengua vehicular del tot el servei és el català (oral i escrita).
- Al camp 'A', el/la gestor/a sempre ha d'escriure:
 - En majúscules per diferenciar-nos de les minúscules amb les que escriu només personal sanitari.
 - Sense faltes ortogràfiques, gramaticals o lèxiques.
 - Només es recull la informació rellevant que ens indiqui l'alertant o bé Central 112.
- S'ha d'utilitzar un llenguatge professional, correcte, formal, precís, parlant sempre en present i amb cortesia (tractar sempre a l'alertant / usuari de vostè).
- S'ha d'evitar paraules i expressions negatives o poc professionals:
 - Expressions de massa confiança amb l'alertant / usuari: cregui'm, entre vostè i jo, li asseguro que...
 - Expressions agressives: no té raó, és mentida...
 - Tics verbals: val, miri, bueno, perfecte, molt bé...
 - Expressions negatives: no, de cap manera, res, mai...
 - Expressions vacil·lants: crec que, potser, no sé...
 - Expressions negres: problema, retard, dificultat, risc, inconvenient...
 - Utilització d'argots vulgars o massa tècnics.
- S'ha d'utilitzar un to de veu adequat (que tranquil·litzi i doni confiança a l'alertant).
- S'ha de fer servir una bona entonació i articulació de les paraules. És a dir, parlar amb un to de veu càlid, segur, calmat i amable. A més, s'ha de vocalitzar correctament les paraules i tenir cura de la velocitat amb la que parlem.
- Si és fa ús del silenci tenir en compte:

- Fer ús d' un SILENCI POSITIU on escoltem a l'usuari i li acompanyem amb paraules o sons que faci saber a l'alertant que li estem escoltant. I si fem esperar a l'usuari, explicar-li les raons per les quals el fem esperar.
- Evitar l'ús del SILENCI NEGATIU on no acompanyem la conversa amb paraules o senyals d'escolta; on no expliquem a l'usuari per què el fem esperar; on es perllonga el temps sense mantenir el contacte amb l'alertant, etc.
- S'ha de fer ESCOLTA ACTIVA al llarg de tota la trucada; i per fer una bona escolta activa el/la gestor/a ha de:
 - Concentrar-se i ser conscient de l'altre persona que té en línia, deixant de costat tota distracció que pot tenir.
 - Preguntar-se si realment entén la necessitat de l'usuari.
 - Resumir els punts més importants.
 - Confirmar amb l'alertant el contingut del missatge; és a dir, donar un *feedback* a l'alertant.
- A l'hora d'interrogar a l'alertant només s'han de fer les preguntes necessàries que ens marca el guió de la trucada (general i de transports sanitaris) sense caure en fer preguntes innecessàries. Per tal de fer això últim, s'ha de tenir molt en compte el guió de les trucades.

9.2 GUIÓ GENERAL DE TRUCADES:

Presentació:

Origen alerta 112 fórmula: *"061 digui'm"*

Origen alerta 061 fórmula:

De 06-12 h.: *"Bon dia, l'atén ... (nom del gestor) en què el puc ajudar?"*

De 12-20 h.: *"Bona tarda, l'atén ... (nom del gestor) en què el puc ajudar?"*

De 20-06 h.: *"Bona nit, l'atén ... (nom del gestor) en què el puc ajudar?"*

Origen alerta ICO 24h. : *"ICO 061 l'atén... (nom del gestor) en què el puc ajudar?"*

Origen interhospitalaris 902335033: *"Interhospitalaris SEM, Bon dia - Bona tarda - Bona nit."*

Origen alerta CRC: *"061 digui'm"*

- *El seu telèfon és...* (re formulem el que apareix en pantalla)

- *Es per vostè o per un familiar?* (anotem tipus d'alertant).

- *En quin Municipi es troba l'afectat?* → no especificar l'afectat comportaria un error de localització, doncs l'alertant ens donaria el seu Municipi que no sempre és el mateix que el on es troba l'afectat.

o Si és capital de província, preguntar si és a la ciutat → *"És Girona ciutat?"*

- *A quin carrer? Quin número?*

- SIG → confirmem amb el mapa la localització zonificada.

- *Què li passa al pacient ara mateix?* Per tal de saber si hem de demanar dades de filiació o no (DNI, CIP...).

- A partir d'aquí, segons l'Omega que classifiquem farem les preguntes corresponents. No allargarem en cap cas la trucada.

Per exemple: Tenim un etílic a lloc públic i per protocol li preguntarem:

Respira amb normalitat? Si li parla li contesta? (estat de consciència i respiració).

- Llegir TEXTUALMENT les indicacions de SITREM segons la nostra classificació:

- Hauria de trucar al seu Centre d'Atenció Primària. Li facilito el telèfon?
- No pengi parlarà amb personal sanitari.
- Li enviem una ambulància.

Per agilitzar la trucada hem de demanar com a primera opció el DNI i com a segona el CIP, en tots els casos on el procediment requereixi les dades de filiació de l'afectat. Excepte al transport sanitari on demanarem el CIP com a primera opció.

Sempre confirmarem les dades que carrega des de la RCA abans de copiar-les – gravar-les a els camps corresponents. Si son errònies tornarem a demanar-les per recollir correctament la informació de filiació i si no validen, les agafarem manualment marcant les caselles desconegut.

GUIO DE TRUCADA D'ALERTANT MMEE, PL, BB:

- Confirmar telèfon i demanar extensió: *El telèfon de contacte és... És un telèfon directe o tenen una extensió?*

- Hem d'afegir la pregunta obligatòria: *Estan de camí o van cap al lloc?* I ho anotarem sempre al camp "A".

- Si no estan al lloc: *Tenen un telèfon de contacte d'algú que estigui al lloc?*

✓ Classificació Omega

Al SITREM, un cop tenim la localització i les dades de filiació corresponents, el següent pas essencial per poder donar la resposta més adient a la demanda de l'alertant / ciutadà és la Classificació Omega, la qual es desglossa en:

- Accident / Traumatisme
- Atenció No Presencial No Urgent
- CRC (Columna de Rescat Cardíac)
- Informativa Ampla
- Informativa Breu
- Malaltia Domicili
- Malaltia Lloc Públic
- Transport Sanitari
- Consultoria pediàtrica
- Consultoria ICO-061

Segons el motiu de l'alerta escollirem una d'aquestes opcions.

GUIO DE TRUCADA TRANSPORTS SANITARIS

L'entrada d'alerta es realitza de manera automàtica. Simultàniament, escoltem l'alertant i apareix en el programa la carta de 'Nova Trucada'. Si això no aparegués de manera automàtica, tenim la possibilitat de fer-ho manualment mitjançant el botó "Nova Trucada".

La recepció de la trucada és discriminada per l'origen:

- Origen alerta 112: "*061 digui'm*".
- Origen alerta ICO 24h (932607746): "*ICO 061, li atén [nom del gestor], en què el puc ajudar?*"
- Origen alerta interhospitalari (902335033): "*Interhospitalaris SEM, Bon dia - Bona tarda - Bona nit.*"
- Origen alerta 061: "*Bon dia-Bona tarda-Bona nit, li atén [nom del gestor] en què el puc ajudar?*"

Per a accedir a les dades del alertant dins de la carta de "Nova Trucada", s'ha de seleccionar el tipus d'alertant usant el desplegable, escrivint el nom o el seu número identificació. Per exemple:

Centre d'Atenció Primària: Podem trobar-ho desplegant la barra de tipologia d'alertant, escrivint 'Centre ...' o marcant el número 06.

Una vegada identificat l'origen de la trucada i el seu alertant corresponent, hem de confirmar el telèfon del lloc i, seguidament, fer ús del botó "M": identifiquem quin personal sanitari (doctor/a, infermer/a) realitza la demanda de transport sanitari i a quin servei pertany. Per exemple:

DOCTOR: Fernández
SERVEI: Urgències

A continuació, hem de realitzar l'interrogatori de caràcter obligatori i, simultàniament, emplenar totes les dades al programa:

- *A quin municipi es troba l'afectat?*
- *Des de quin centre sanitari truca?* o bé *En quina direcció es troba l'afectat?*
- *On es troba el pacient dins del centre?* (Anotant la resposta a complement d'adreça)
- *Vostè té extensió?* (Anotant la resposta a complement d'adreça)
- *Em pot facilitar la Targeta Sanitària del pacient (CIP) o el D.N.I.?*

Una vegada emplenats totes aquestes dades, procedim a la classificació del Omega, desglossant així la tipologia de trucada. A partir d'aquí s'ha de classificar segons el tipus de trasllat que sigui ('Tipus de Trasllat):

- Identificar si és un Transport Secundari o Transport Sanitari Urgent.

- Descartar si és un codi IAM/ICTUS o no. En cas que sigui un codi, seguir el procediment d'acord al CODI.
- Demanar Diagnòstic i anotar al camp A*
- Recordar les frases d'acomiadament segons tipologia de recurs assignat.

*Si el diagnòstic es de caire respiratori i el transport es un SVB realitzarem el següent interrogatori:

- *Em pot facilitar la Saturació d'Oxigen Basal? I anotar al camp A: SAT + VALOR*
- *Em pot facilitar la freqüència respiratòria? I anotar al camp A: FR + VALOR*
- *Em pot confirmar si cal suport d'oxigen? I anotar al camp A: Si cal / No cal suport d'oxigen.*

Una vegada recollida la informació utilitzarem la frase d'acomiadament: ***“Una ambulància anirà cap el lloc”.****